



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN MARET
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab 1 Pendahuluan 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

 A. Visi 2

 B. Misi 2

 C. Motto 2

 D. 7 Nilai Budi Utama 2

 E. Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

 A. Profil Pelayanan 5

 a. Kunjungan Pasien Rawat Inap 5

 b. Kunjungan Pasien Rawat Jalan 5

 c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA 6

 d. Profil Tempat Tidur Profil Tempat Tidur 6

 B. Profil Pelayanan Antrian Online 7

 a. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online bulan Terakhir 7

 b. Analisa 8

 C. Indikator Kerja 9

 a. BOR, LOS, BTO dan TOI 2024 (Januari – bulan terakhir) 9

 b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI 10

 c. Klaim Pending 10

 a) Analisis 10

 b) Tindak Lanjut 10

 D. Data Mutu/Keselamatan Pasien 10

 E. Permasalahan Rumah Sakit 41

 F. Profil SDM 45

 a. Komposisi dan Distribusi SDM 45

 b. Update STR/SIP 50

 G. Kemajuan Piutang 51

 a. Data Piutang yang Belum Terbayar 51

 b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang 51

 c. Update IKS 53

 H. Program Nasional 64

 a. PONEK 64

 b. TB Dots 74

 c. HIV 83

 d. Stunting & Wasting 91

 e. KBRIS 101

Bab IV Data Utilitas Unit 104

 A. Pelayanan Medis 104

 a. Tabel Data Kamar Operasi 104

 b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan 105

c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap.....	108
d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)	111
B. Penunjang Medis	112
a. Tabel Data Laboratorium.....	112
b. Tabel Data Radiologi.....	113
c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	114
d. Tabel Data Laundry.....	115
e. Tabel Data CSSD.....	116
f. Tabel Data Instalasi Gizi	117
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	120
Bab VI Penutup.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Maret Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

A. VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

B. MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

C. MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

D. 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :

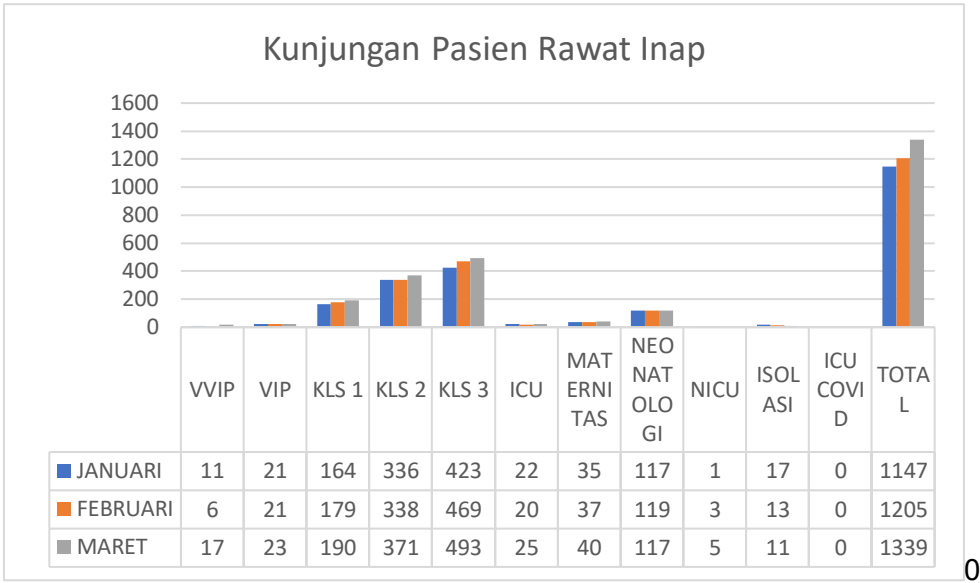
NO	JABATAN	NAMA	NO SK JABATAN	TANGGAL JABATAN
1	PLT Direktur RS Prima Husada	dr. Nur Mazidah	001.204/DPM/I-KEP/DIR/I/2024	1 Februari 2024
3	Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	1451/I-KEP/DIR/X/2020	1 November 2020
		Dwi Novianti, Amd.AK, S.Kes	397/I-KEP/DIR/V/2021	28 Mei 2021
4	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	002.4/DPM/I-KEP/DIR/II/2024	2 Februari 2024
5	PLT Kepala Bidang Penunjang Medis	Putri Indah Purnamasari, Amd. Keb	1153/I-KEP/DIR/XI/2023	13 November 2023
6	Kepala Bidang Umum dan Keuangan	drg. Endy Wira Pradana, MMRS	136.132/DPM/I-KEP/DIR/VI/2023	10 Juni 2023
7	Kepala Bidang Keperawatan	Ns. Very Susanto, S. Kep	974.1/I-KEP/DIR/X/2023	4 Oktober 2023
	Kepala Instalasi Rawat Inap	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP (K)	004.4/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
8	1) Kepala Ruang Rawat Inap 2C	Indah Maulhayati, S.Kep.Ns	006.4/I-KEP/DIR/I/2023	2 Januari 2023
	2) Kepala Ruang Rawat Inap 6A, 7A, 8A	Murwani Suryaning Sapartinah, S. Kep., Ns	428.56/I-KEP/DIR/VI/2021	22 Juni 2021
	3) Kepala Ruang Rawat Inap 3C	Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns	428.58/I-KEP/DIR/VI/2021	22 Juni 2021
	4) Kepala Ruang Rawat Inap 2A, 3A, 4A	Wahyuni, A.Md.Kep	296/I-KEP/DIR/III/2024	13 Maret 2024
	5) Kepala Ruang Rawat Inap 5C	Amilatul Kholifah, AMd. Kep	659/I-KEP/DIR/VII/2023	1 Juli 2023
	6) Kepala Ruang Rawat Inap Maternitas	Siti Zaimah, AMd.Keb	1196.7/I-KEP/DIR/VII/2022	26 Juli 2022
	7) Kepala Ruang Neonatologi	Dhora Putri Meryda, S.Kep.Ns	2272.4/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
9	Kepala Instalasi Kamar Operasi	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.16/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
	1) Kepala Ruang IKO	Siti Durotul Ibadiyah., S. Kep.,Ns	039.22/I-KEP/DIR/I/2018	2 Januari 2018
	Kepala Intensive Care Unit	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.14/I-KEP/DIR/2019	2 Januari 2019
10	1) Kepala Ruang ICU	Risma Indra Setiyani, S.Kep.,Ns	651/I-KEP/DIR/V/2022	26 Mei 2022
	PLT Kepala Instalasi Gawat Darurat	dr. Reza Muchlas Fauziansyah	161.1/I-KEP/DIR/II/2024	7 Februari 2024
11	1) Kepala Ruang IGD	Afni Nur Ainy, S.Kep.Ns	2272.3/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
	Kepala Instalasi Rawat Jalan	dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK	004.4.2/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
12	1) Kepala Ruang Rawat Jalan	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	2272.1/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
13	Kepala Instalasi Farmasi	Apt. Asharul Fahrizi	185/DPM/I-KEP/DIR/IV/2024	1 April 2024
14	Kepala Instalasi Rekam Medik	Rina Tri Wahyuni, AMd.RMIK	2272.6/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
	Kepala Instalasi Laboratorium	dr. Ari Putriani, Sp. PK	004.25/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019

15	1) Kepala Unit Laboratorium	Yoga Eka Ramadhani Ariwa, AMd.AK	1345.4/I-KEP/DIR/VIII/2022	26 Agustus 2022
16	Kepala Instalasi Radiologi	dr. Agung Setyawan, Sp.Rad	401/I-KEP/DIR/VI/2019	17 Juli 2020
	1) Kepala Unit Radiologi	Ayu Bintang Tinara, Amd. Rad	004.28/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
17	Kepala Unit Sterilisasi (CSSD) & Laundry	Ahmad Taufan Fauzi, Amd. Kep	1520.1/KEP/DIR/II/2020	27 November 2020
18	Kepala Instalasi Gizi	-	-	-
	1) Kepala Unit Gizi	Veni Lestari Puri Purnami., Amd. Gz	004.30/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
19	Kepala Bidang Umum	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS		
	1) Kesekretariatan	Maheza Yudistiranti,S.AP	1255.3/I-KEP/DIR/XII/2023	01 Desember 2023
	2) Kepala Unit SDM & Diklat	-	-	-
	3) Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi	Novi Ratnasari, S.E	103.1/I-KEP/DIR/II/2021	26 Februari 2021
	4) Kepala Unit SIMRS & IT	Ramadhian Anshari, S.Kom	153.14/I-KEP/DIR/III/2021	26 Maret 2021
	5) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	M. Arifin	240/I-KEP/DIR/II/2024	1 Maret 2024
	6) Kepala Unit Security & Parkir	M. Rizal., S.E	004.40/I-KEP/DIR/II/2019	2 Januari 2019
	7) Kepala Unit Umum Cleaning Service	Erik Ardinata	104.1/I-KEP/DIR/II/2023	1 Januari 2023
	8) Kepala Unit Asuransi Centre	Nur Rizkiah Amalia	1560/I-KEP/DIR/X/2022	5 Oktober 2022
20	Ketua Komite Medis	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	1185/I-KEP/DIR/VII/2022	25 Juli 2022
21	Ketua Komite Keperawatan	Artika Wulandari, S.Kep., Ns	839/I-KEP/DIR/VIII/2023	14 Agustus 2023
22	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz	116/I-KEP/DIR/II/2023	6 Februari 2023
23	Ketua Komite PPI	dr. Aida Musyarofah, Sp.OG	-	-
	1) IPCN	Sherly Rosita, S.Kep.,Ns	068.2/I-KEP/DIR/II/2020	3 Februari 2020
24	Ketua Komite Etik Rumah Sakit	dr. Ari Putriani, Sp.PK	001.4/I-KEP/DIR/I/2022	4 Agustus 2022
25	Ketua Komite Farmasi & Terapi	dr. Sadi Hariono, MMRS	175.3/I-KEP/DIR/II/2022	1 Februari 2022-
26	Ketua Tim P2K3RS		-	-
27	Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A.,M.Biomed	001.5/I-KEP/DIR/I/2022	1 Januari 2022

BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

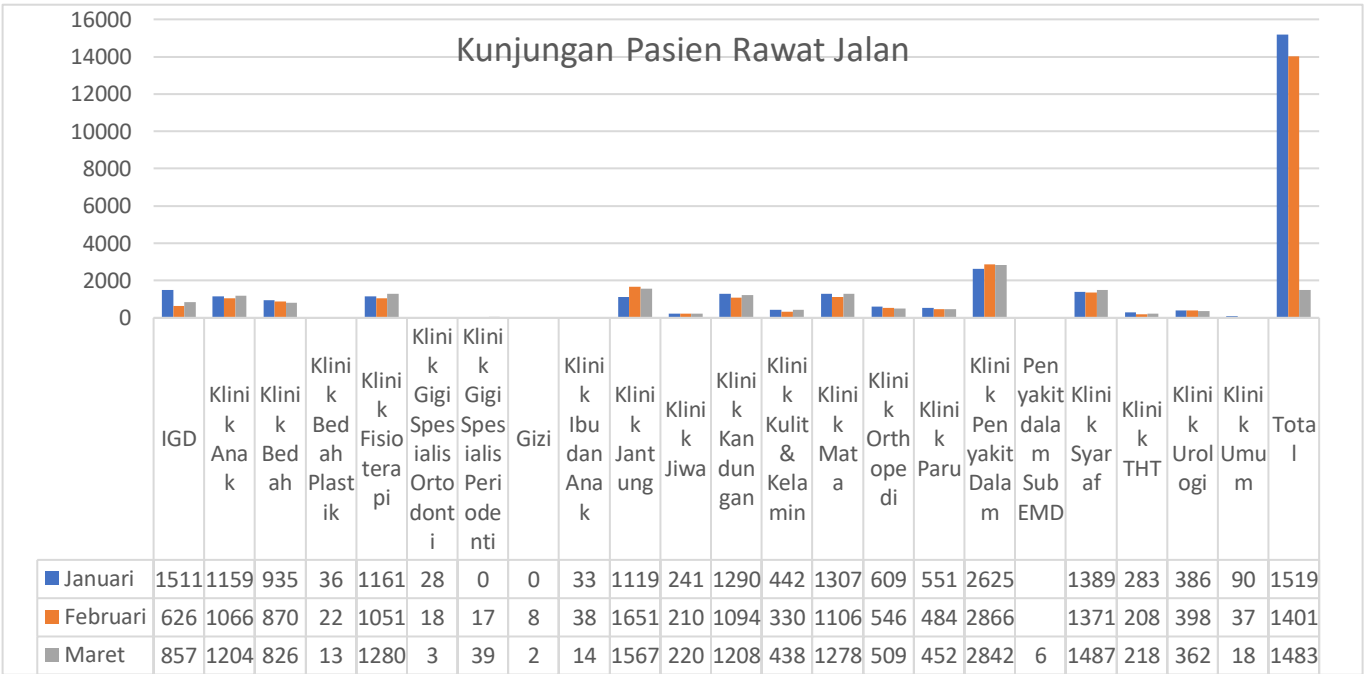
A. Profil Pelayanan

a. Kunjungan Pasien Rawat Inap



Berdasarkan pada grafik diatas, kunjungan pasien rawat inap di RS Prima Husada Malang mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Dimana pasien rawat inap pada bulan februari di angka 1205 dan mengalami kenaikan di bulan Maret di angka 1339. Kunjungan pasien rawat inap di bulan Februari mengalami kenaikan sebesar 10% dari bulan sebelumnya.

b. Kunjungan Pasien Rawat Jalan



Berdasarkan grafik kunjungan diatas pasien rawat jalan yang berkunjung ke RS Prima Husada Malang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kunjungan pasien rawat jalan pada bulan februari sebesar 14.081 kunjungan, bulan Maret sebesar 14.843 Dimana kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 5,1% dari jumlah kunjungan bulan sebelumnya. Kunjungan pasien di Poli Penyakit Dalam masih menduduki kunjungan paling banyak dari seluruh poli yang ada di RS Prima Husada Malang.

c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA

Plan	1. Mempertahankan tren peningkatan pasien rawat inap 2. Meningkatkan kunjungan Poli dengan menambah slot jadwal dokter spesialis 3. Menambah dokter spesialis agar slot terpenuhi 4. Melakukan penertiban dan evaluasi jadwal praktek dokter di Poli 5. Menjaring lebih banyak pasien lewat promosi dan marketing melalui media online 6. Mengaplikasikan daftar kehadiran dokter praktek di Poli dalam SIMRS yang terintegrasi dengan ERM 7. Mempercepat alur penerimaan rujukan luar 8. Meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi complain 9. Menjalin Kerjasama dan hubungan yang baik dengan Perusahaan dan faskes Tingkat 1
Do	1. Mengurangi jumlah rujukan ke luar dengan meningkatkan komunikasi pada DPJP 2. Publikasi info rekrutmen dokter spesialis via WA dan IG 3. Meningkatkan kinerja humas dan marketing ke perusahaan, FKTP dan BPM untuk meningkatkan jumlah pasien 4. Koordinasi dengan DPJP untuk penambahan jadwal dokter praktek 5. Mengevaluasi keterlambatan DPJP 6. Mengevaluasi respond time rujukan yang diterima
Study	1. Keterlambatan dan ketidakhadiran dokter di RS akan mempengaruhi kinerja pelayanan di RS 2. Komplain pasien yang masuk disebabkan karena pasien merasa pelayanan IGD lambat, setelah ditelusur dokter IGD sudah bekerja sesuai triage tetapi jumlah pasien yang tinggi dapat menyebabkan pasien dengan triage hijau akan lebih lama untuk ditangani
Action	1. Melakukan open recruitment dokter umum untuk meningkatkan pelayanan IGD 2. Membuka layanan poliklinik eksekutif untuk meningkatkan jumlah pasien 3. Memberikan pelayanan yang baik kepada pasien misalnya melakukan full service pada pasien JKK untuk selalu menghubungi pihak Perusahaan terkait kondisi pasien agar bisa meningkatkan kepuasan pasien dan Perusahaan

d. Profil Tempat Tidur

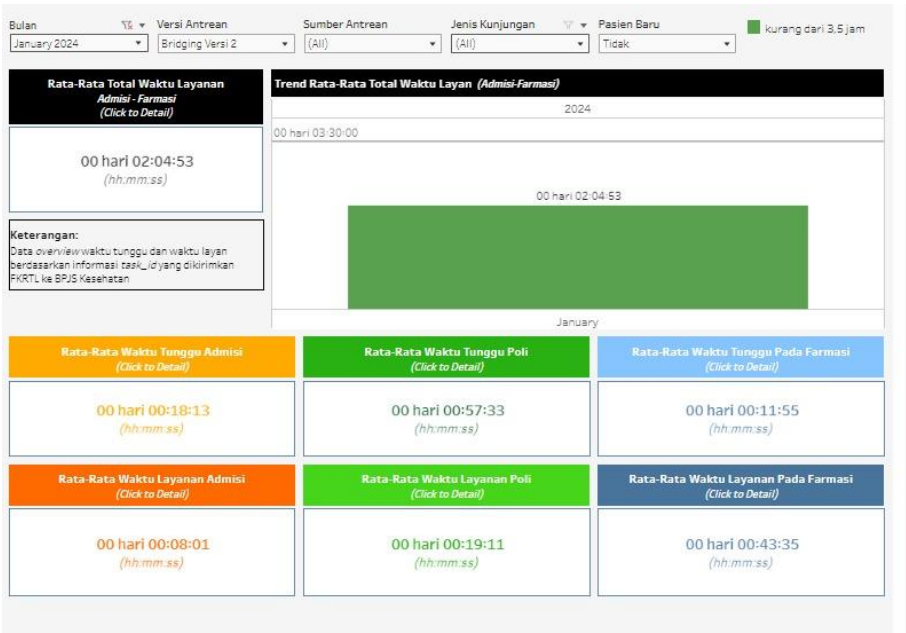
NO	JENIS KELAS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kelas VVIP	3	2%
2	Kelas VIP	3	2%
3	Kelas 1	17	12%
4	Kelas 2	38	28%
5	Kelas 3	49	35%
6	Perawatan Intensive		
	ICU Dengan Ventilator	8	6%
7	HCU	2	1%
8	NICU	6	4%
9	Isolasi		
	Isolasi Tekanan Negatif	9	10%
	Isolasi <i>Immunocompromise</i>	5	
TOTAL		140	100%

Nb : SK No 701/KEP/DIR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Tempat Tidur untuk Pelayanan Asuhan Pasien

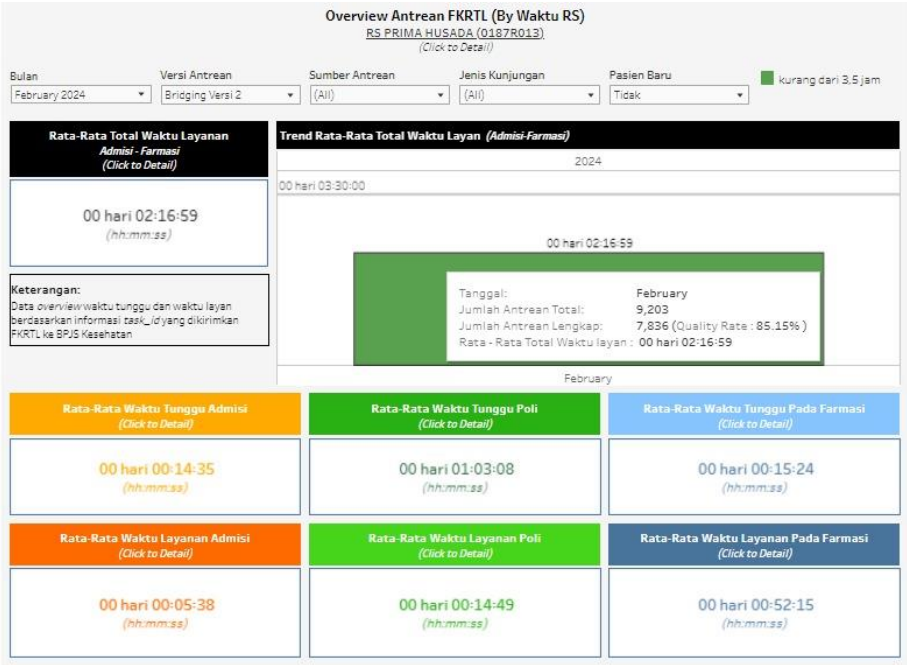
B. Profil Pelayanan Antrian Online

1. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online

Januari 2024



Februari 2024



Rata-Rata Total Waktu Layanan

Admisi - Farmasi

(Click to Detail)

00 hari 02:16:59

(hh:mm:ss)

Keterangan:

Data overview waktu tunggu dan waktu layanan berdasarkan informasi task_id yang dikirimkan FKRTL ke BPJS Kesehatan

Trend Rata-Rata Total Waktu Layan (Admisi-Farmasi)

2024

00 hari 03:30:00

00 hari 02:16:59

February

Tanggal:

February

Jumlah Antrean Total:

9,203

Jumlah Antrean Lengkap:

7,836 (Quality Rate : 85.15%)

Rata - Rata Total Waktu layan :

00 hari 02:16:59

Rata-Rata Waktu Tunggu Admisi

(Click to Detail)

00 hari 00:14:35

(hh:mm:ss)

Rata-Rata Waktu Tunggu Poli

(Click to Detail)

00 hari 01:03:08

(hh:mm:ss)

Rata-Rata Waktu Tunggu Pada Farmasi

(Click to Detail)

00 hari 00:15:24

(hh:mm:ss)

Rata-Rata Waktu Layanan Admisi

(Click to Detail)

00 hari 00:05:38

(hh:mm:ss)

Rata-Rata Waktu Layanan Poli

(Click to Detail)

00 hari 00:14:49

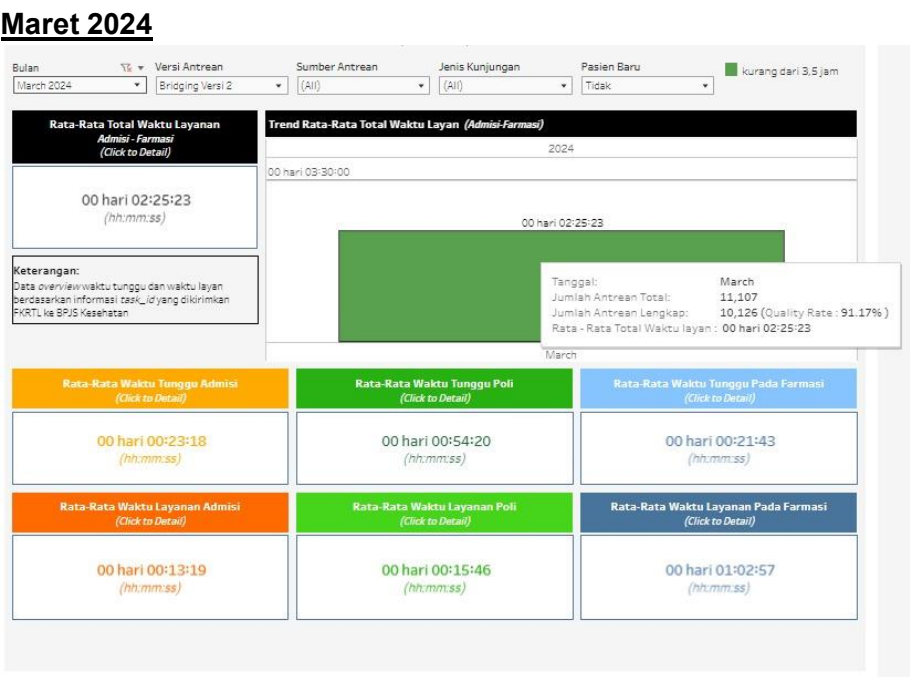
(hh:mm:ss)

Rata-Rata Waktu Layanan Pada Farmasi

(Click to Detail)

00 hari 00:52:15

(hh:mm:ss)

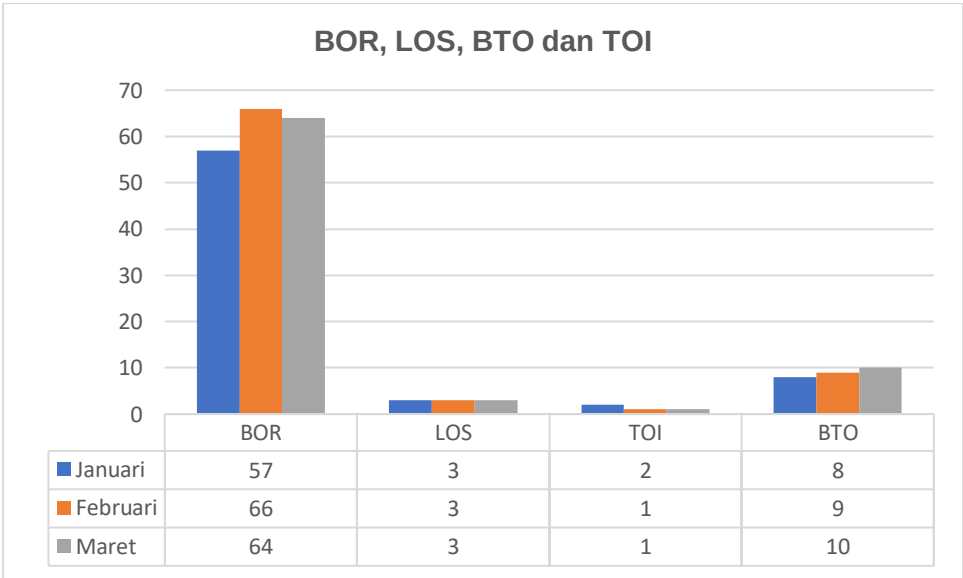


NO	JENIS	OKT '23	NOV '23	DES '23	JAN '24	FEB '24	MAR 24
1	Jumlah SEP RJTL Terbit	9.006	8.425	8.525	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
2	Bridging	4.884	5.269	5.280	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
3	Mobile JKN A	342	2.691	2.985	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
4	All Sumber	5.226	7.960	8.265	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
5	%	58%	94%	97%	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS

Analisa :
-

Plan	Menganalisa perbaikan data quality rate
Do	Kordinasi dengan programmer terkait hasil bulan Desember sebagai pelaporan hasil perbaikan
Study	Data bulan Oktober sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki mulai diperbaiki.
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> bulan Desember 3. Supervisi kabid

C. Indikator Kinerja
a. BOR, LOS, BTO dan TOI



b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI

Tingkat hunian meningkat dibanding 2 bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, BOR RS Prima Husada Malang mengalami penurunan sebesar 3% tetapi masih memenuhi standard. ALOS di RS Prima Husada Malang tetap dalam 3 (tiga) bulan terakhir yaitu di angka 3, BTO meningkat sebanyak 10 kali dari bulan sebelumnya dan TOI tetap pada 1 hari.

Analisa :

Terdapat peningkatan jumlah pasien rawat inap tetapi BOR mengalami penurunan

c. Klaim Pending

a) Analisis

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Indikasi dilakukan tindakan USG	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Konfirmasi penggunaan kode tindakan 83.39 (<i>Excision of lesion of other soft tissue</i>) pada tindakan Eksisi diminta menggunakan kode 86.22 <i>Excisional debridement of wound, infection, or burn</i>	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
3.	Indikasi pasien rawat inap dengan LOS < 2hari pada pasien tindakan operasi	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
4.	Konfirmasi tata laksana spesifik diagnosa E87.1 (Hyponatremi) , E83 (Hipolakemi) dan penggunaan diagnosa utama GERD	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

D. Data Mutu / Keselamatan Pasien

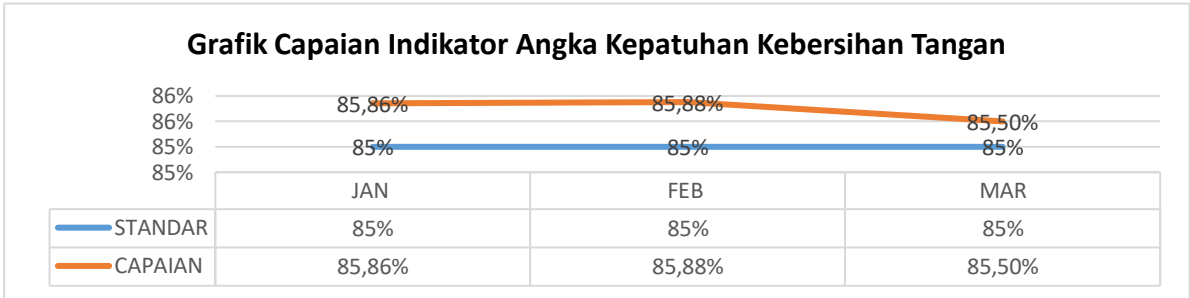
a. Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL					
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%

9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

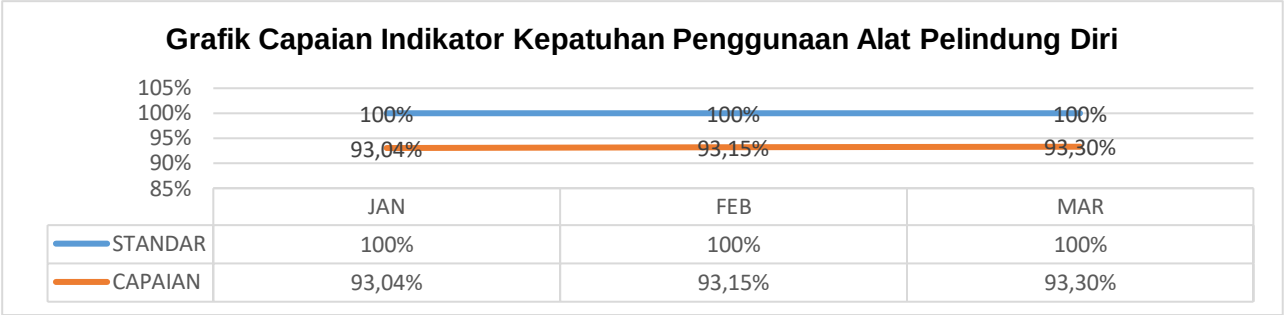


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,5%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.Mengingatkn perawat atau nakes	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.		
--	--	--	--	--	--

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

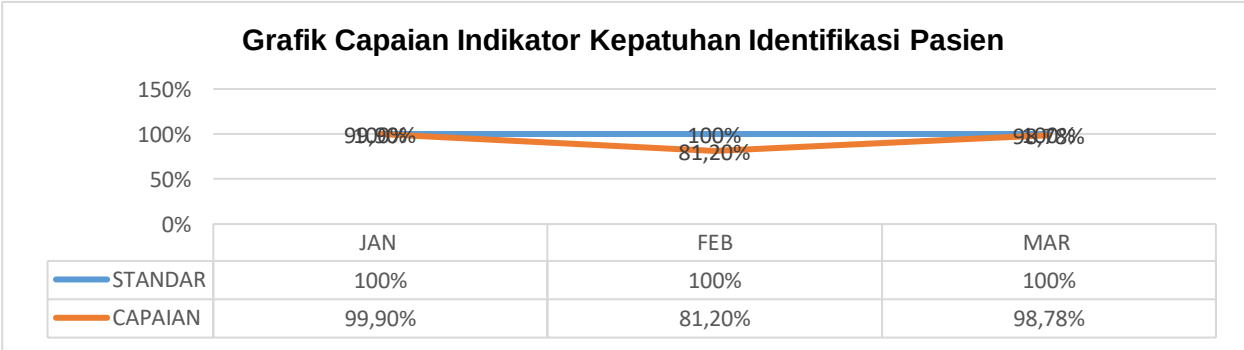


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,3% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			ketidak patuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. 5. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.		
--	--	--	---	--	--

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

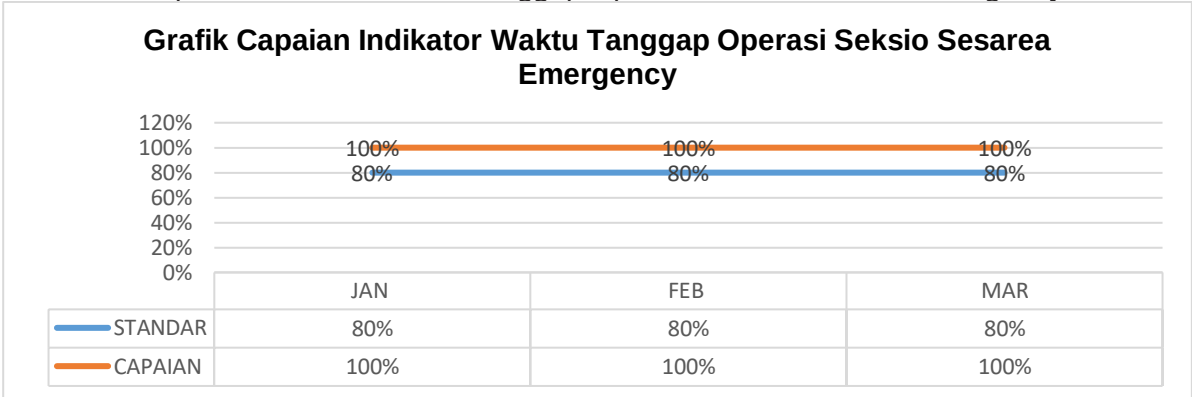
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Bahkan dapat diketahui, capaian menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

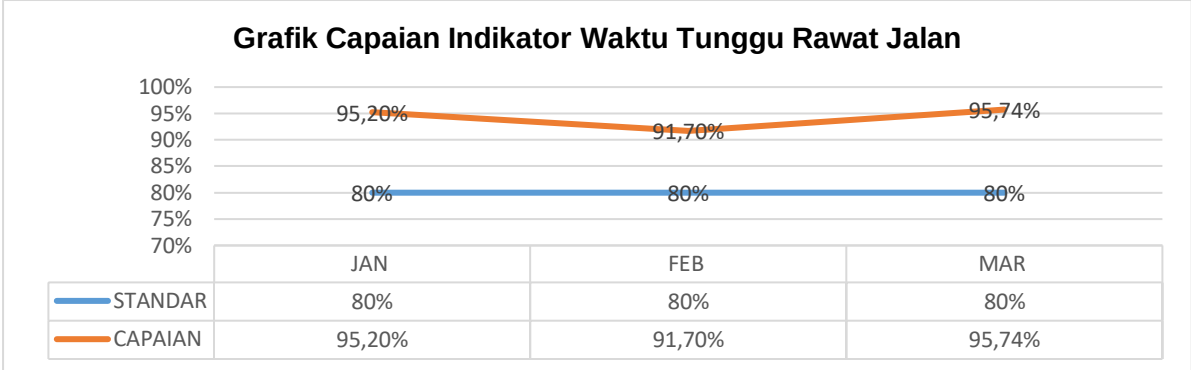


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

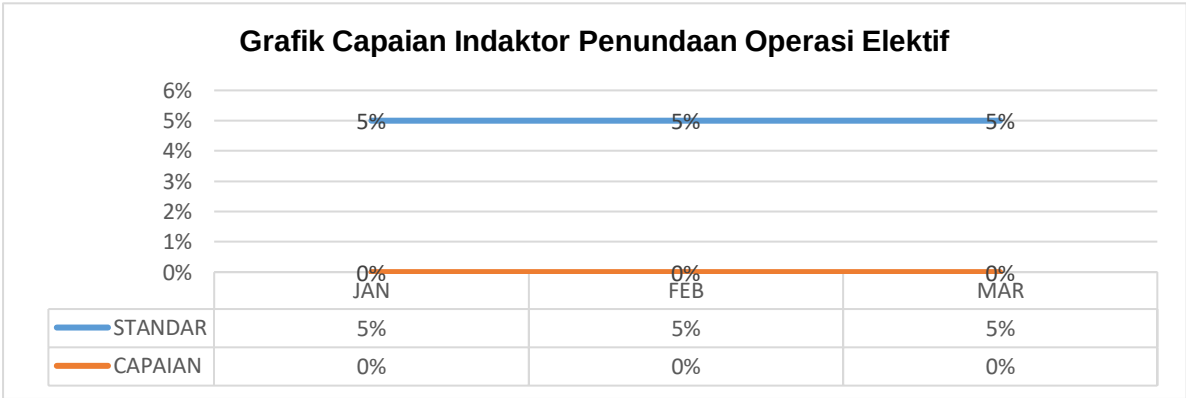
Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 capaian indikator waktu tunggu rawat jalan telah mencapai standart. Pada bulan Februari tahun 2024 capaian masih mencapai standart, meskipun capaian menurun menjadi 91,7% dari bulan sebelumnya 95,20%. Pada bulan Maret tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 95.74%.

6. Penundaan Operasi Elektif

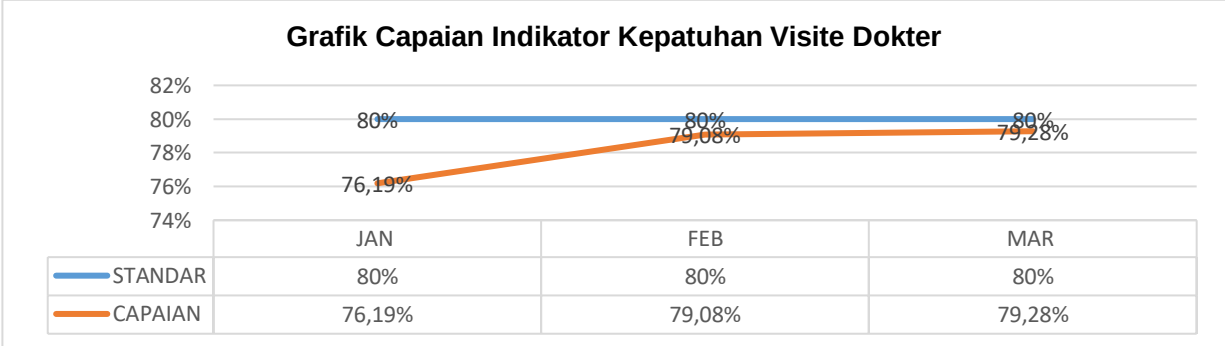
Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Maret tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

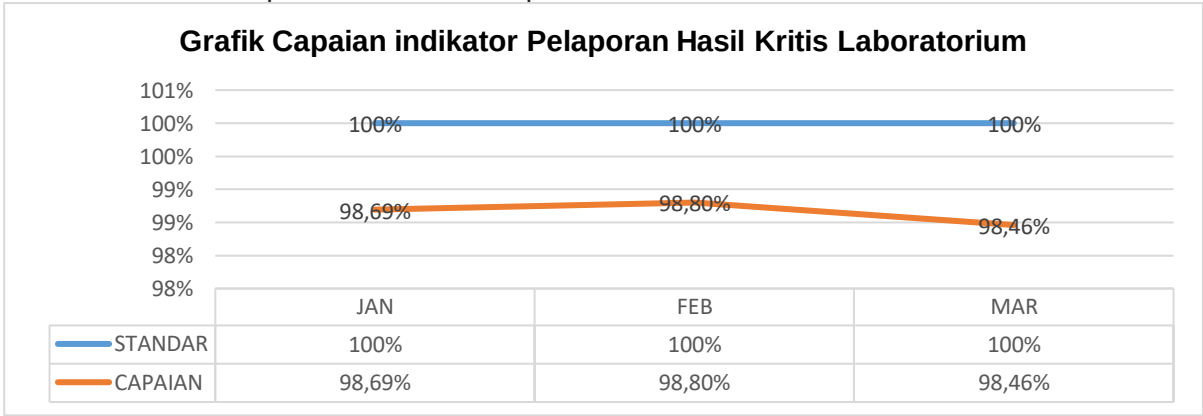
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Fiona Sp.A, dr. Zora Sp.PD Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Zaki Sp.B, dr. Syahrir Sp.S				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

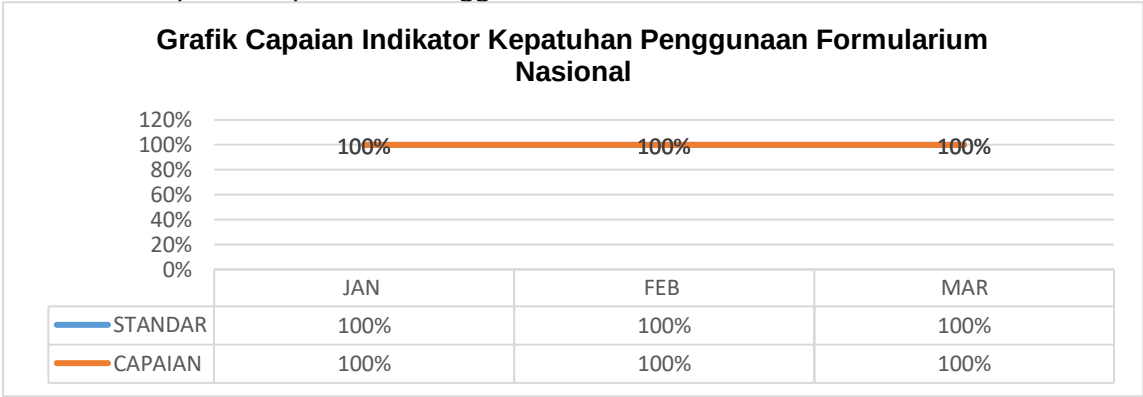


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan
--	--	--	---	--	------------

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

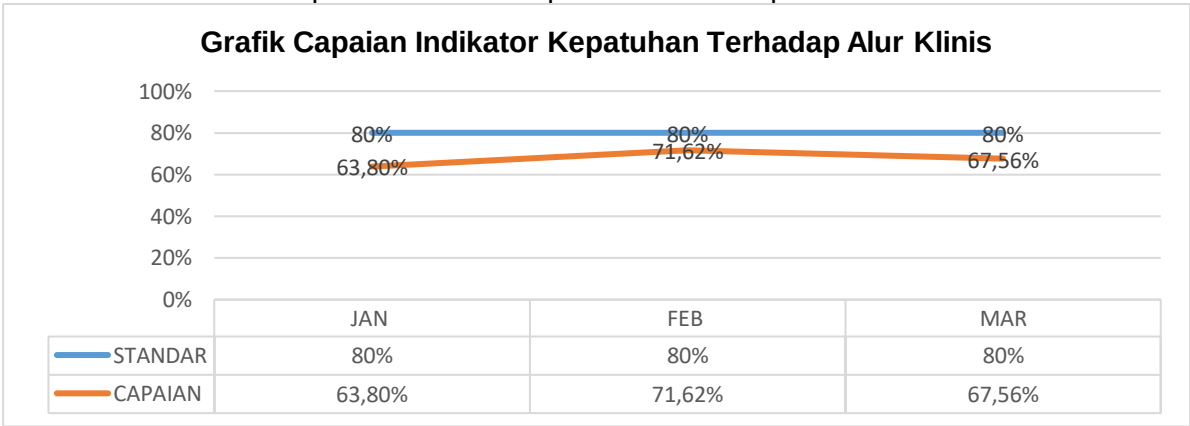
Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisa Capaian :
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Maret Tahun 2024 telah mencapai standart.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis

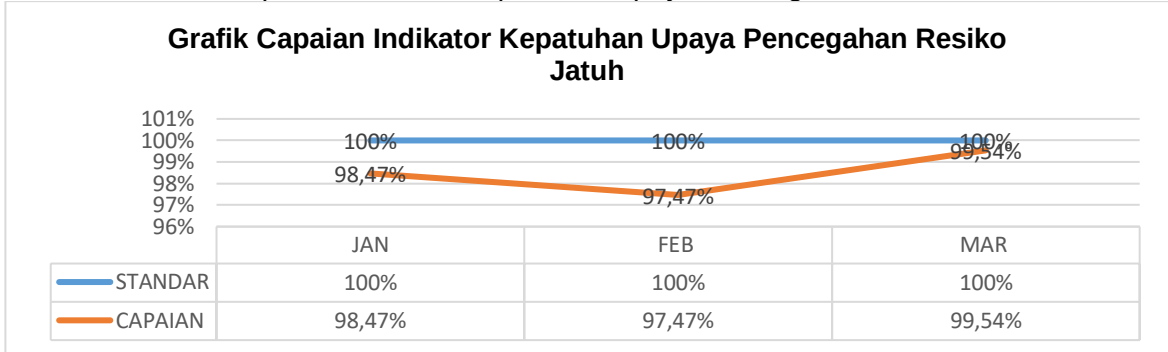


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat

	dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

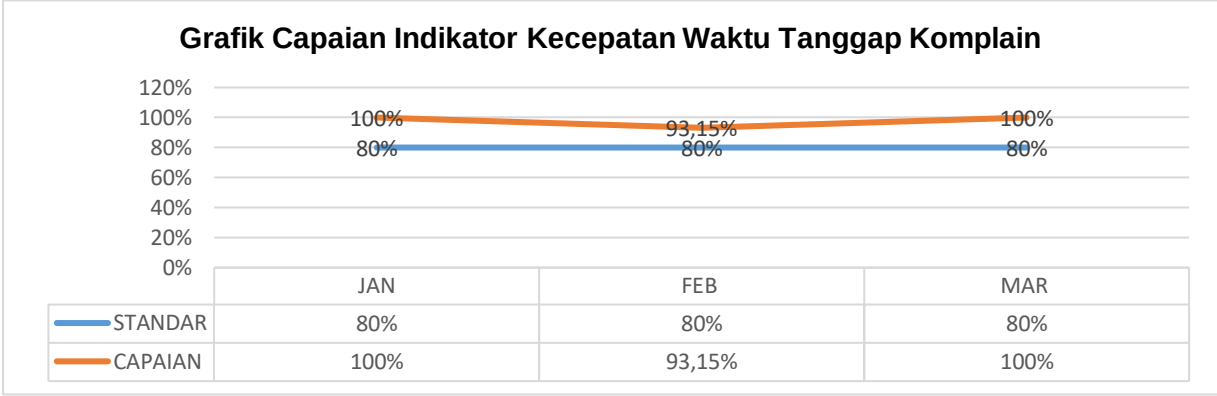


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

			bukti bahwa edukasi telah dilakukan.		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

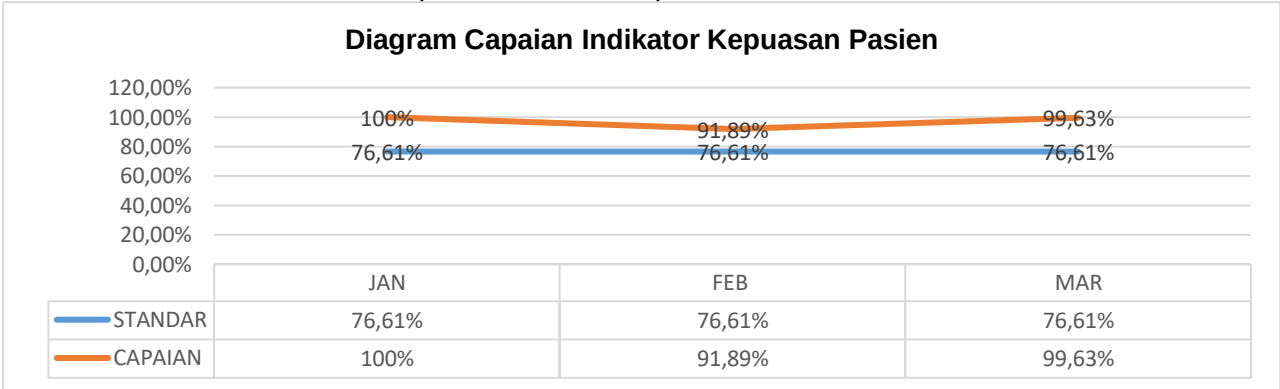
Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap kompalin pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret capaian kembali meningkat menjadi 100%.

13. Kepuasan Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa capaian indicator kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart meskipun capaian menurun di bulan Februari dan kembali meningkat di bulan Maret. Pada bulan Februari dan Maret capaian belum maksimal 100% karena masih ditemukan keluhan pasien terkait sarana dan prasarana dan juga keramahan petugas.

b. Indikator Mutu Prioritas

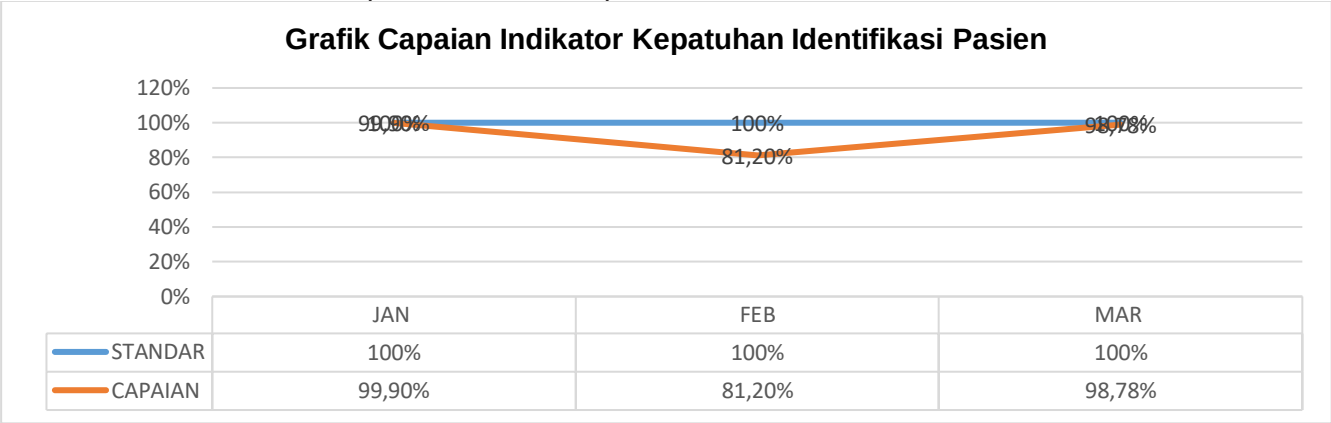
1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0

3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%

1) Kepatuhan Identifikasi Pasien

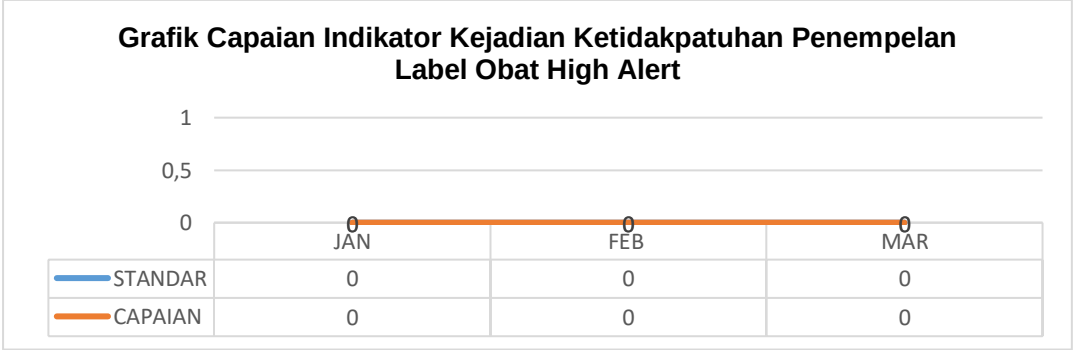
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	a) Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan b) Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien c) Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Bahkan dapat diketahui, capaian menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervise berjenjang pada petugas unit. 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

2) Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



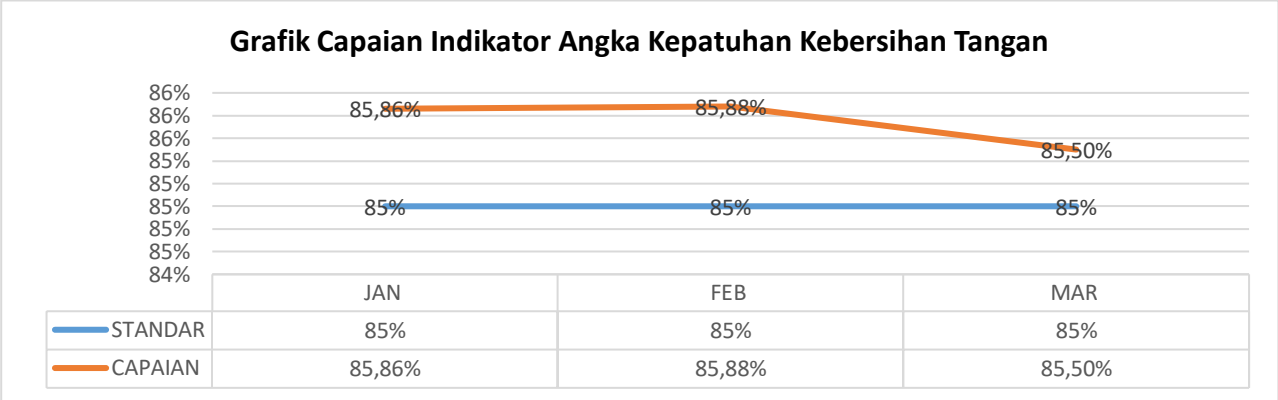
Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart.

3) Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi
Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis:
Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart.

4) Kepatuhan Kebersihan Tangan
Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

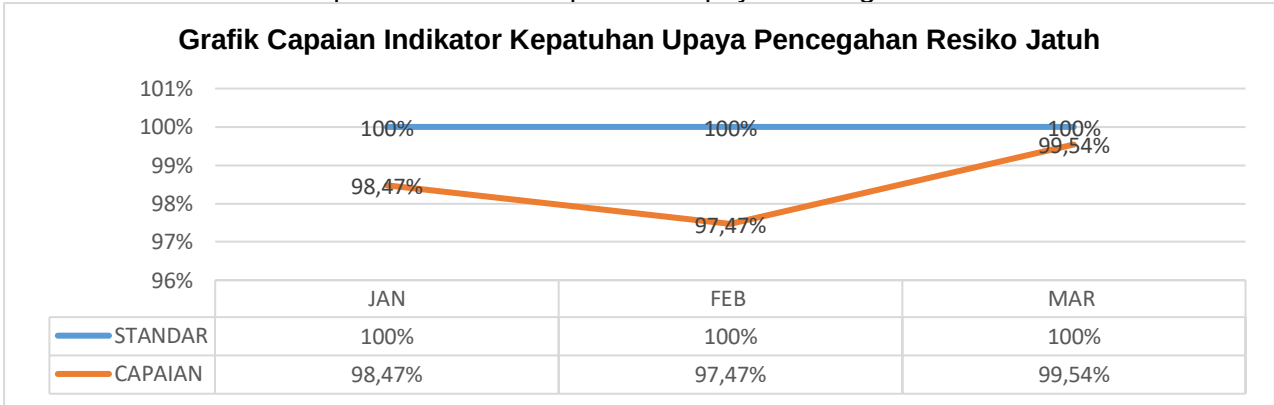


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	a) Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. b) Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. c) Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. d) Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. e) Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,88%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan
---------------------------------	---	---	---	---	------------

5) Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



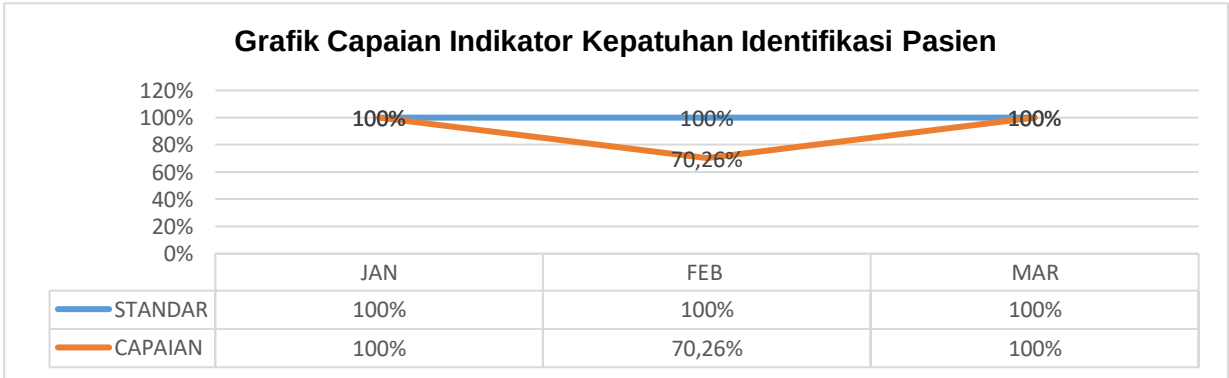
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

c. Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

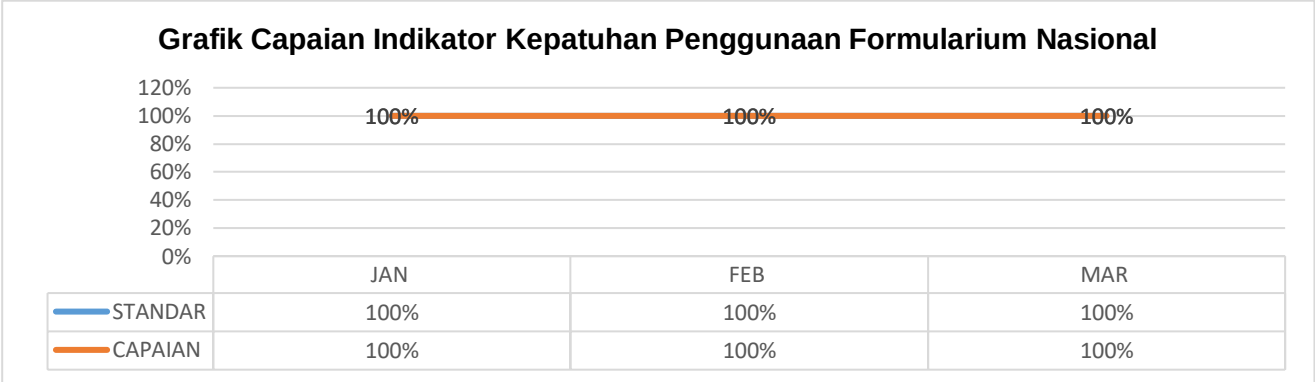


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari dan Maret capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang

	tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

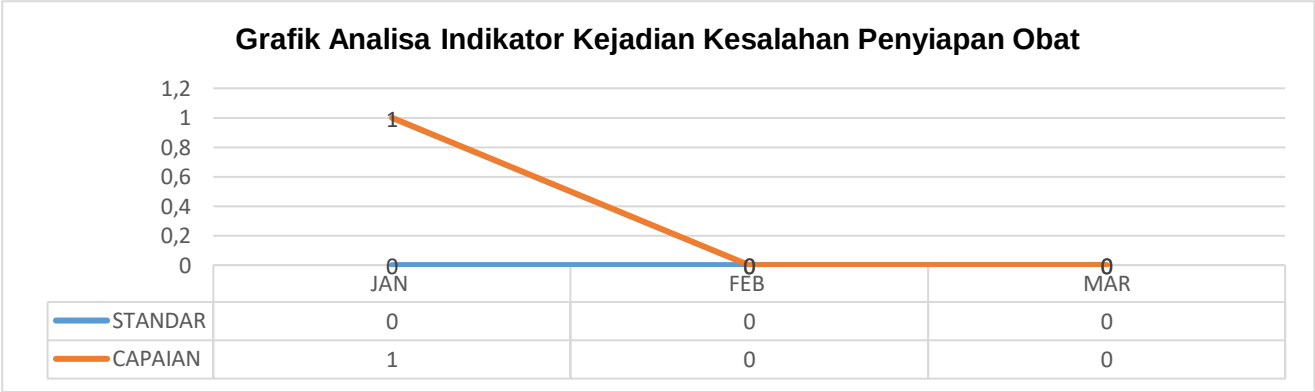


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart.

3. Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

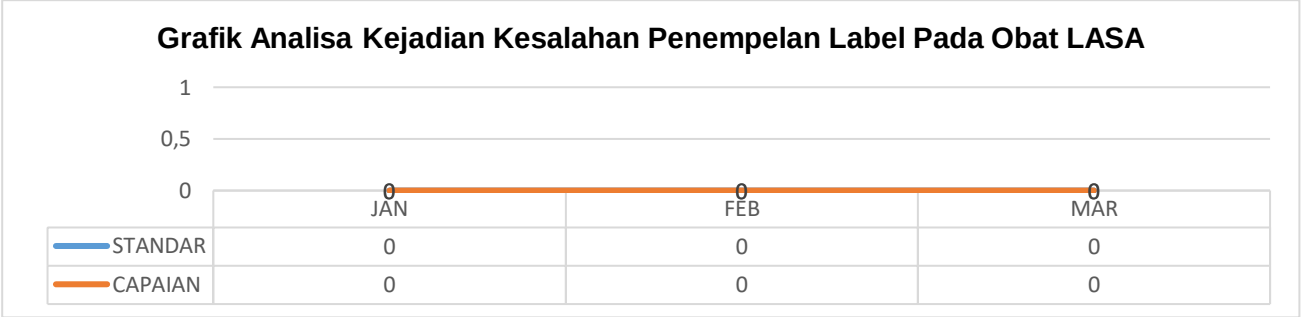
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

4. Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

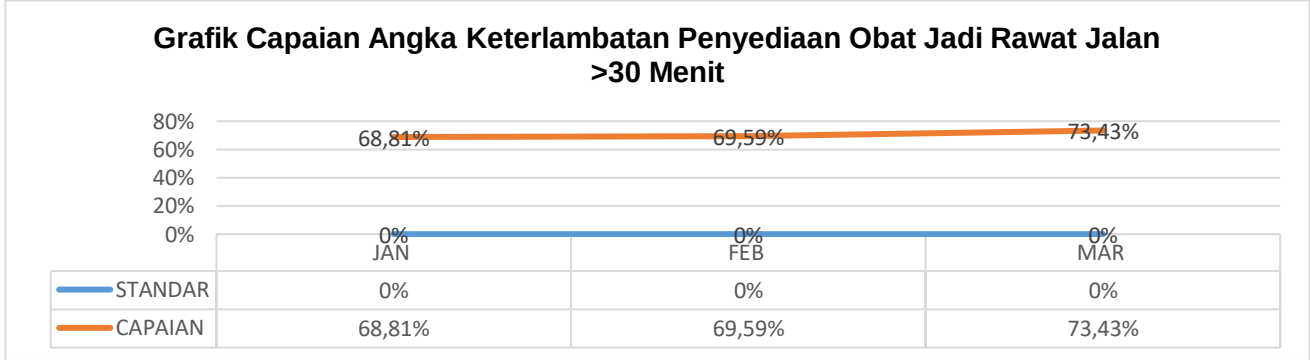


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

5. Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

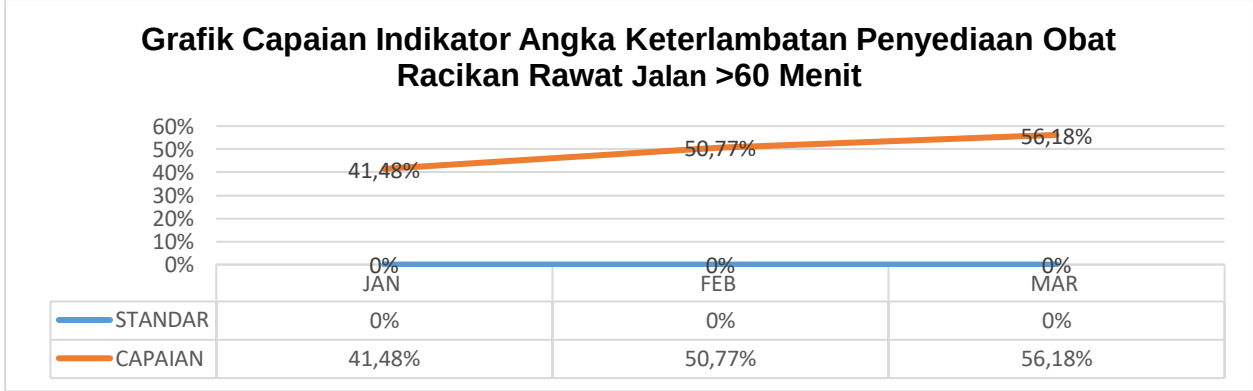
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

6. Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

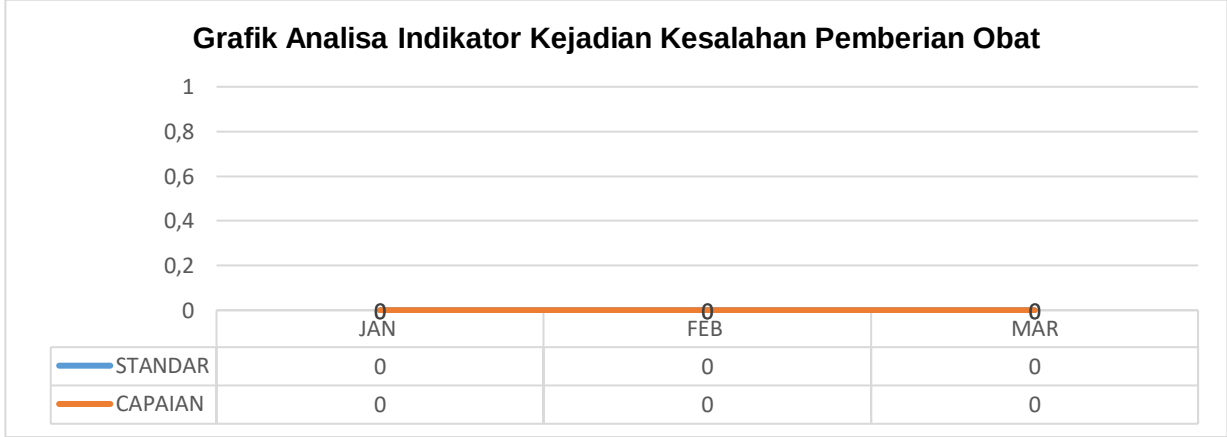


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai

STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resepan, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

7. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

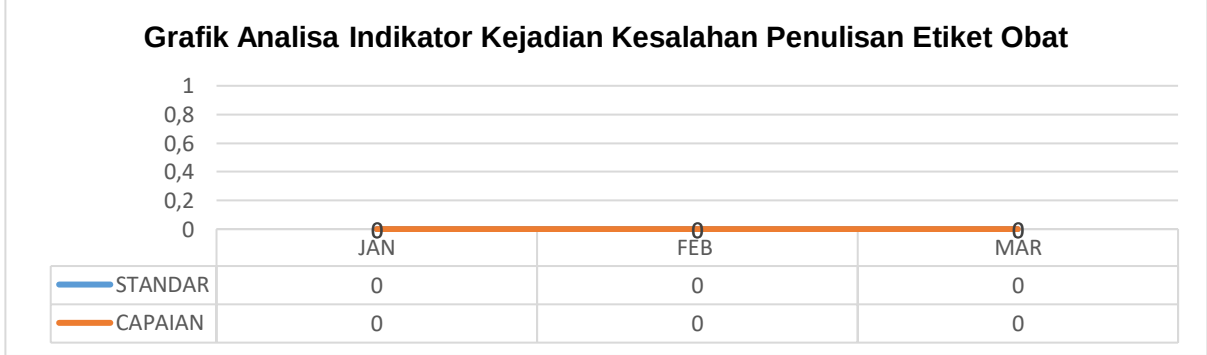
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



Analisa Capaian :
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

8. Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

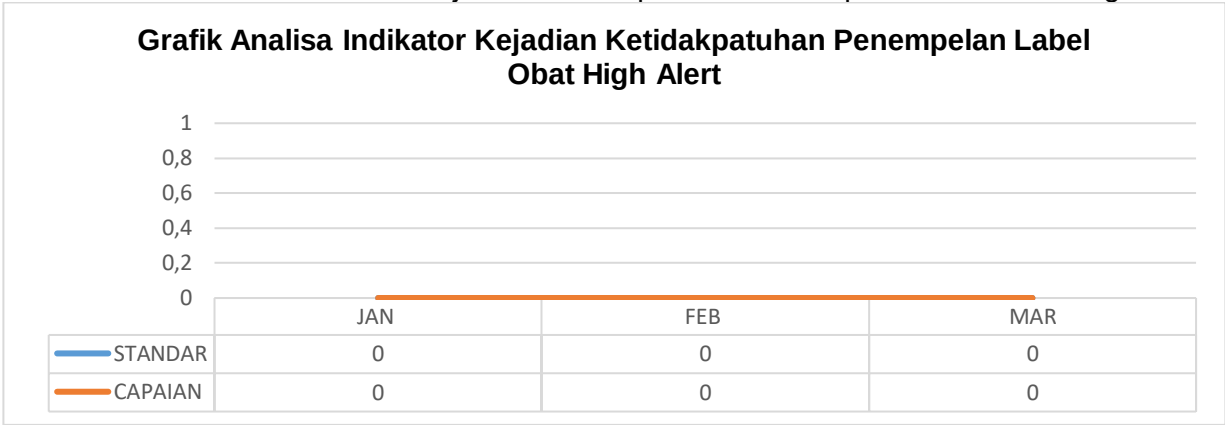
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

9. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

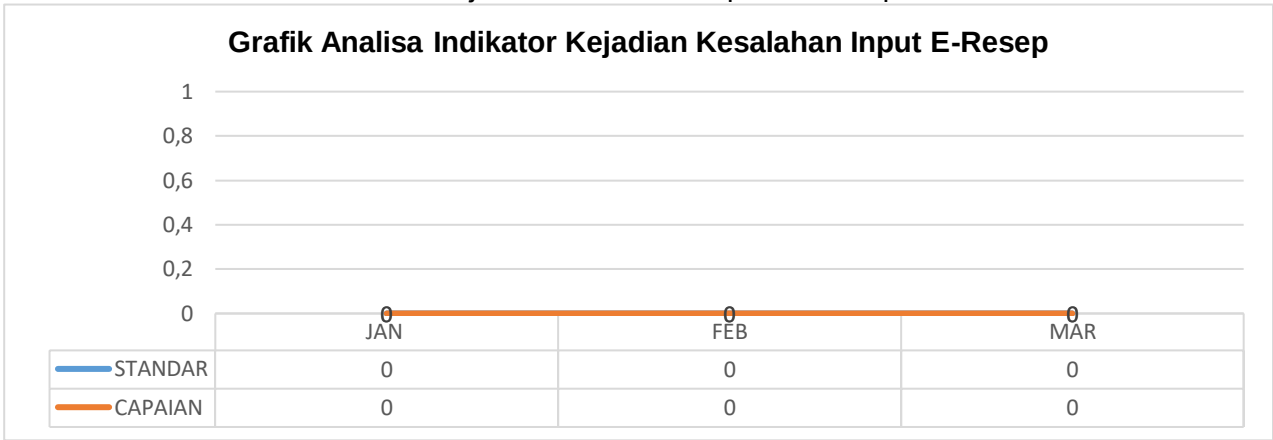
Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

10. Kejadian Kesalahan Input E-Resep

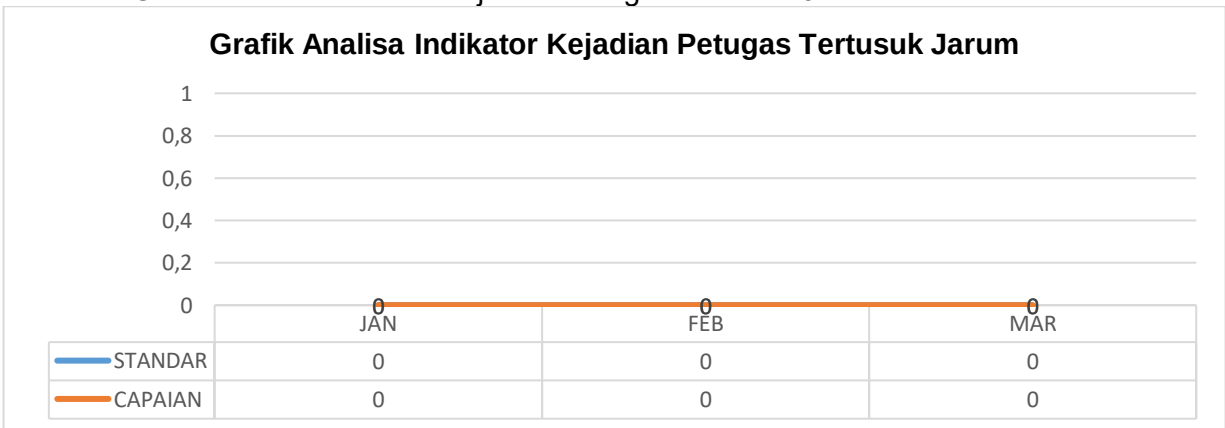
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

11. Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

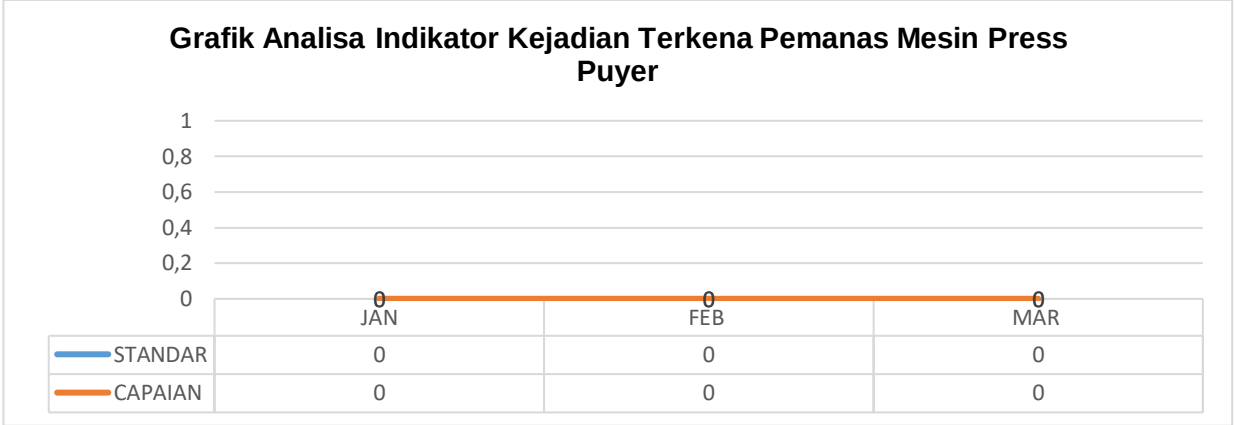
Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

12. Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

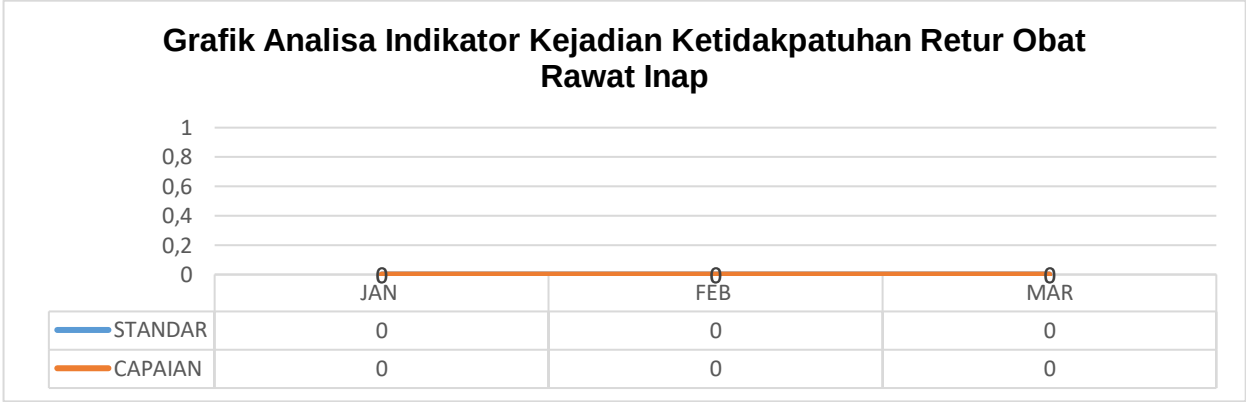
Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2024.

13. Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

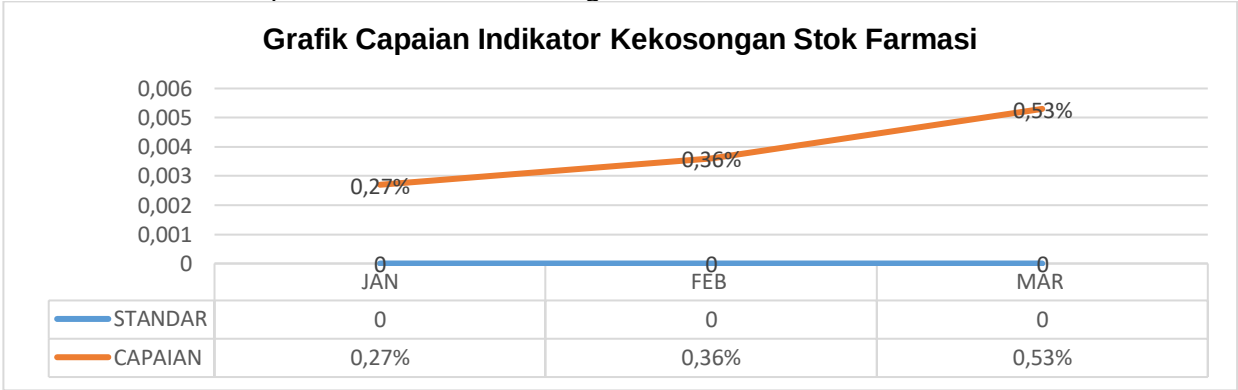
Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisa Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024.

14. Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.

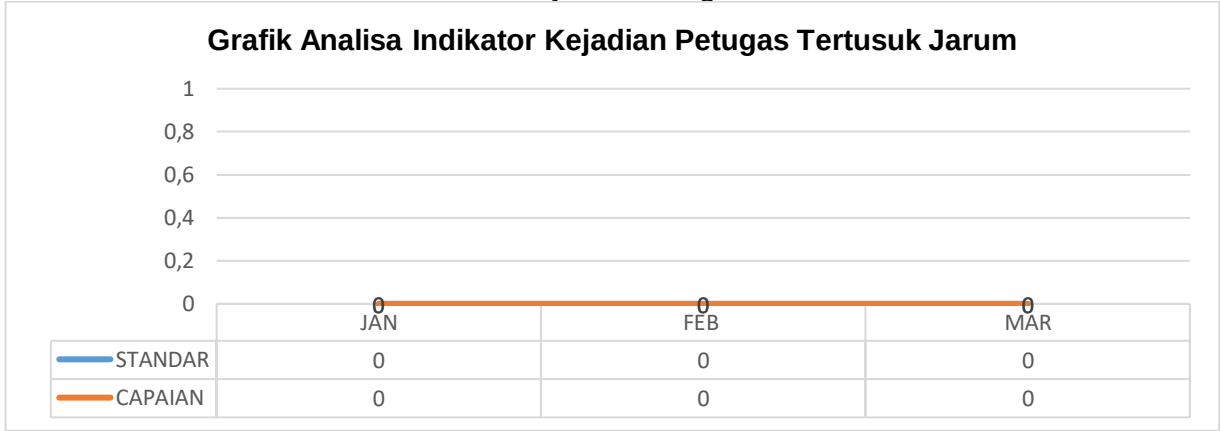
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi yang disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : -Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setuju bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbarui surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	1. Kepala Instalasi farmasi 2. Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

d. Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0

1. Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

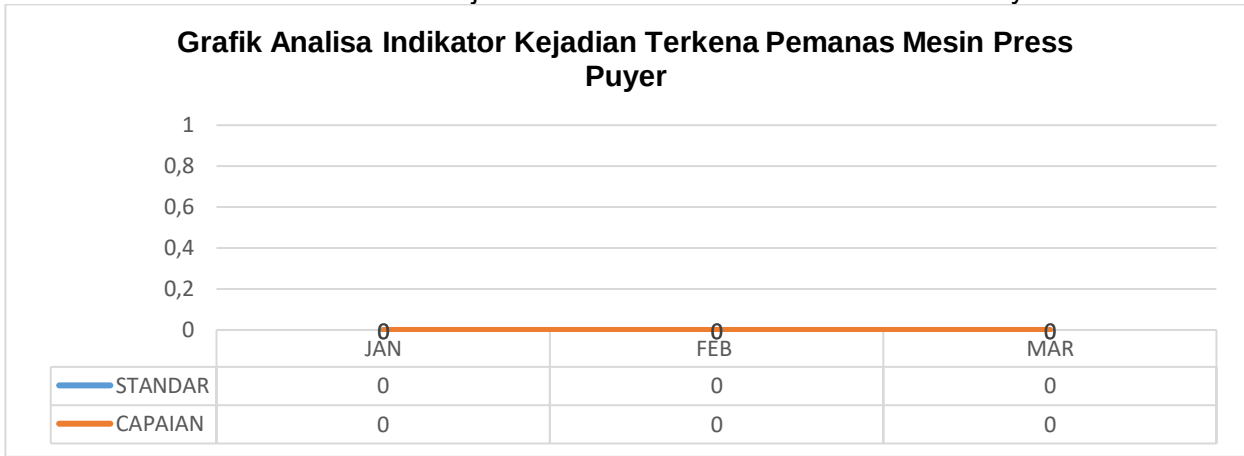


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman.

	4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

2. Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2024.

e. Mutu Unit
1. Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25%	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%

2. IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%

2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%

3. IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18%	89,4%	91,28%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96%	87,65%	82,43%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%

4. IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23%	86,54%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%

5. IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%

6. IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%

7. IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%

8. IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22%	76,67%	75%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-

4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%

9. IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49%	81,45%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%

10. ICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%			
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53%	86%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%

11. HCU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%

12. IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75%	100%	95,71%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42%	82,35%	84,04%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%

13. Maternitas

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	2	0
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%

17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%

14. NICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92%	90,63%	84,72%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%
6	Angka Kematian Bayi	0	0%	0%	0%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0

15. IKO

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0

11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%

16. Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%

17. Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0

18. Gizi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0

19. Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%

7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0

20. Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MARET '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%

21. PPI

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%
6.	Decubitus	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0

22. PIPP

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89%	99,63%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94%	75,31%	57,76%

23. SDM

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99%	98,97%	99,14%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%

24. Rekam Medis

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06%

25. Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	7,7%	6%	3,86%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%

26. K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0

27. Asuransi Center

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04%	0,78%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04%	2,17%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57%	0,44%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1

28. IPSRS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%

29. UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5

30. Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	MAR '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	1,39%	1,67%	29,17%

31. Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	JAN '24	MAR '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21%	0%	20,69%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71%

32. Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0%

33. CSSD

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1

34. Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17%	90,88%	100%

2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82%
---	---	----	-------	------	--------

35. IT

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34
1	Kejadian downtime	0	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%

36. Kamar Jenazah

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34
1	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%

E. Permasalahan Rumah Sakit

1. Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kartu Stok tidak di tulis sesuai dengan tanggal	P	Menegakkan punishment kedisiplinan penulisan kartu stok Memenuhi petugas farmasi di IKO (TTK)
		D	Monitoring dan evaluasi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok Koordinasi dengan SDM terkait evaluasi kinerja
		S	Petugas lebih teliti dan disiplin ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran
		A	Supervisi oleh kains

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Meningkatnya masalah komplain pasien terkait pelayanan di karenakan dokter IGD hanya 1 sehingga pemeriksaan sedikit lebih lambat	P	Melakukan Analisa beban kerja dokter umum dan melakukan open recruitment dokter umum
		D	Jika dokter umum baru sudah masuk, menambah dokter IGD menjadi 2 dokter dan memperbaiki alur rawat jalan di IGD
		S	Evaluasi apakah ada perbaikan pelayanan IGD
		A	Melakukan perbaikan dari hasil evaluasi
2	Menumpuknya berkas rawat jalan/ERM karena ada sebagian dokter tidak tertulis /mengisi	P	Meningkatkan kepatuhan dokter IGD untuk mengisi casemix rawat jalan
		D	Melakukan peneguran langsung pada dokter yang tidak mengisi casemix rawat jalan
		S	Evaluasi apakah casemix / rekam medis sudah terisi dengan lengkap terutama saat load pasien IGD tinggi
		A	Menambah dokter jaga menjadi 2 dokter dalam 1 shift agar beban kerja tidak terlalu berat dan dokter juga

			bisa maksimal dalam pengerjaan berkas rekam medis
3	Pendaftaran IGD hanya 1 jadi waktu kunjungan meningkat pendaftaran tidak teratasi	P	Menambah tim pendaftaran
		D	Membuat Analisa beban kerja dan mengajukan ke PT tetapi tidak di acc
		S	Angka lembur tim pendaftaran tinggi
		A	Mencoba untuk melakukan pengajuan ulang
5	Tidak suportnya ruangan dalam keadaan penuh tetapi ruangan sering menunda dalam menerima pasien	P	Meningkatkan kepekaan perawat ruangan agar dapat bekerja sama dalam menerima pasien
		D	Melakukan konseling pada masing-masing karu untuk menertibkan anggotanya yang menunda dalam menerima pasien
		S	Evaluasi kenyataan di lapangan setelah karu melakukan konseling pada anggotanya
		A	Memasukkan ke evaluasi kinerja jika masih ada anggota yang tidak professional dengan menunda dalam menerima pasien
6	Masalah Fingerprint/absensi pasien rawat jalan yang sampai saat ini belum ada tindakan/ konfirmasi dari IT	P	Menyegerakan finger print pasien rawat jalan
		D	Follow up IT secara berkala
		S	Evaluasi kendala IT, karena masih focus pada SATU SEHAT
		A	Menetapkan deadline pada IT terkait penyelesaian finger print pasien rawat jalan

3. Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien tidak mengenali perawatnya	P	Pasien dapat mengetahui perawat yang melakukan Tindakan padanya agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pasien
		D	Meningkatkan kepatuhan perawat dalam memperkenalkan diri sebelum melakukan Tindakan pada pasien dan mengingatkan untuk selalu memakai nametag sepanjang shift
		S	Evaluasi dari kuisisioner
		A	Melakukan operan langsung ke masing-masing pasien
2	Rekam medis tidak lengkap	P	Meningkatkan kelengkapan rekam medis
		D	Supervisi setiap saat oleh kepala ruang kepada rekam medis yang di kerjakan oleh stafnya
		S	Perawat dan DPJP tidak tertib dalam pengisian rekam medis
		A	Mengingatkan karu dan DPJP. Memasukkan evaluasi kelengkapan DRM ke OPPE DPJP
3	Matras Bed Penunggu pasien rusak dan masih kurang banyak	P	Melakukan proses telusur penyebab kekurangan matras
		D	Mencatat/mendata ruangan yang butuh
		S	Berkoordinasi dengan kepala CS untuk perbaikan matras
		A	Melakukan supervisi setiap saat

4. Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	DPJP masih banyak yang terlambat praktek > 15 menit	P	Meningkatkan kedisiplinan DPJP untuk tepat waktu
		D	Membuat form mengenai surat pernyataan ketepatan HFIS sesuai ketentuan BPJS Mengirimkan surat teguran tertulis pada DPJP yang terlambat >50%
		S	Beberapa DPJP sudah melakukan perbaikan
		A	Mengirimkan OPPE kepada DPJP dengan persentase keterlambatan

5. Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Selisih stok di Depo Farmasi, Gudang Farmasi dan Floorstock IKO	P	Memperbaiki sistem floorstock di IKO
		D	Koordinasi dengan programmer terkait sistem IKO untuk meminimalisir terjadinya selisih dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka IFRS untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Melakukan pencatatan dan melakukan pelaporan untuk stok obat dan selisih
2	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual	P	Mengajukan penambahan fitur KPO digital
		D	Koordinasi dengan programmer perihal pengadaan KPO billing untuk target realisasi dan membantu DPJP dalam penulisan obat agar mudah terbaca.
		S	1. Mempermudah PPA melihat riwayat pemberian obat. 2. Mengurangi koiplain pasien akibat pasien lupa membawa KPO.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan system KPO digital.
3	Penulisan kartu stok di Depo, IKO dan Gudang farmasi yang masih belum berjalan baik	P	Menegakkan punishment kedisiplinan penulisan kartu stok Memenuhi petugas farmasi di IKO
		D	Monitoring dan evaluasi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok Koordinasi dengan SDM terkait evaluasi kinerja
		S	Petugas lebih teliti dan disiplin ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran
		A	Kains melakukan supervise setiap hari
4	Terjadi kekosongan obat sehingga pelayanan tidak maksimal	P	Memperbaiki system ROP
		D	Melakukan evaluasi beberapa rumus ROP kemudian menetapkan rumus yang akan digunakan. Koordinasi dengan programmer untuk mengaplikasikan rumus ROP yang disepakati kedalam system.
		S	Mempersingkat proses order. Meminimalisir petugas kelewat order.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan rumus ROP yang sudah disepakati.

6. Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan PA	P	Memperbaiki alur penerimaan hasil PA rujukan.
		D	Koordinasi dengan Sp.PA dan analis untuk kesepakatan pengiriman hasil pemeriksaan.
		S	Mempercepat proses klaim.
		A	1. Menghubungi dr Berlian, Sp.PA untuk kesepakatan hasil pemeriksaan maksimal 4x24 jam sesuai SPO. 2. Analis melakukan pencatatan dan follow up hasil sebelum batas waktu maksimal.

7. Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tidak bisa menarik data asuhan gizi rawat jalan karena belum terdapat fitur di RM-e	P	Memiliki fitur asuhan gizi di rawat jalan untuk kebutuhan pelaporan internal dan Dinkes.
		D	Permintaan fitur ke programmer sudah dilakukan, menunggu antrian.
		S	Ahli Gizi bisa menyampaikan hasil asuhan gizi pasien rawat jalan di RM-e untuk kebutuhan penarikan data oleh Instalasi RM dan pelaporan.
		A	Follow up ke Programmer (Masuk kedalam antrian)
2	Kelengkapan ERM rawat jalan belum mencapai standar dan tidak bisa tervalidasi	P	Membuat list kekurangan form rawat jalan dan permasalahan ERM rawat jalan, kemudian diserahkan ke Programmer.
		D	1. Mengisi permasalahan yang ditemukan di link google spreadsheet. 2. Koordinasi dengan Programmer untuk ditindaklanjuti.
		S	Memudahkan DPJP dan PPA dalam melakukan pengisian.
		A	Koordinasi dengan Programmer.
3	Penumpukan DRM IRNA dan IRJA karena perpindahan tempat	P	Membuat plotting jadwal untuk target penyelesaian perpindahan DRM dan penyelesaian tugas utama di RM, Filing, Asembling dan Analisa.
		D	Melakukan plotting petugas dan supervise oleh Kabid
		S	Menyelesaikan sesuai jadwal.
		A	Pengkondisian jadwal oleh Kains.
4	Keterlembatan penyetoran DRM meningkat	P	Mencatat keterlambatan setoran DRM meliputi tanggal, unit, nama DPJP dan alasan tidak tepat waktu.
		D	Memberikan catatat keterlambatan kepada Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk ditindaklanjuti.
		S	Mendisiplinkan setoran DRM sesuai realtime.
		A	Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

F. Profil SDM

a. Komposisi dan Distribusi SDM

NO	UNIT	PENDIDIKAN	MARET				
			TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	Bidan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMK	41	20	4	16	0
		D3 Farmasi		12	0	12	0
		S1 Apoteker		3	0	3	0
		S1 Farmasi		1	0	1	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		20	4	16	0
11	Asuransi Center	SMA	11	2	2	0	0
		D3 Kes		3	0	3	0
		D3 RMIK		5	2	3	0
		D3 Asuransi Kes		1	0	1	0
		D4 RMIK		0	0	0	0
12	CSSD	D3 Keperawatan	4	1	1	0	0
		D3 Farmasi		1	1	0	0
		SMK		2	1	1	0
13	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	2	1	0
		D4 Terapi Wicara		1	0	1	0

14	Gizi	SMA	11	11	2	9	0
		D3 Gizi	6	2	1	1	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
15	Humas & Marketing	S.KM	1	1	0	1	0
		Profesi Ners	1	1	1	0	
16	ICU dan HCU	D3 Kebidanan	9	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		4	0	4	0
17	IGD	D3 Kebidanan	28	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	0	7	0
18	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
19	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
20	IPSRs	D3 TEM	1	0	0	1	0
		SKM	1	1	0	1	0
		S1 Teknik	5	2	0	2	0
		SMA		3	1	2	0
27	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
28	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0

		Profesi Ners		5	1	4	0
29	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
30	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
31	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
32	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
33	Maternitas	D3 Kebidanan	10	8	7	1	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
35	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
36	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
37	Laundry	SMA	6	6	3	3	0
38	Rekam Medis	SMA	10	0	0	0	0
		D3 RMIK		9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
39	Pendaftaran	SMA	15	8	1	7	0
		D3 RMIK		4	2	2	0

		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
40	PIPP	Ners	5	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
41	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
42	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
43	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
				1	0	1	0
44	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
45	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
46	Umum	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
47	Cleaning Service	SMP	44	5	2	3	0
		SMA		39	2	37	0
48	Security	SMA	12	12	6	6	0
49	Driver	SMA	5	5	1	4	0
50	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
51	Dokter Spesialis Anak		3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
53	Dokter Spesialis Jantung Paru		3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Paru		4	4	0	4	0

55	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
58	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
59	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3		3	0
60	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Mata		2	2	0	2	0
64	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
65	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
66	Dokter Spesialis Obstetri Ginekology		4	4	0	4	0
67	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
69	Dokter Spesialis THT		1	1	0	1	0

70	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
71	Dokter Spesialis Radiologi		3	3	0	3	0
TOTAL STAF			436	436	75	361	0

Keterangan :

Pada bulan Maret terdapat perubahan staf dari 428 ke 436 karena penambahan staf di unit CS sebanyak 3, di unit Laundry sebanyak 1, di unit Farmasi sebanyak 3, di unit IPSRS sebanyak 1

b. Update STR/SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Dr. dr. Mohammad Kuntadi Syamsul Hidayat, Sp.OT.,M.Kes.,MMRS	Dokter Spesialis Orthopedi	05 Maret 2024	Penonaktifan sementara mengunggu SIP terbit – SIP sudah terbit tanggal 6 Maret 2024.
2	Suci Nur Pratiwi, S.Gz	Ahli Gizi Pelaksana	17 Maret 2024	Penonaktifan sementara menunggu SIP terbit – SIP sudah terbit tanggal 19 Maret 2024.
3	Yurike Devita Ratna Sari dewi, S.Kep.,Ns	Perawat Pelaksana	26 Maret 2024	Penonaktifan sementara menunggu SIP terbit – SIP belum terbit hingga akhir Maret 2024.

F. Kemajuan Piutang

a. Data Piutang yang Belum Terbayar

Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Februari 2024)

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
3	FPK PEND OKT 23	235.480.288	20.12.2024	02.01.2024	206.379.388	29.100.900	-
4	FPK PEND NOV 23	261.599.399	07.02.2024	19.02.2024	235.809.299	25.790.100	-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024				6.015.000
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024				12.485.000
							-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024				7.740.000
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024				3.795.000
							-
3	BPJS REGULER MARET 2024	7.929.995.849					7.929.995.849
	Belum FPK						-
							-
		30.896.648.719			22.843.343.570	93.274.300	7.960.030.849

Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	JAN 24	RJ	12.393	12.336	1	57	0,5%
		RI	947	867	-	80	8%
2	FEB 24	RJ	11.519	11.510	2	9	0,1%
		RI	1.004	915	-	89	9%

b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG								
PERIODE 2024								
			Y	Z	AA	AB	AC	
NO	DESKRIPSI	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE MARET 2024 :								
1	Asuransi	133.029.509	127.762.727	3.293.980	-	532.660	1.440.142	133.029.509
2	Perusahaan	85.432.634	77.492.984	-	-	300.000	7.639.200	85.432.184
3	Mandiri Inhealth	105.516.972	105.516.972	-	-	-	-	105.516.972
4	Jasa Raharja	116.169.793	116.169.793	-	-	-	-	116.169.793
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.266.491.754	1.254.583.892	4.191.497	4.836.712	2.580.152	299.500	1.266.491.754
		1.706.640.663	1.681.526.369	7.485.477	4.836.712	3.412.812	9.378.842	1.706.640.213

Keterangan :

1. Cutt OF piutang per tanggal 31 Maret 2024 dengan saldo Rp 1.706.640.213,-
2. Asuransi Admedika Proses Rekonsiliasi dengan pihak asuransi di Jakarta untuk asuransi pacific cross PCET pengajuan penutupan karena proses pembayaran lebih dari 120 hari
3. Mandiri Inhealth jenis manage care untuk maret belum pengiriman karena proses addendum dan penginputan pada website mandiri inhealth untuk tarif tindakan fisioterapi. Hail follow up dengan bu siwi akan di proses setelah cuti idul fitri.
4. BPJS Ketenagakerjaan proses rekonsiliasi dengan PIC Pak Bayu setelah cuti Idul Fitri atas piutang diatas 60 hari

c. Update IKS

NO	INSTANSI	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	12 Desember 2017	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	Asuransi	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	13 April 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku		3143/PMN-PA/IV/2020
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	4 November 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	28 November 2016	Perpanjang Otomatis	Berlaku	150/ PKS- RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016	
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	19 September 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	26 agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	14 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		091/ELI/LGL/X/19
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	15 Agustus 2013	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013
11	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	9 Oktober 2012	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012

12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Asuransi	Selamanya	9 April 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	16 Maret 2015	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	14 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		090/ELI/LGL/X/19
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	24 Oktober 2013	Perpanjang Otomatis	Berlaku	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	17 September 2018	Perpanjang Otomatis	Berlaku	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	24 Juli 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Asuransi	Selamanya	28 April 2018	Perpanjang Otomatis	Berlaku	025/RSPH/E- PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	070/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	25 Februari 2015	Perpanjang Otomatis	Berlaku	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	02 Januari 2017	Perpanjang Otomatis	Berlaku	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017
22	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu	Asuransi	Selamanya	2 Maret 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku	017/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan	Asuransi	Selamanya	29 November	Perpanjang Otomatis	Berlaku	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019

		Kesehatan			2019				
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	Asuransi	2 Tahun	21 Agustus 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku	364/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	30 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	28 Agustus 2020	27 Agustus 2023	Berlaku	PKS.031/GHASKES/157- 1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	7 September 2020	7 September 2025	Berlaku	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	Asuransi	Selamanya	31 Agustus 2020	Perpanjang Otomatis	Berlaku	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	Asuransi	Selamanya	4 Januari 2014	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	-
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 maret 2022	Perpanjang Otomatis	Berlaku	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	Selamanya	10 Oktober 2023	10 Oktober 2028	Berlaku	149/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang	Klinik	Selamanya	11 September 2012	Perpanjang Otomatis	Berlaku		
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	1 Juni 2014	Perpanjang Otomatis	Berlaku	-	55/Perj/HMS/IX/2014
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Medisak Chek Up	Perusahaan	Selamanya	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	1 April 2013	Perpanjang Otomatis	Berlaku		

36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	Perusahaan	Selamanya	5 Januari 2012	Perpanjang Otomatis	Berlaku	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	Perusahaan		9 Januari 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)	Perusahaan	Selamanya	1 Oktober 2014	Perpanjang Otomatis	Berlaku		
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	2 Tahun	20 Maret 2015	Perpanjang Otomatis	Berlaku		
40	Harris Hotel & Conventions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	2 Tahun	14 Oktober 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac	Perusahaan	Selamanya	11 Januari 2019	Perpanjang Otomatis	Berlaku		
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Rumah Sakit	Selamanya	2 Desember 2016	Perpanjang Otomatis	Berlaku	1097.1/E-PKS/DIR/VIII/2021	
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK			Selamanya	1 Mei 2015	Perpanjang Otomatis	Berlaku	003/MKT/HLT/PKS/I/2015	PH/IKS/269/XII/2014
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan	Asuransi	5 Tahun	4 Juli 2022	4 Juli 2027	Berlaku	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkitan Umum	Asuransi	4 Tahun	7 Februari 2023	4 Juli 2027	Berlaku		

		dan Lalu Lintas Jalan							
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	23 Januari 2024	20 Januari 2027	Berlaku	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	6 Februari 2024	6 Februari 2027	Berlaku	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk	Perusahaan	5 Tahun	1 September 2022	1 September 2027	Berlaku		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	Rumah Sakit	5 Tahun	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Berlaku	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	3 Tahun	26 Juni 2023	26 Juni 2026	Berlaku	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023
51	ASABRI	Pelayanan Pengobatan Dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta Asabri Aktif	Asuransi	3 Tahun	13 Desember 2023	13 Desember 2026	Berlaku	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	15 April 2023	15 April 2026	Berlaku	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
53	Klinik Tirta Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	18 September 2023	18 September 2026	Berlaku	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	24 April 2023	27 April 2026	Berlaku	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	Klinik	3 Tahun	3 Juli 2023	3 Juli 2026	Berlaku	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023
56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	1 Desember 2023	31 November 2026	Berlaku	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023
57	Klinik Rawat Inap	Rujukan Asuhan	Klinik	3 Tahun	15 April	15 April	Berlaku	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023

	Wijaya Husada	Pasien			2023	2026			
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	21 Juli 2023	21 Juli 2026	Berlaku	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Klinik	3 Tahun	3 Aoktober 2023	3 Oktober 2026	Berlaku	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	Klinik	3 Tahun	31 Mei 2023	31 Mei 2025	Berlaku	131.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	Laboratorium	3 Tahun	5 Juni 2023	5 Juni 2026	Berlaku	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	22 Juni 2023	22 Juni 2026	Berlaku	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	1 November 2023	1 November 2026	Berlaku	222/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	15 Juni 2023	15 Juni 2026	Berlaku	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit	Perusahaan	4 Tahun	22 April 2022	24 April 2026	Berlaku		
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	Berlaku	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	3 Tahun	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	Berlaku	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	Rumah Sakit	3 Tahun	1 Januari 2024	31 Desember 2026	Berlaku	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT
69	RS Puri Bunda	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	6 Februari 2024	6 Februari 2026	BERLAKU	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	1 Maret 2024	1 Maret 2026	Berlaku	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024

71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	2 Tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025	Berlaku	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023	
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	Asuransi	2 Tahun	30 Januari 2023	31 Januari 2025	Berlaku	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	Bidan Praktek Mandiri	3 Tahun	10 Januari 2022	10 Januari 2025	Berlaku	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025	Berlaku		
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	5 Januari 2022	5 Januari 2025	Berlaku	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022	
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025	Berlaku	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	360/DPM/I-PKS/VIII/2020	
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	5 Tahun	1 Juli 2020	1 Juli 2025	Berlaku	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Karyawan Dan Keluarga	Perusahaan	3 Tahun	1 Juni 2022	1 Juni 2025	Berlaku	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/II/2020
81	PT. Tirta Investama	Pelayanan Kesehatan Karyawan & Keluarga	Perusahaan	5 Tahun	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	Berlaku		
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	Perusahaan	2 Tahun	1 Januari 2023	31 Desember 2025	Berlaku	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Berlaku		
84	PT. Nayaka Era	Pelayanan	Perusahaan	2 Tahun	30 Mei	30 Mei	Berlaku	143.1/DPM/E-	PKS/106/072023

	Husada	Kesehatan			2023	2025		PKS/DIR/VII/2023	
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	PMI	1 Tahun	1 Juni 2023	1 Juni 2025	Berlaku	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	PMI	1 Tahun	20 November 2023	31 Desember 2025	Berlaku	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	10 Agustus 2023	10 Agustus 2025	Berlaku	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	Rumah Sakit	3 Tahun	21 Februari 2022	21 Februari 2025	Berlaku	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	Rumah Sakit	3 Tahun	7 Oktober 2022	6 Oktober 2025	Berlaku	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk	Perusahaan	1 Tahun	1 Januari 2024	1 Januari 2025	BERLAKU		106/KCS-PNS/MOU/II/2023
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi	5 Tahun	18 September 2019	18 September 2024	Berlaku	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	Asuransi	4 Tahun	28 Januari 2020	27 Januari 2024	Berlaku	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN	Asuransi	1 Tahun	1 Januari 2024	31 Desember 2024	Berlaku	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi	1 Tahun	1 Januari 2023	31 Desember 2024	Berlaku	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022

95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Bidan Praktek Mandiri	3 Tahun	10 Maret 2021	10 Maret 2024	Berlaku	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022	
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	Klinik	3 Tahun	16 Juni 2021	16 Juni 2024	Berlaku	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	Perusahaan	1 Tahun	1 Juni 2023	1 Juni 2024	Berlaku	132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	Perusahaan	2 Tahun	1 Maret 2022	1 Maret 2024	Berlaku	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun	12 Desember 2021	12 Desember 2024	Berlaku	174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	Perusahaan	1 Tahun	11 September 2023	11 September 2024	Berlaku	173.1/DPM/E-PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023
101	PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)	Layanan Antar Obat Pasien	Perusahaan	1 Tahun	15 Juni 2023	15 Juni 2024	Berlaku	138.2/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/MLG/23-24
102	PT. TSSA (Teman Sejati Sejahtera Abadi)	Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan	1 Tahun	6 Februari 2023	2 Juni 2024	Berlaku	0175/LGL-PK/DPM-TSSA-AMP/II/2023	
103	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	Perusahaan	1 Tahun	1 Juni 2023	30 Juni 2024	Berlaku	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023
104	PT. Global Trans Jaya Mulia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Perusahaan	1 Tahun	1 April 2023	31 Maret 2024	Berlaku	060.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023
105	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan	Perusahaan	3 Tahun	8 Juni 2023	8 Juni 2024	Berlaku	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021

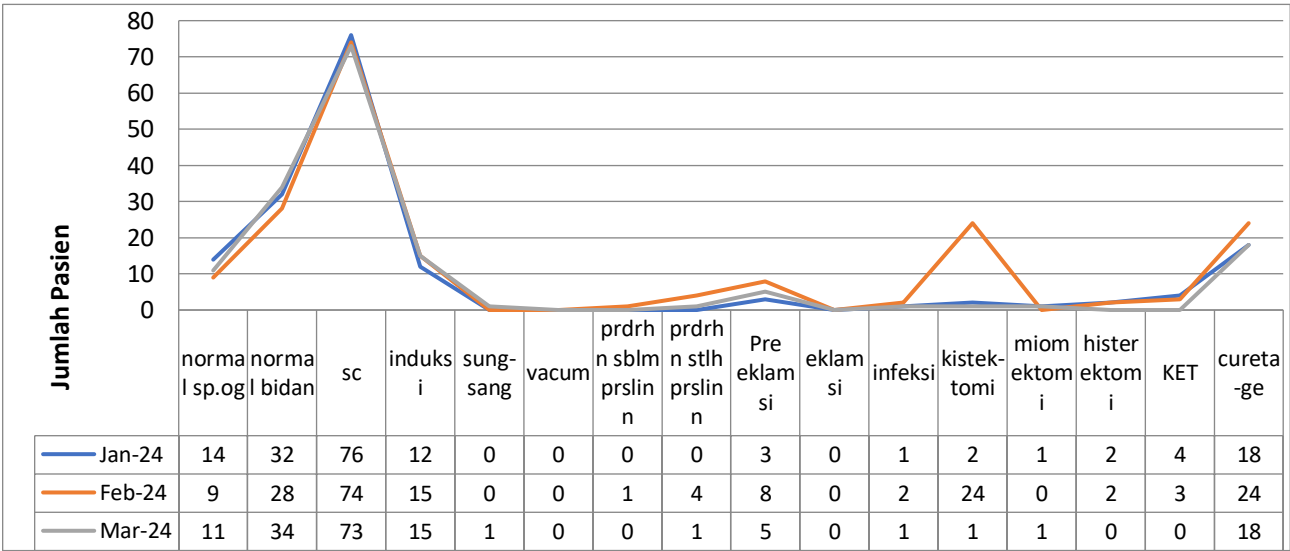
		Kesehatan dan Penunjang							
106	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	Rumah Sakit	2 Tahun	1 November 2022	1 November 2024	Berlaku	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019
107	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	16 September 2022	15 September 2024	Berlaku	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022
108	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	Rumah Sakit	2 Tahun	4 Oktober 2022	3 Oktober 2024	Berlaku	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022
109	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	Rumah Sakit	2 Tahun	1 November 2022	1 November 2024	Berlaku	1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022	116//102.7/2022
110	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	Rumah Sakit	1 Tahun	21 Agustus 2023	21 Agustus 2024	Berlaku	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023
111	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	Dinas Pemerintah			31 Desember 2023	PROSES PERMOHONAN	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023
112	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Perusahaan	1 Tahun	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Proses TTD Pihak Kedua		
113	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	Asuransi				PROSES TTD DILUAR		
114	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan	Asuransi				PROSES DISPOSISI SIM		

115	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Kesehatan	Asuransi				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS		
116	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	Dinas Pemerintah	1 Tahun	17 Januari 2024	17 Januari 2025	Proses pengajuan TTD ke BKKBN	294/E-PKS/DIR/I/2024	
117	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Proteza Ortesa	Pengadaan Alat				PROSES DISPOSISI SIM		
118	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan	3 Tahun			Progres Review di Pihak Kedua		
119	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Media Online	2 Tahun			Progres Review di Pihak Kedua		
120	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Progres Review di Pihak Kedua		
121	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Perusahaan				Progres Review di Pihak Kedua		
122	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Klinik				Progres pengajuan di PT by SIMRS		

G. Program Nasional
a. Ponek
Kinerja Dan Produktivitas
1. Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1				
	a. Persalinan Normal Sp. OG	14	9	11
	b. Persalinan Normal Bidan	32	28	34
	c. <i>SectioCaesaria</i>	76	74	73
2				
	a. Induksi / Drip	12	15	15
	b. Sungsang	0	0	1
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	0	4	1
	c. Pre Eklamsi	3	8	5
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	1	2	1
4				
	a. Curretage	18	24	18
	b. Kistektomi	2	2	1
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	2	2	0
	e. KET	4	3	0

Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Maret 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 73 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan Maret 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 34 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Persalinan sungsang pada bulan Maret terdapat 1 pasien, sedangkan pada bulan Januari maupun Februari tidak ada persalinan sungsang, dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024
4. Induksi Persalinan pada bulan Februari dan Maret tetap sebanyak 15 pasien.
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Maret 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024.
6. Jenis pelayanan curetage di bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu 18 pasien. Curetage dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometoragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

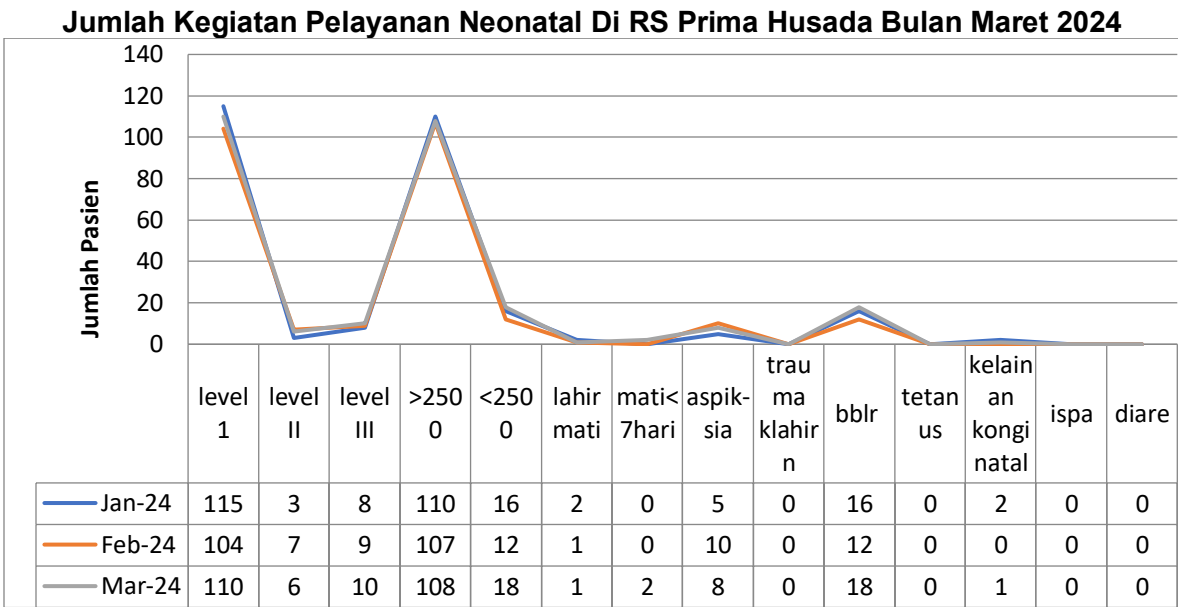
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1				
	a. Level 1	115	104	110
	b. Level II	3	7	6
	c. Level III	8	9	9
2				
	a. ≥ 2500 gram	110	107	108
	b. ≤ 2500 gram	16	12	18
3				
	a. Kelahiran Mati	2	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	2
4				

	a. Asphyxia	5	10	8
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	16	12	18
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	2	0	1
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0



Evaluasi

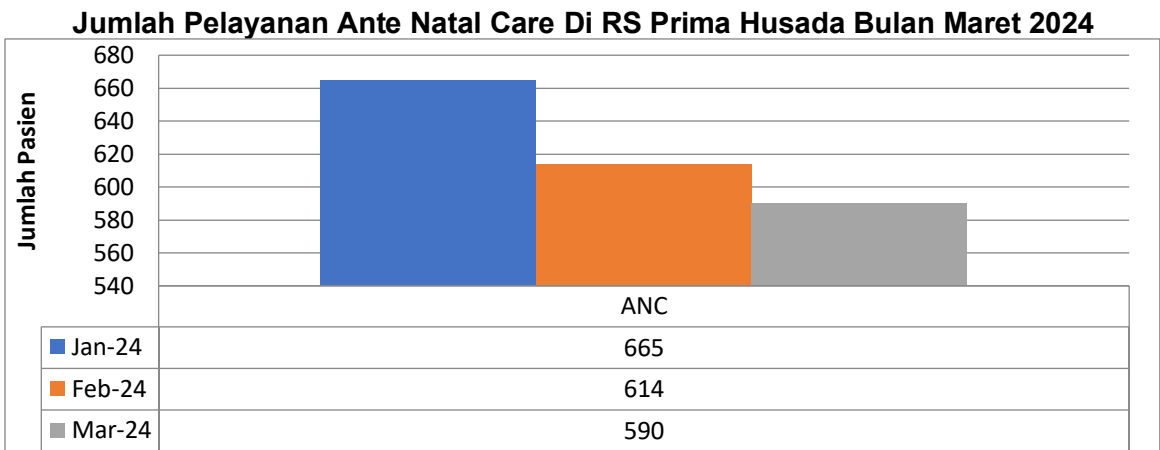
- Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Maret 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 110 bayi. Sedangkan level 2 pada sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi. Sedangkan pada level 3 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi.
- Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Maret 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 108 bayi.
- Dan masih terdapat jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Maret 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 18 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- Kasus BBLR pada bulan Maret 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 18 bayi.
- Terdapat kasus kelahiran mati pada bulan Februari dan Maret sebanyak 1 kasus
- Terdapat kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Maret sebanyak 2 kasus

Rencana dan Tindak Lanjut

- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		665	614	590
1	ANC	665	614	590



Evaluasi :

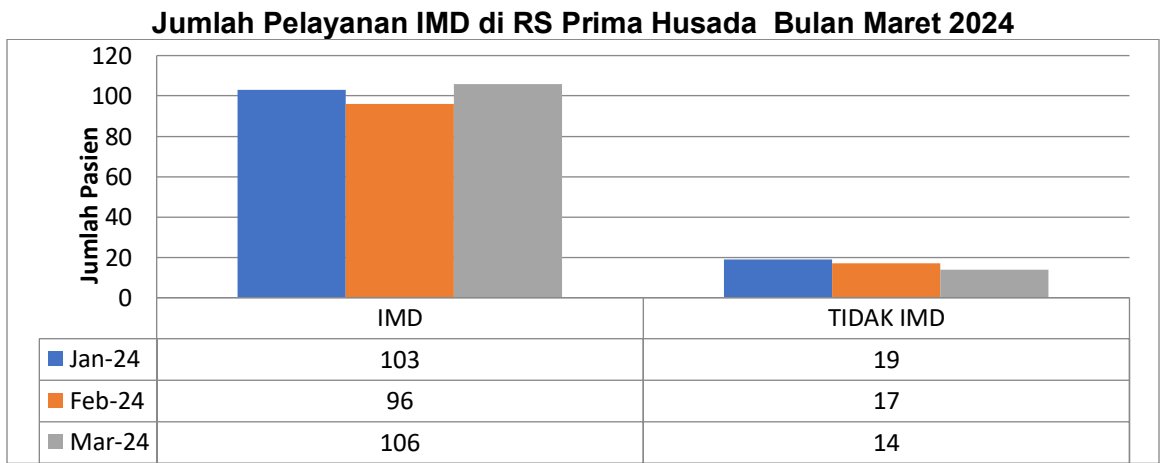
Pelayanan ANC pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 590 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	IMD	103	96	106
2	Tidak IMD	19	17	14



Evaluasi :

- Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 106 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Maret 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.

3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut

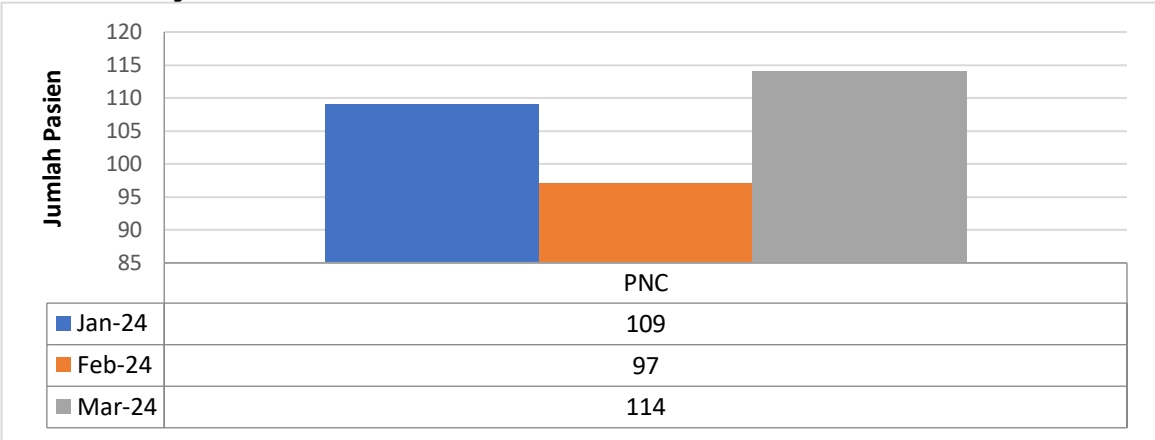
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponек RSPHM Maret 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	PNC	109	97	114

Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

Pelayanan PNC pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 114 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

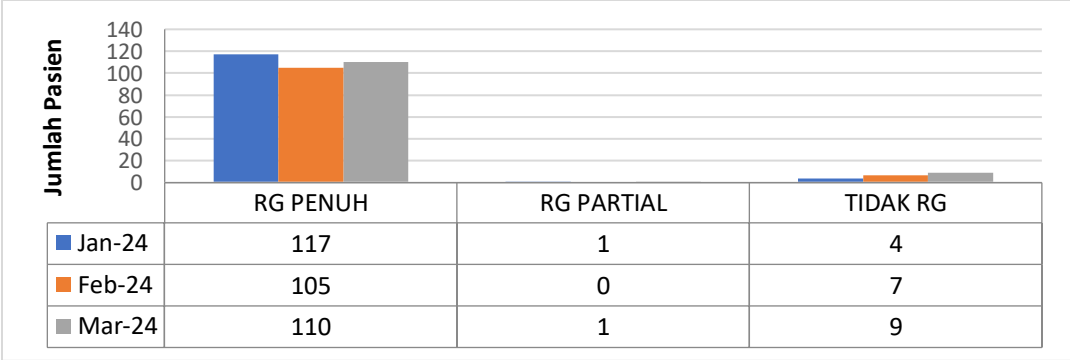
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

6. Pelayanan Rawat Gabung

Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponек RSPHM Maret 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Rawat gabung penuh	117	105	110
2	Rawat gabung partial	1	0	1
3	Tidak Rawat gabung	4	7	9

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 110 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 9 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

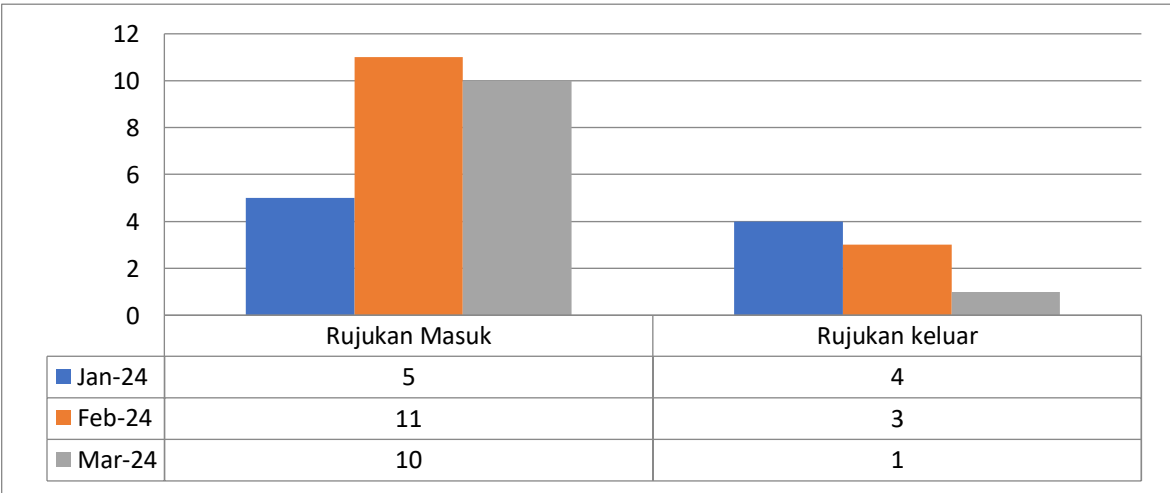
Melakukan skrening awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

7. Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek RSPHM Maret 2024

NO	RUJUKAN	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Rujukan Masuk	5	11	10
2	Rujukan keluar	4	3	1

Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Maret 2024

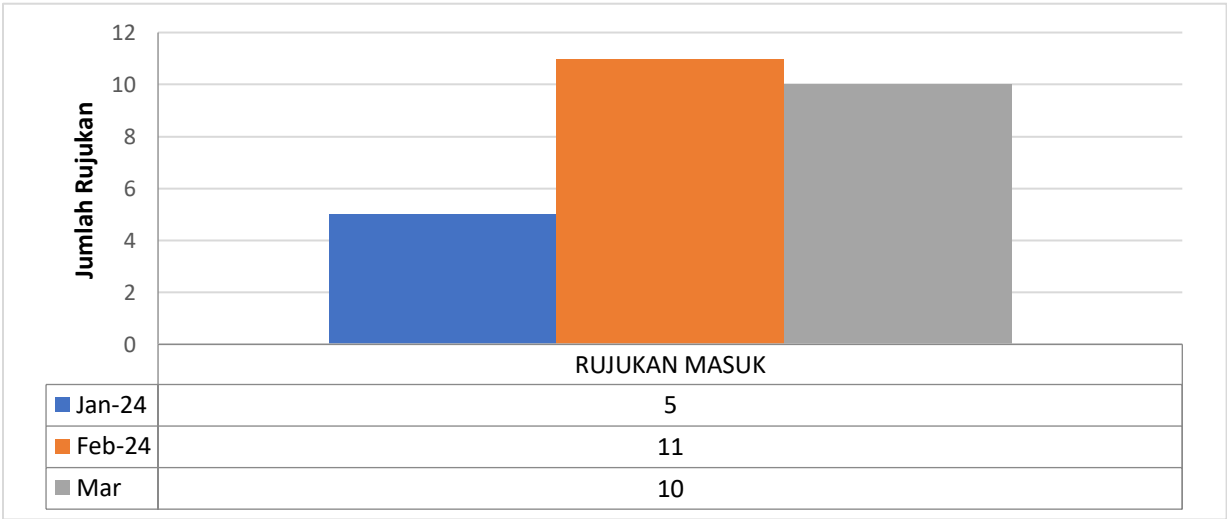


Tabel Rujukan Masuk Ponpek RSPHM Maret 2024

BULAN JANUARI 2024		
1	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
2	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
3	G1 P0000 Ab000 UK : 40 mgg dengan DJJ Irreguler	BPM Titik
4	G1 P0000 Ab000 UK : 32 mgg dg Susp. Inpending Eklamsia	BPM Yena
5	G2 P1001 Ab000 UK 28-30 mgg dg Susp Plasenta Letak Rendah	PKM Pembantu desa Dengkol
BULAN FEBRUARI 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 40 mgg dg PEB	BPM Nurul ismawati
2	G3 P2002 Ab000 UK 10 – 12 mgg dg DHF	Klinik Putra Husada
3	G4 P3003 Ab000 11-12 mgg dg Abortus Inkomplit	BPM Suma'iyah
4	G2 P1001 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg gemelli + KIFA + PE	BPM Rini Idawati
5	G2 P0000 ab100 uk 39 – 40 mgg dg KIFL	BPM Indi
6	G1 P0000 ab000 uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati

7	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg susp CPD	BPM Titik
8	G2 P1001 ab000 uk 39-40 mgg dg BSC	BPM Titik
9	G3 P2002 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg KIFA	BPM Indi
10	G1 P0000 Ab000 uk 6-8 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
11	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	BPM
BULAN MARET 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 30-32 mgg dengan PPR0M	RS Sumber Sentosa
2	G1 P0000 Ab000 UK : 28-30 mgg dg obs vomiting + anemia	Klinik Mutiara Sehat
3	G3 P2002 Ab000 UK : 39-40 mgg dg Prolong Fase laten + KPD	PKM Singosari
4	G1 P0000 AB000 UK 40-41 MGG DG KIFL	BPM Anis Sulisyorini
5	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 mgg dg prolong fase laten	RS Marsudi Waluyo
7	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg KIFL + BSC	BPM Sri Utami
8	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg PE	BPM Titik
9	G2 P1001 Ab000 UK 42 mgg dg KIFA+ PE	BPM Lilik Agustina
10	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PE	BPM Subaeda

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Maret 2024 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 rujukan masuk.

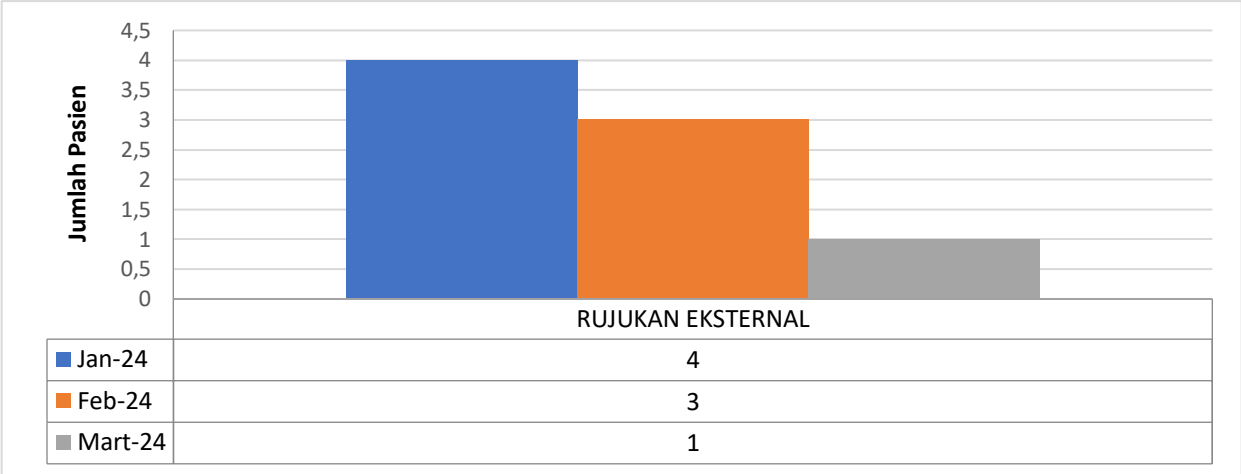
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

Tabel Rujukan Keluar Ponek RSPHM Maret 2024

BULAN JANUARI 2024		
1	NKB + Atresia Ani + susp PJB	RSSA
2	G3 P1001 Ab100 Uk : 24-26 mgg dg PPR0M + Plasenta Previa+ BSC + Letak lintang + Fetal Distres	RSSA
3	G5 P1001 Ab300 Uk : 10 – 12 mgg dg HEG + DM + HT + KAD	RSSA
4	APB + PEB curiga lnpending Eklamsi	RSSA
BULAN FEBRUARI 2024		
1	NKB+BBLR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
2	NKB+BBLSR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
3	Pneumonia, Asfiksia. BBLR	RS Lavalette
BULAN MARET 2024		
1	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	RS Soepraoen

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



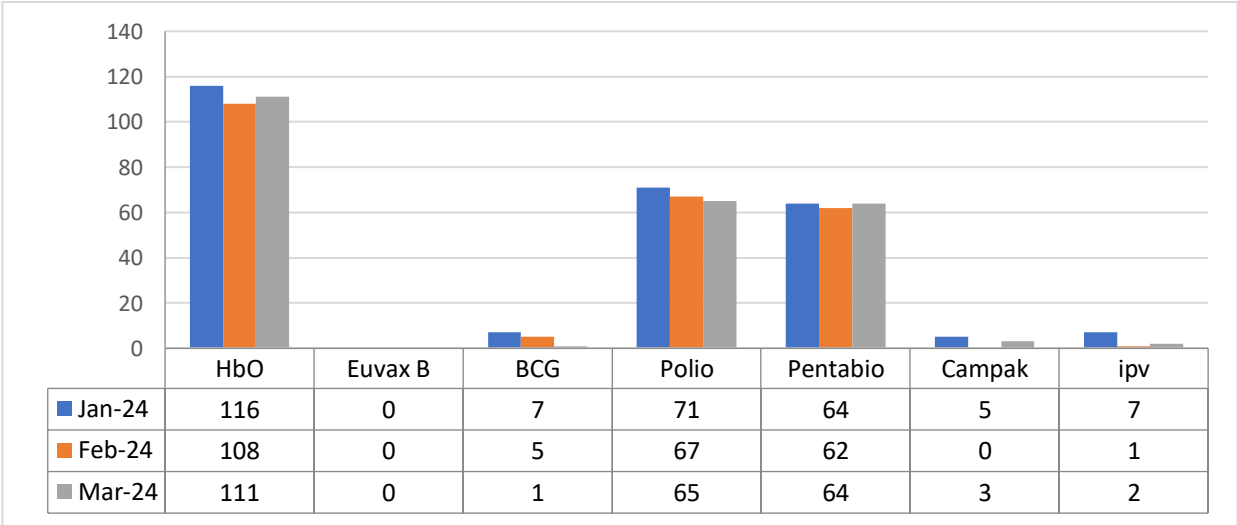
Evaluasi :
Pada bulan Maret 2024 pasien yang dirujuk keluar menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan Sebelumnya, yaitu 1 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

8. Pelayanan Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	HbO	116	108	111
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	7	5	1
3	Polio	71	67	65
4	Pentabio	64	62	64
5	Campak	5	0	3
6	IPV	7	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Maret 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.

2. Imunisasi Hbo pada bulan Maret mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 111 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
5. Pada periode Maret 2024 bayi yang melakukan Imunisasi campak mengalami peningkatan yaitu 3 bayi.
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 65 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Maret 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 64 pasien

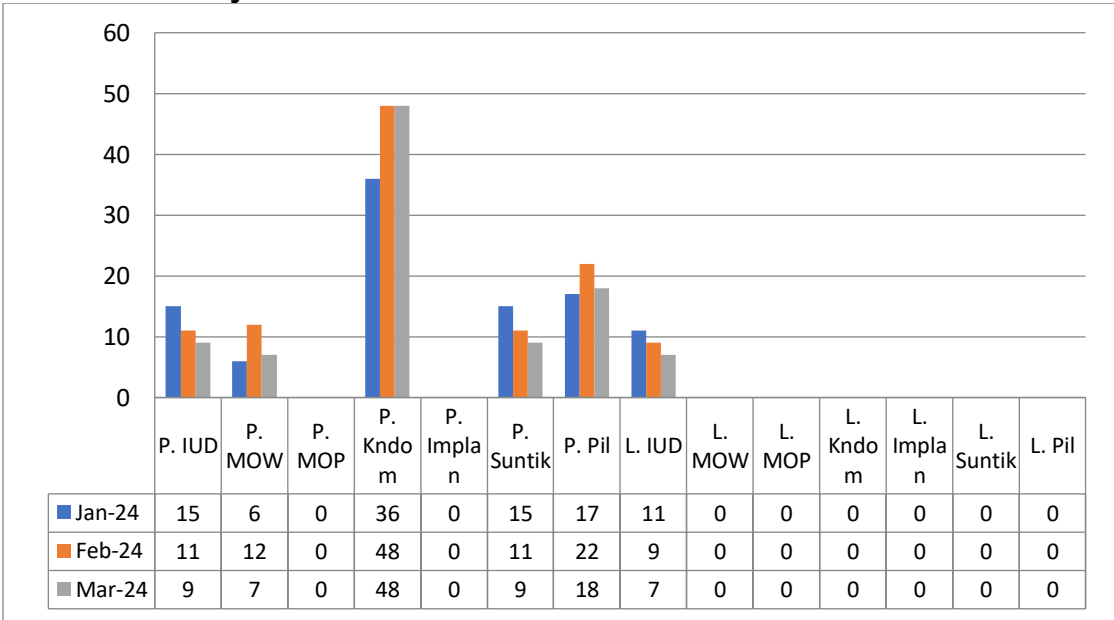
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

9. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	IUD	15	11	9	11	9	7
2	MOW	6	12	7	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	36	48	48	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	15	11	9	0	0	0
7	Pil	17	22	18	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan Maret 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 akseptor, yang terdiri dari IUD Nova T sebanyak 6 akseptor dan IUD Copper T sebanyak 3 akseptor

2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Maret menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Maret 2024 tetap sebanyak 48 pasien.
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Maret 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 18 pengguna
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 pengguna

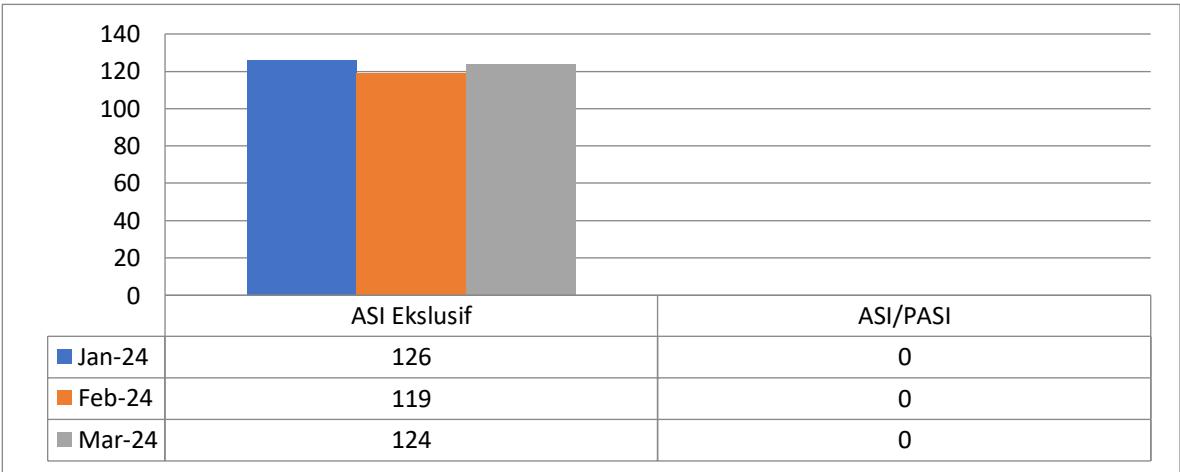
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Asi eksklusif	126	119	124
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 124 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

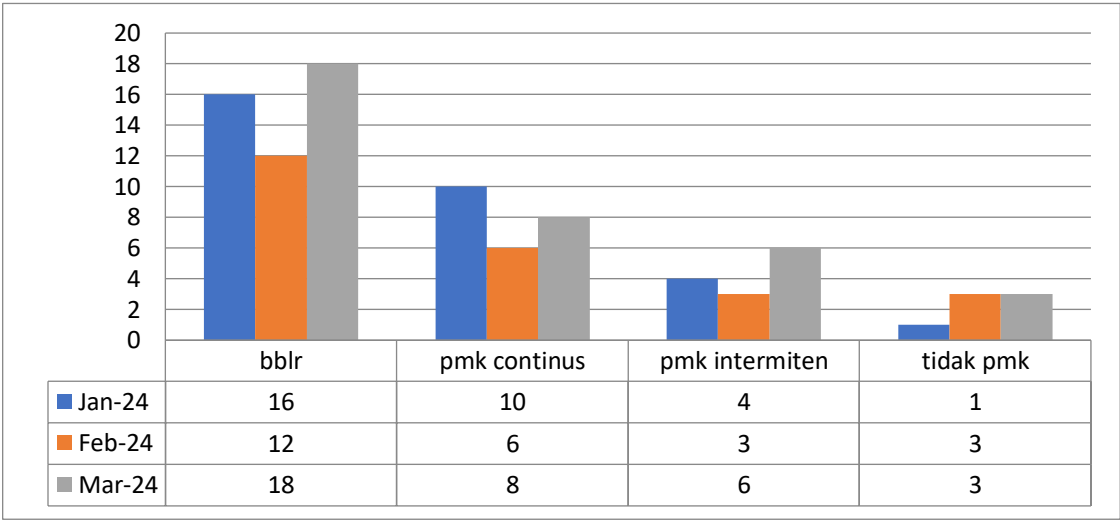
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Bayi BBLR	16	12	18
2	PMK continuos	10	6	8
3	PMK Intermiten	4	3	6
4	Tidak PMK	1	3	3

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Evaluasi :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Maret 2023 meningkat menjadi 6 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Maret 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan terdapat 3 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Februari dan Maret 2024, dan meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

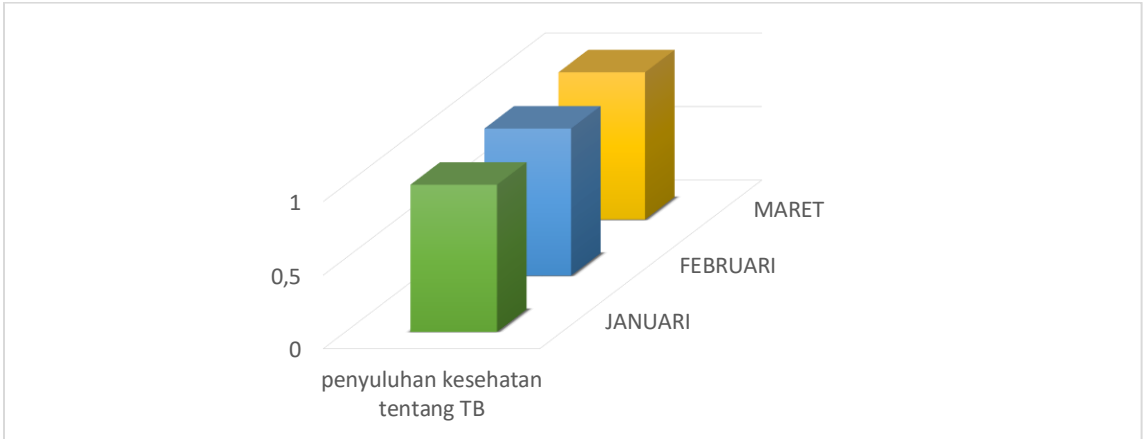
b. TB Dots

Kinerja Produktivitas

1. Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Di RS Prima Husada



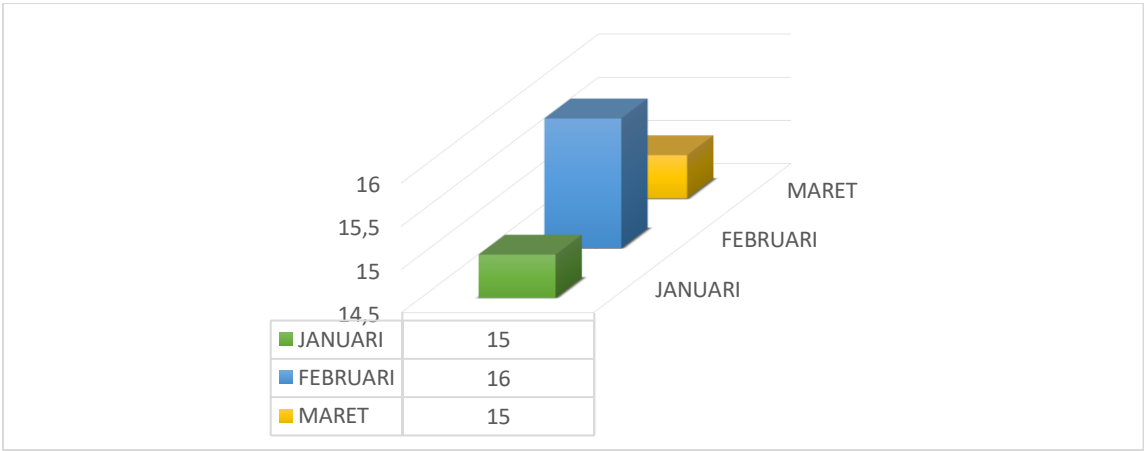
Evaluasi :
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

2. Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15	16	15

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada

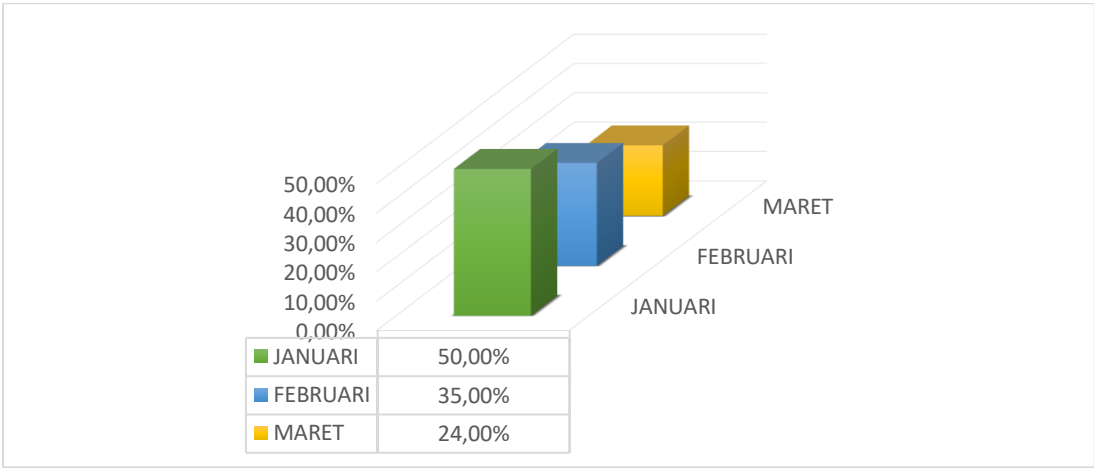


- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan Januari 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
 - 2. Pada bulan Februari 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)
 - 3. **Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis**

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	50	35	24

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Evaluasi :

1. Pada bulan januari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 50
2. Pada bulan februari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 35
3. Pada bulan maret 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24

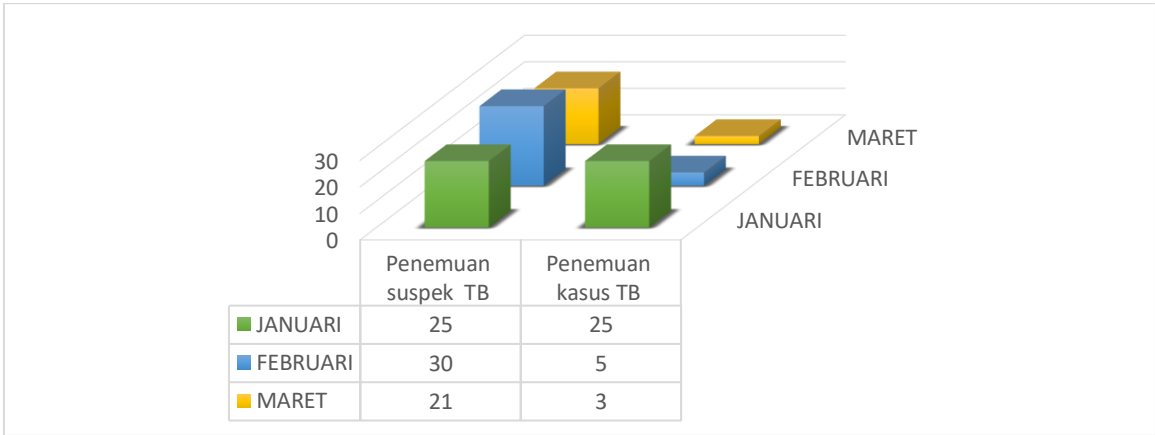
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3. Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	25	30	21
2.	Penemuan kasus TB	25	5	3

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi:

- 1. Pada bulan januari 2024 terdapat 25 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 25 pasien
- 2. Pada bulan februari 2024 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien
- 3. Pada bulan maret 2024 terdapat 21 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 3 pasien

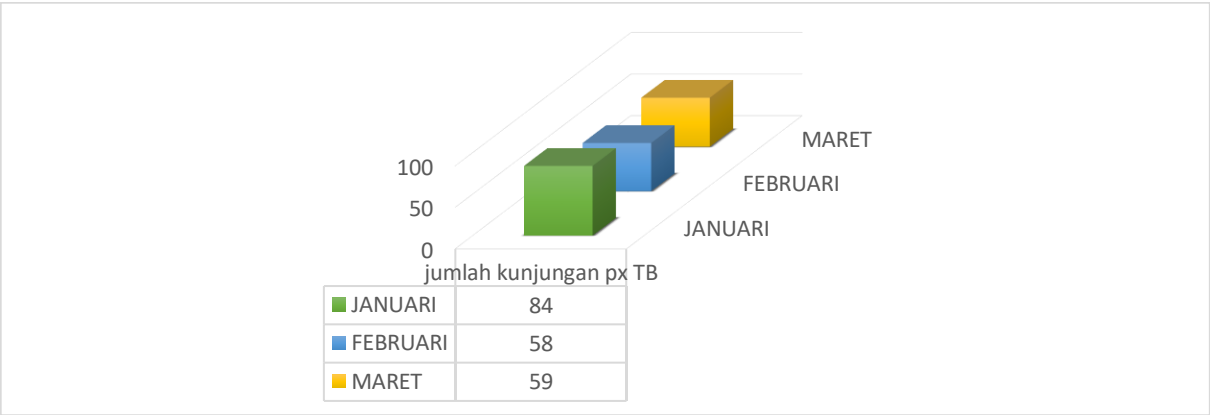
Rencana Dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

4. Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	84	58	59

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Januari 2024 di poli pasien TBC mencapai 84 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Februari 2024 di poli pasien TBC mencapai 58 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Maret 2024 di poli pasien TBC mencapai 59 pasien.

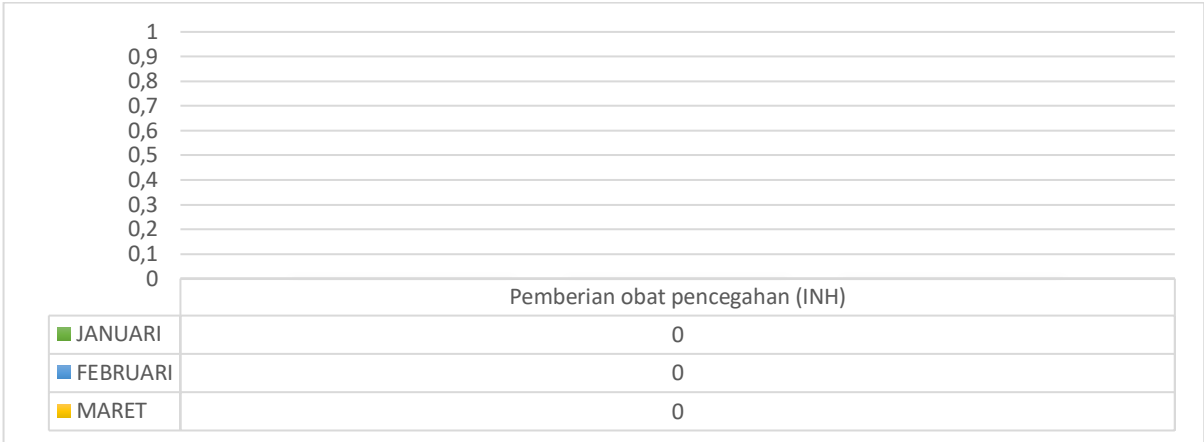
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

5. Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



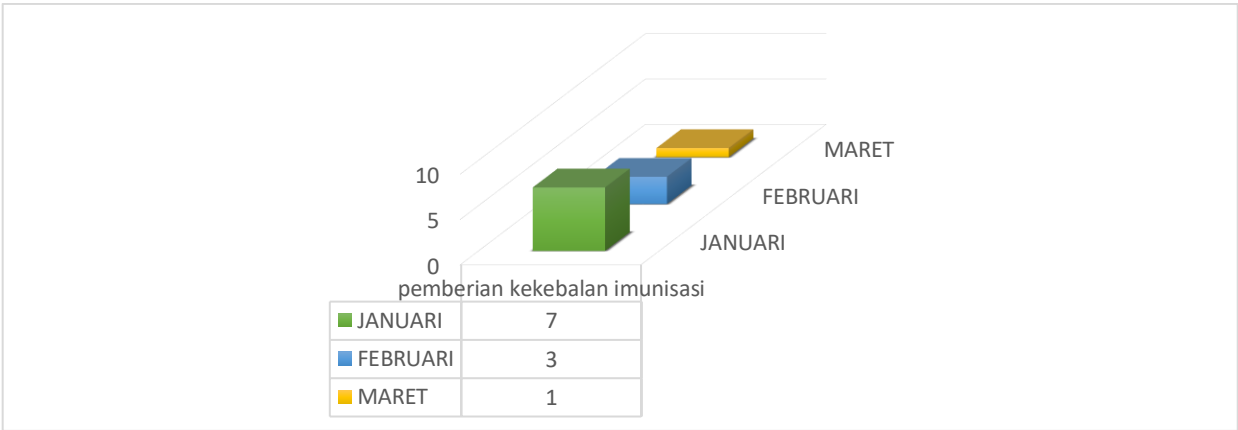
Evaluasi :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

6. Pemberia Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	7	3	1

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



- Evaluasi :**
- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 7 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
 - 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
 - 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret

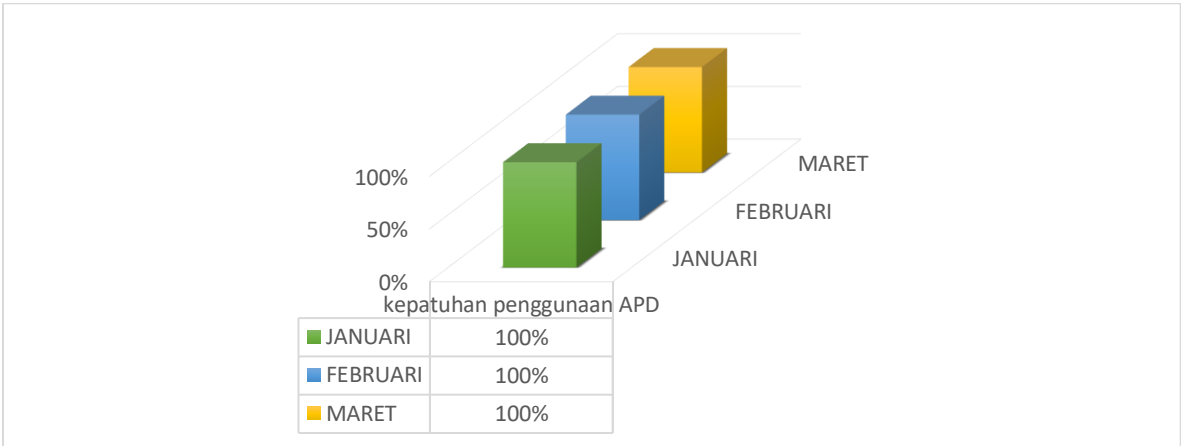
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

7. Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100 %	100 %	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



Evaluasi :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

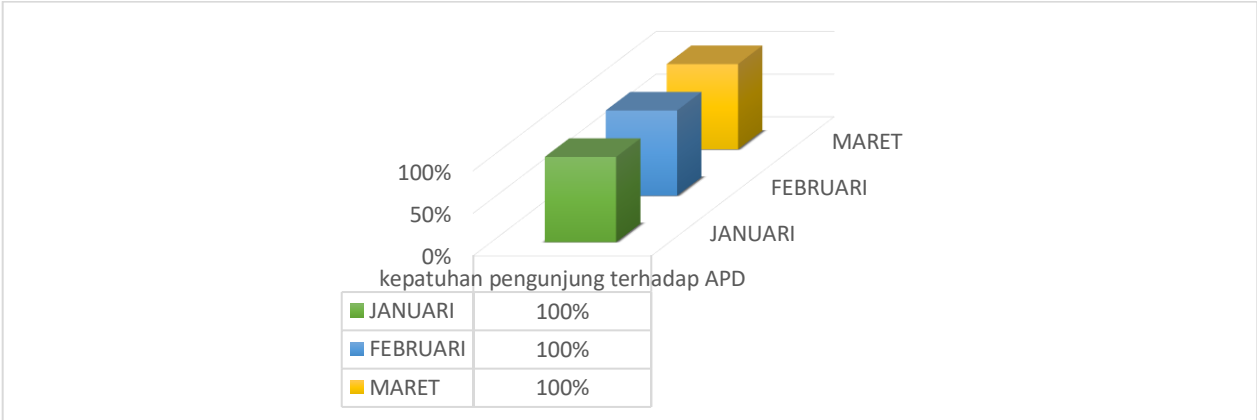
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

8. Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100 %	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



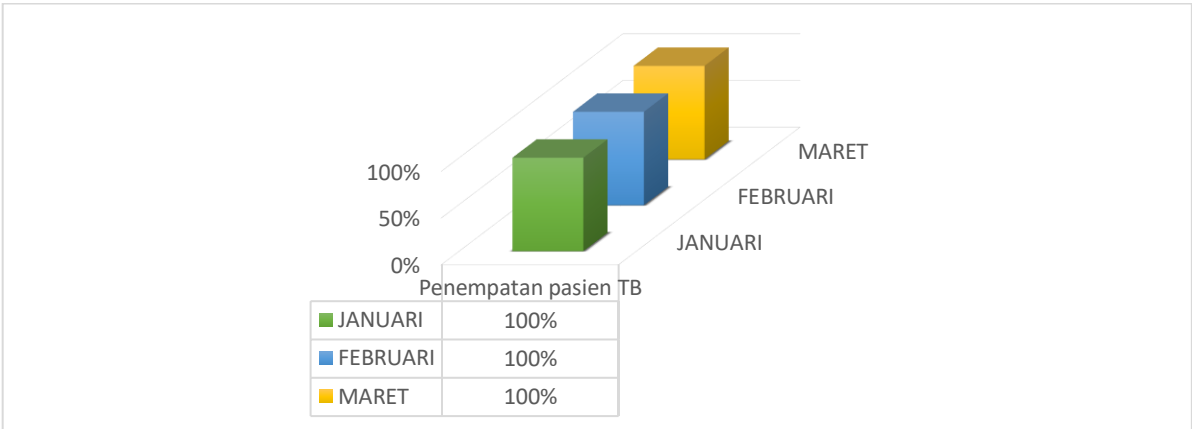
Evaluasi :
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi.

9. Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%	100 %	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan



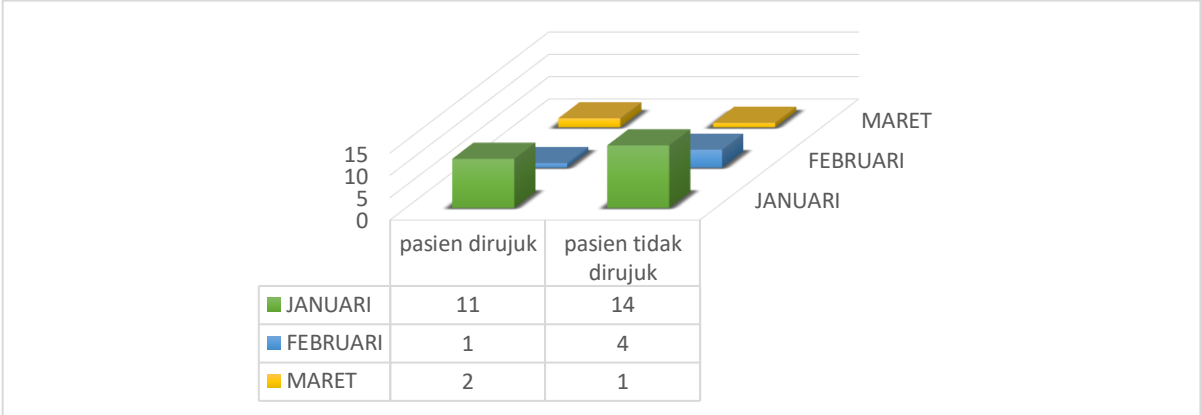
Evaluasi :
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

10. Pasien TB yang Dirujuk

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	11	1	1
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	14	4	2

Grafik Pasien TB yang Dirujuk di Rumah Sakit Prima Husada



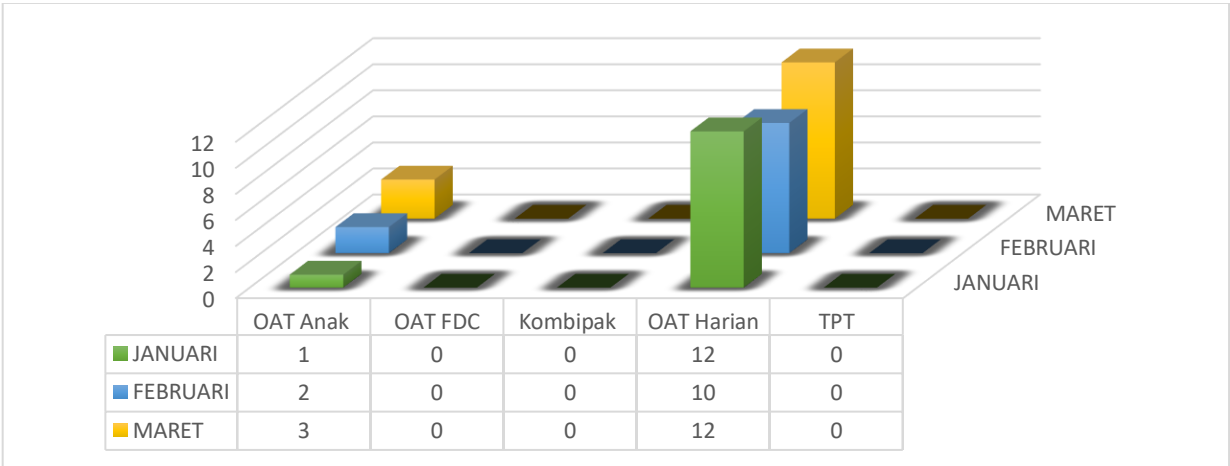
- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan Januari 2024 terdapat 11 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2. Pada bulan Februari 2024 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 3. Pada bulan Maret 2024 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

11. Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1	2	3
2.	OAT Dewasa	0	0	0
3.	Kombipak	0	0	0
4.	OAT Harian	12	10	12
5.	TPT	0	0	0

Grafik Stok Obat TBC di Rumah Sakit Prima Husada



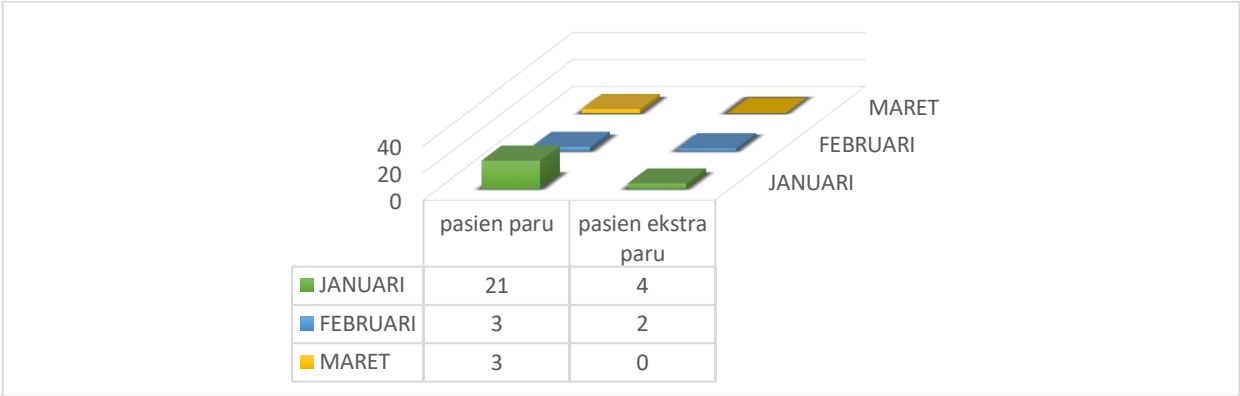
Evaluasi :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

12. Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	21	3	3
2.	Pasien Ekstra paru	4	2	0

Grafik Pasien paru dan Ekstra paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1. Pada bulan januari 2024 terdapat 4 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan february 2024 terdapat 2 pasien ekstra paru
- 3. Pada bulan maret 2024 terdapat 0 pasien ekstra paru

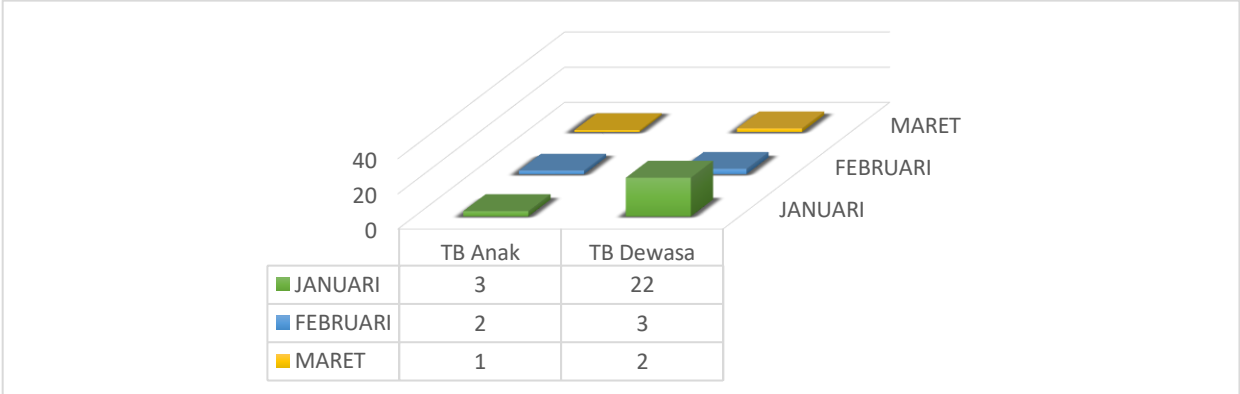
Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

13. Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	3	2	1
2.	Pasien Dewasa	22	3	2

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa Di Rumah Sakit Prima



Evaluasi :

- 1. Pada bulan Januari terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 22 pasien

2. Pada bulan Februari terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien
3. Pada bulan Maret terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

14. Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
		Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

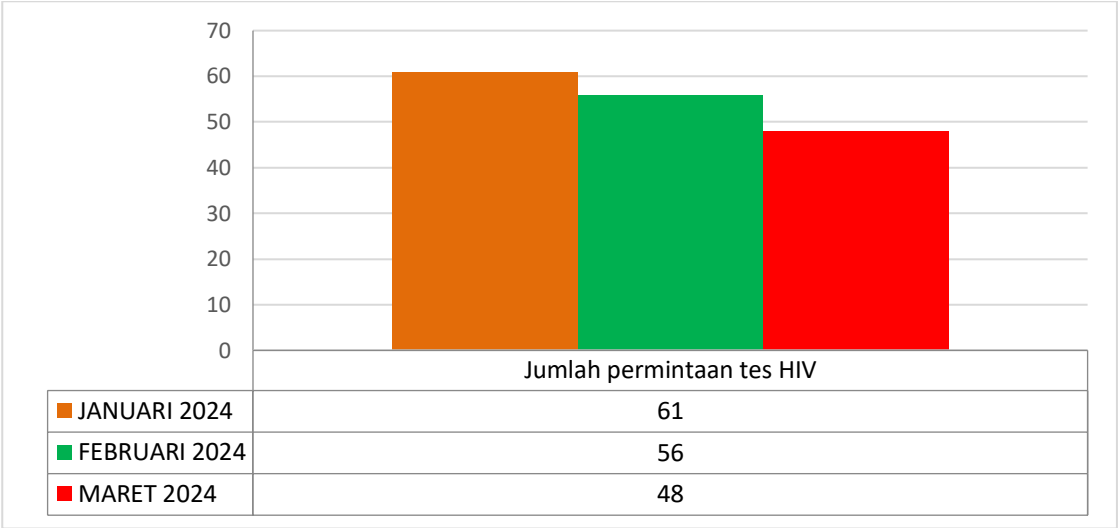
Evaluasi :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang.

- c. HIV
Kinerja dan Produktivitas
1. Jumlah permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Permintaan Test HIV	61	56	48

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



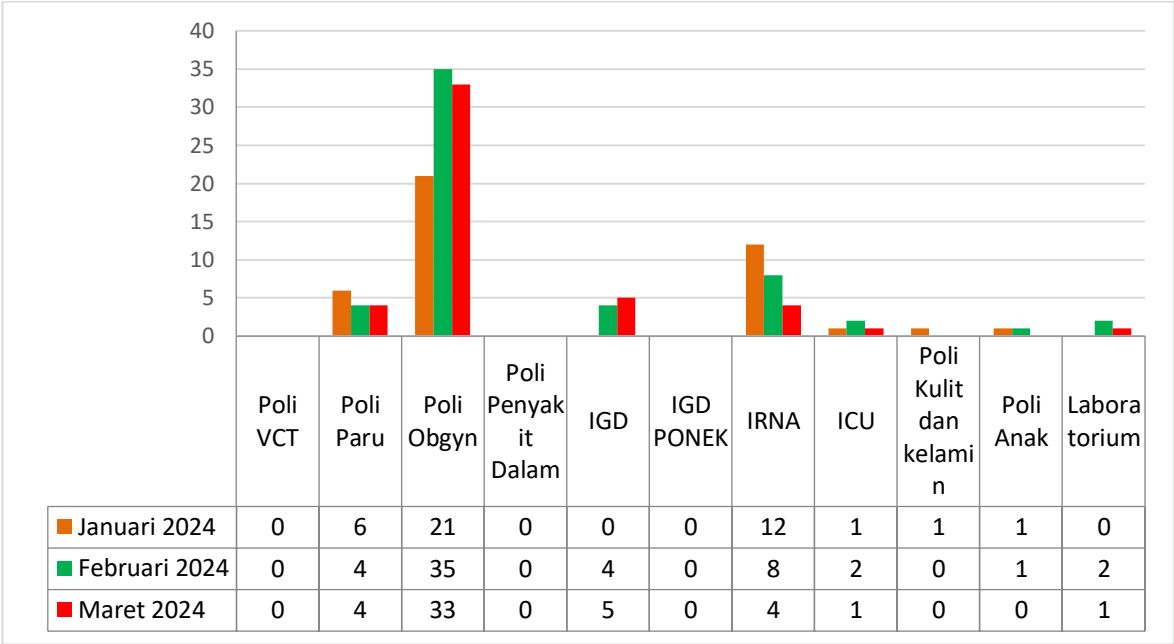
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Maret 2024 menurun menjadi 48 pemeriksaan dibandingkan pada bulan Januari 2024 sebanyak 61 pemeriksaan dan pada bulan februari sebanyak 56 pemeriksaan hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

2. ASAL PERMINTAAN TES HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	6	4	4
3	Poli Obgyn	21	35	33
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	0	4	5
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	12	8	4
8	ICU	1	2	1
9	Poli Kulit dan kelamin	1	0	0
10	Poli Anak	1	1	0
11	Laboratorium	0	2	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



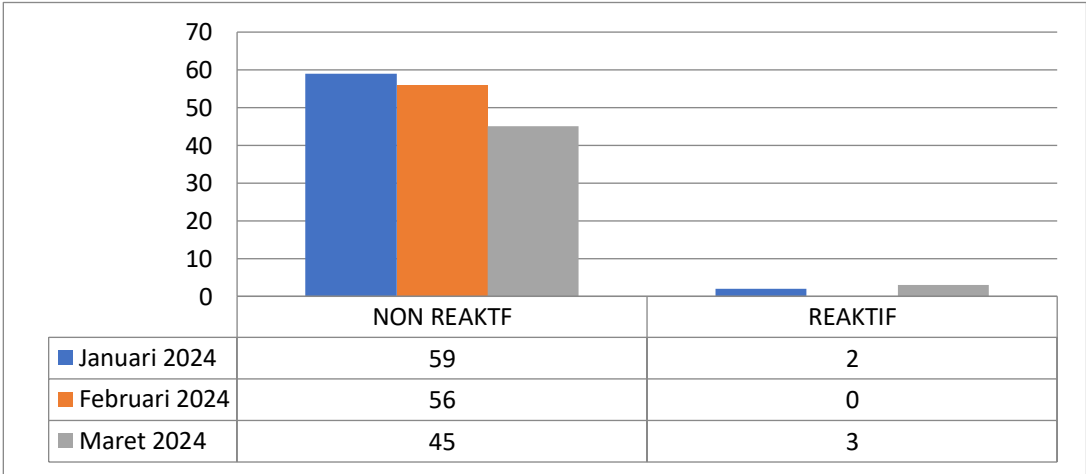
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan Januari 2024 21 pasien pada bulan februari 2024 35 pasien, sedangkan pada bulan maret 2024 sebanyak33 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3. STATUS HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Non Reaktif	59	56	45
2	Reaktif	2	0	3

Grafik Status HIV di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



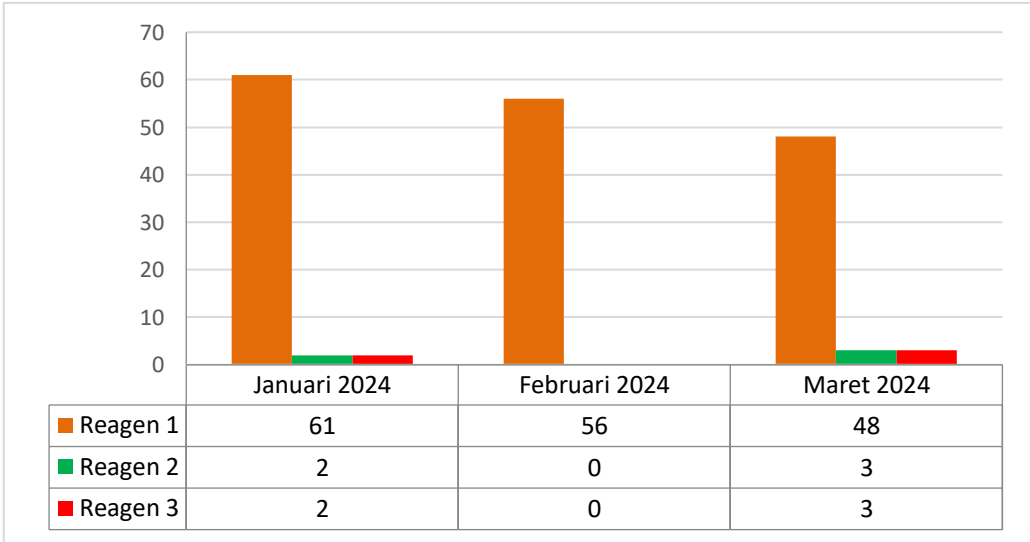
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data status HIV dengan status reaktif pada pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 pasien. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya meningkat dari 0 pasien menjadi 3.

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

4. JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Reagen 1	61	56	48
2	Reagen 2	2	0	3
3	Reagen 3	2	0	3

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



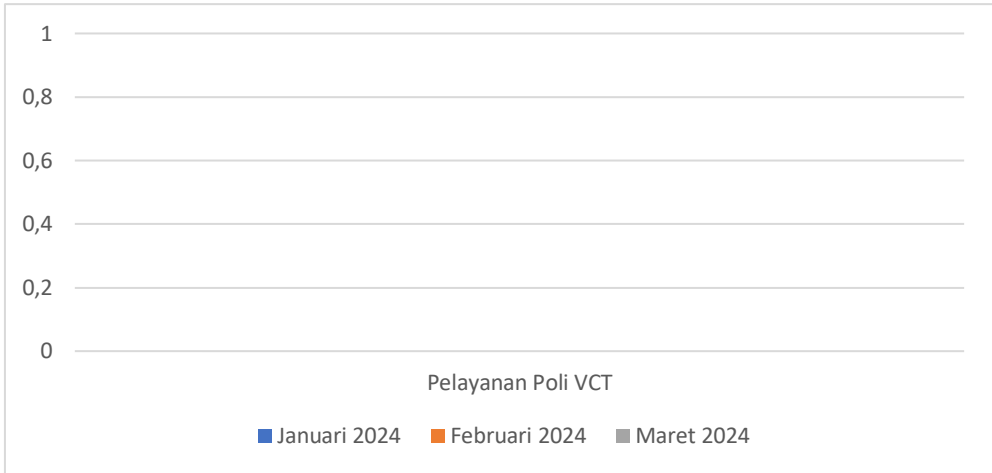
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada Januari 2024 sampai dengan reagen 3 sedangkan pada bulan februari 2024 pemakaian reage hanya ampai reagen 1 saja. Pada bulan maret ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2024 ditemukan 3 pasien dengan hasil HIV Reaktif dari IGD dan rawat jalan.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

5. PELAYANAN VCT (*Voluntary Conseling And Testing*)

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



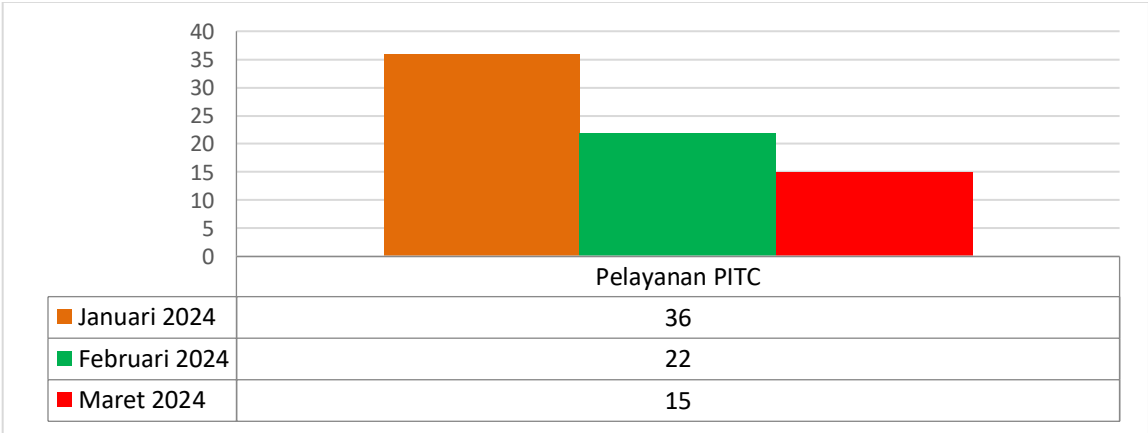
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut :
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

6. PELAYANAN PITC (*Provider Initiated Testing and Counseling*)

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Pelayanan PITC	36	22	15

Grafik Pelayanan PITC di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Januari 2024 sebanyak 36 pasien, pada bulan februari 2024 sebanyak 21 pasien, sedangkan

pada bulan maret 2024 sebanyak 15 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

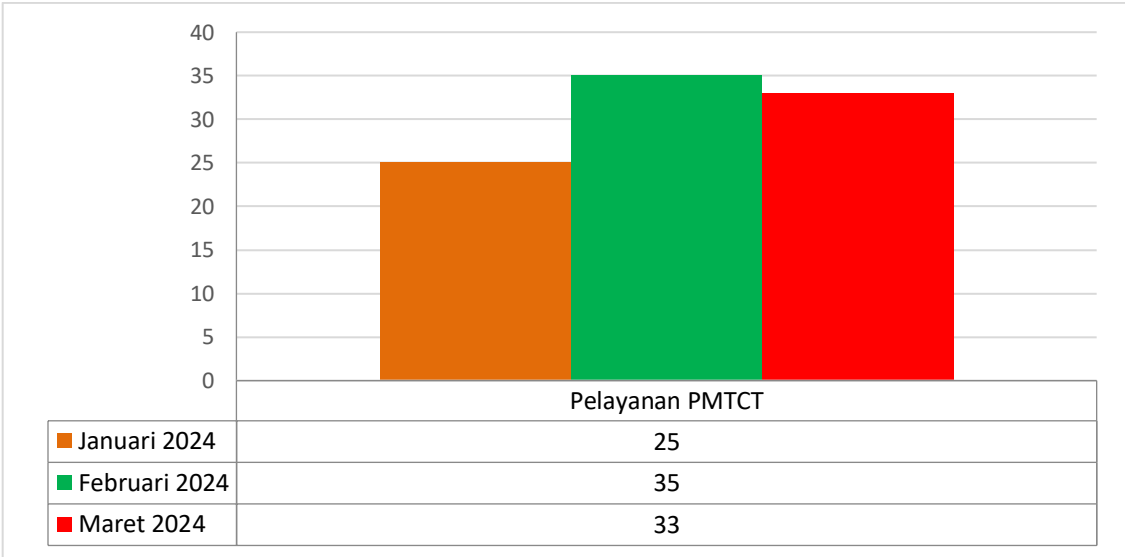
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

7. PELAYANAN PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Pelayanan PMTCT	25	35	33

**Grafik Pelayanan PMTCT di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada buan januari 2024 sebanyak 25 pasien, pada bulan februari meningkat menjadi 34 pasien. Sedangkan pada bulan maret sebnayak 33 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

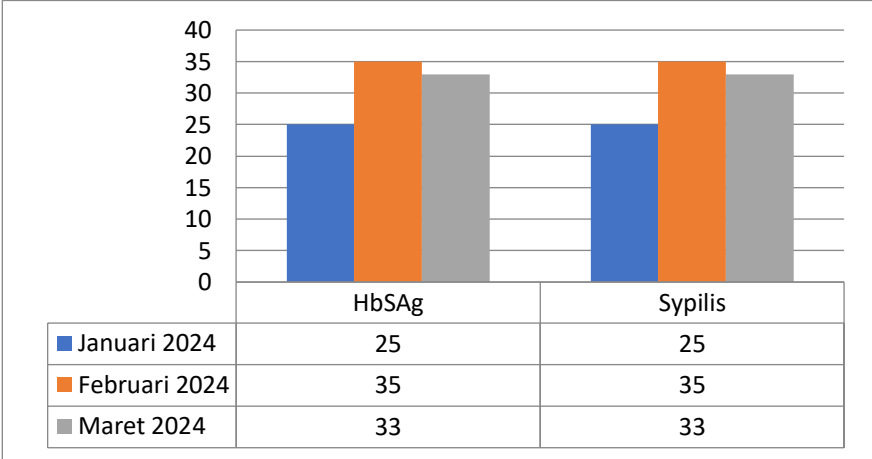
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

8. PELAYANAN PEMERIKSAAN TRIPLE EIMINASI PADA IBU HAMIL

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	HbSAg	25	35	33
2	Sypilis	25	35	33

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



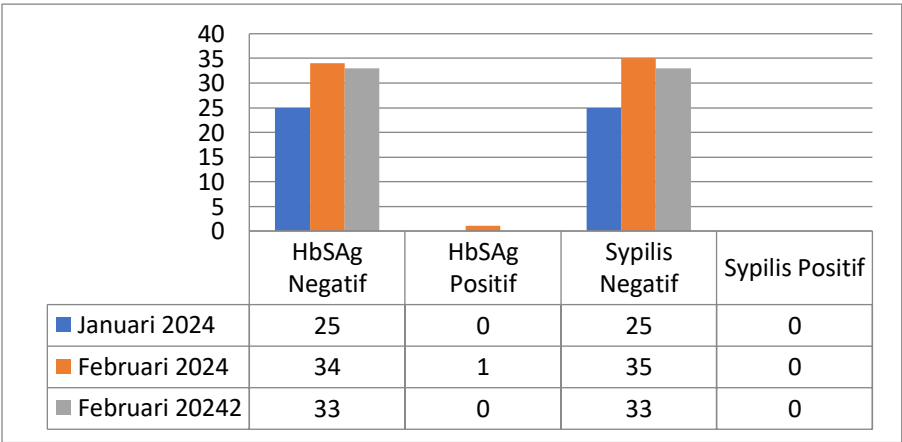
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan januari 2024 sebanyak 25 pasien, pada bulan februari 2024 sebanyak 34 pasien. Sedangkan pada bulan maret 2024 sebanyak 33 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

9. STATUS PELAYANAN PEMERIKSAAN TRIPLE EIMINASI PADA IBU HAMIL

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	HbSAg			
	Negatif	25	34	33
	Positif	0	1	0
2	Sypilis			
	Negatif	25	35	33
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



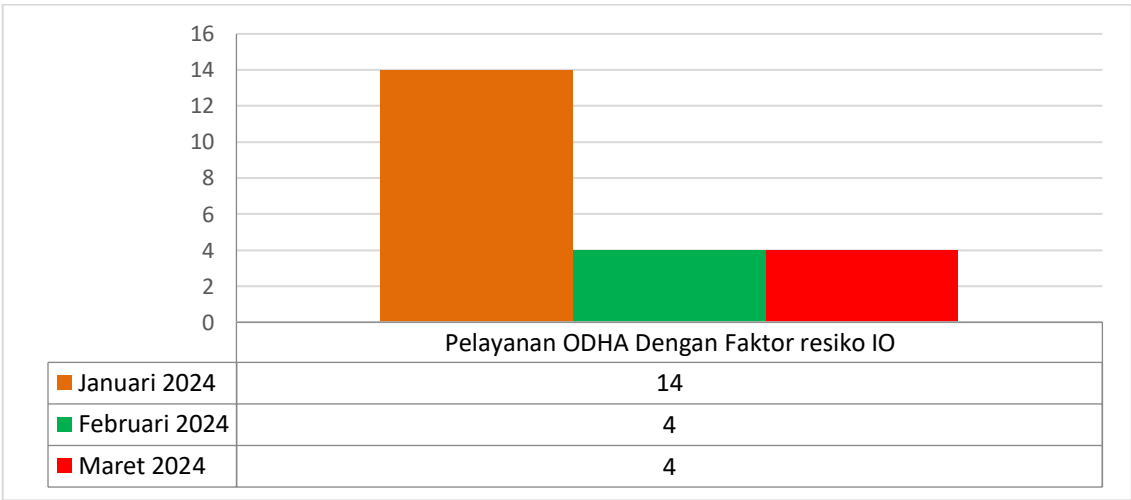
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa ditemukan 1 kasus pasien dengan HbSAg positif pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 pasien. Sedangkan pada pemeriksaan syphilis tidak ada kasus pasien positif. Pada bulan Maret 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien. Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
 2. Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

10. PELAYANAN ODHA DENGAN FAKTOR RESIKO INFEKSI OPORTUNISTIK

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	14	4	4

Grafik Pelayanan Odha Dengan Faktor Resiko IO di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



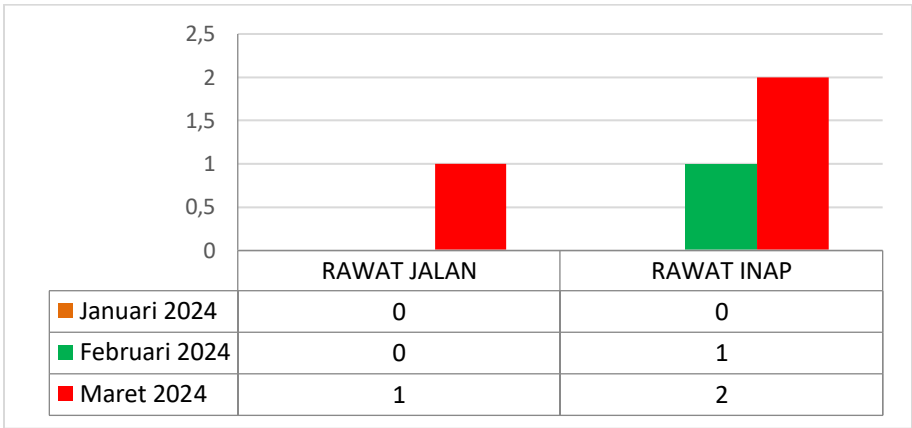
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Januari 2024 terjadi peningkatan yaitu 14 pasien. Sedangkan pada bulan februari 2024 dan maret 2024 terjadi penurunan yaitu sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

11. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	RAWAT JALAN	0	0	1
2	RAWAT INAP	0	1	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Maret 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan februari 2024 terdapat 1 pasien yang dilakukan rujuk eksternal dari rawat inap. Sedangkan pada bulan maret 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk eksternal, yaitu 1 dari rawat jalan dan 2 dari rawat inap. Hal ini dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

d. Stunting dan Wasting

1. Kegiatan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting bulan Januari 2024

NO	KEGIATAN POKOK SDM	PEMENUHAN RENCANA KEGIATAN
1	Kebutuhan SDM	Tidak terdapat perubahan tim stunting dan wasting pada bulan Maret 2024.
2	Orientasi	Tidak ada orientasi pada anggota tim penurunan prevalensi stunting dan wasting pada bulan Maret 2024
3	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan tentang stunting dan wasting dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai stunting dan wasting serta dampak dan faktor penyebab dari stunting dan wasting dimana materi disampaikan oleh ketua tim setiap rapat bulanan. Pendidikan dan pelatihan kepada staff RS Prima Husada tentang stunting masih belum dilaksanakan pada bulan Maret 2024.
4	Evaluasi Kinerja	1. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan berkaitan dengan intervensi spesifik dan pencegahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang stunting dan wasting.

		2. Melakukan beberapa intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit yaitu promosi tentang program 1000 HPK, Suplementasi tablet besi folat, Pemberian PMT pada ibu hamil, promosi konseling IMD dan ASI eksklusif, Pemberian makanan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. 3. ASI Eksklusif a) Edukasi Pemberian ASI eksklusif sudah terlaksana dengan baik, b) Dibentuknya Grup pendukung ASI eksklusif 4. Senam Hamil a) Senam Hamil dilaksanakan 2x dalam 1 bulan secara rutin b) Pemberian edukasi seputar kesehatan atau perawatan - perawatan yang dibutuhkan ibu hamil. 5. Merujuk pasien stunting kepada puskesmas wilayah tempat tinggal balita stunting dan wasting untuk evulasi pertumbuhan dan perkembangan balita melalui whatsapp dan aplikasi eppgbm
--	--	---

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

NO	JENIS	KETERANGAN	KONDISI
RUANGAN			
1.	R. Rawat Jalan Anak	Tersedia	Baik Siap Pakai
2.	Poli Gizi	Tersedia	Baik Siap Pakai
3.	R. rawat inap anak	Tersedia	Baik Siap Pakai

NO	JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	KONDISI
PERALATAN NON MEDIS				
1.	Timbangan Berat dan Panjang Badan Bayi	Tersedia	2	Baik Siap Pakai
2.	Timbangan Berat Badan Balita	Tersedia	3	Baik Siap Pakai
3.	Alat ukur Tinggi Badan Balita	Tersedia	3	Baik Siap Pakai
Media Konseling dan Promosi Kesehatan				
4.	X-Banner	Tersedia	1	Baik Siap Pakai
5.	Leaflet	Tersedia	Tersedia	Baik Siap Pakai

Analisis :

- Secara keseluruhan kondisi sarana prasarana tim stunting dan wasting sudah tersedia dengan lengkap.
- Apabila ada alat yang rusak akan diperbaiki oleh tim IPSRS.
- Pada bulan Februari tidak ada jadwal kalibrasi

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan tim IPSRS untuk melakukan kalibrasi pada alat ukur berat badan dan Panjang badan bayi.

3. Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husda Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Pada Bulan Februari tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis :

- 1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah sakit.

4. Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	0
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1
Pemantaua	Melakukan	Pasien Anak	IRJA	1	1	1

n pertumbuha n (Pelayan an Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak		anak			
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaa n imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberika n PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	2	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	1
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

	mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
--	---	--	--	--	--	--

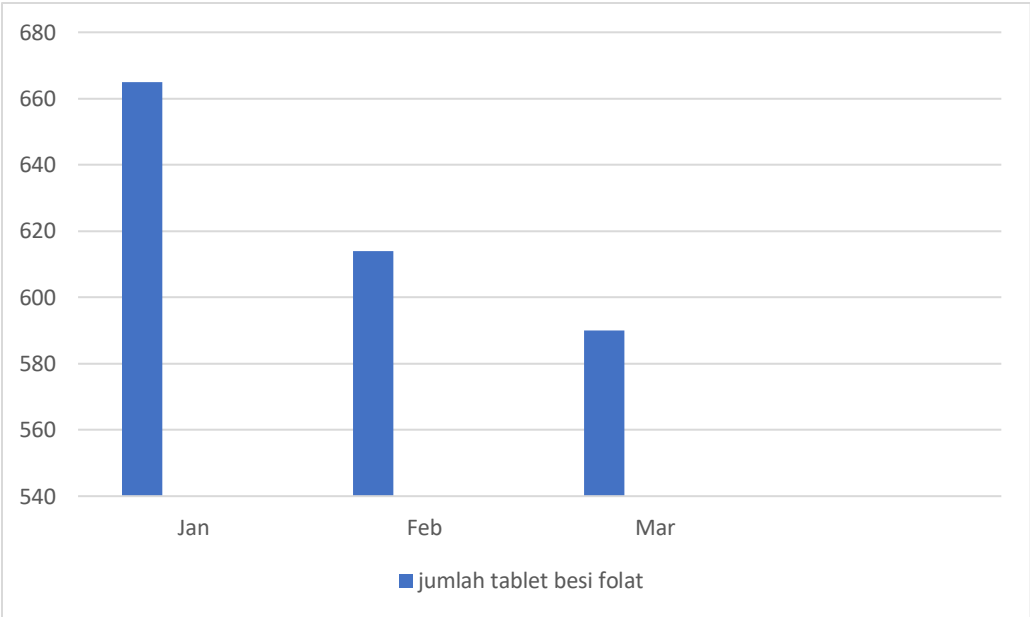
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pada bulan Maret karena terdapat 1 balita stunting dan wasting yang berasal dari puskesmas Ardimulyo. Sehingga Ahli Gizi Puskesmas Ardimulyo mlakukan koordinasi dengan Ahli gizi RSPHM untuk pemberian PKMK, Bubuk Taburia, dan mineral mix terhadap pasien tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

5. Pemberian Tablet Besi Folat bagi ibu hamil

BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	665	614	590

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Maret yaitu 590 ibu hamil.

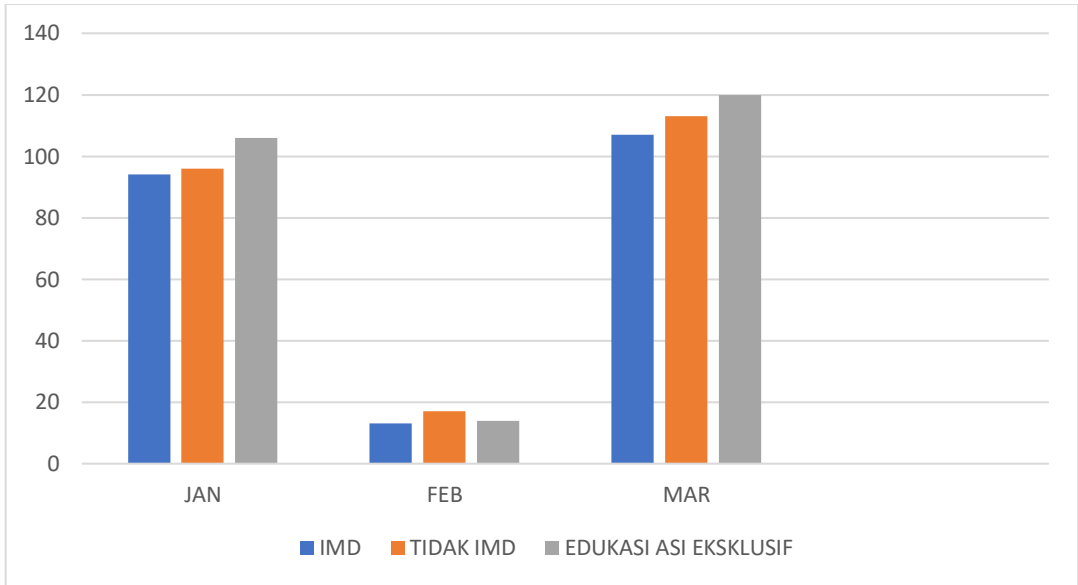
Rencana Tindak Lanjut:

1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

6. Angka capaian Ibu yang melakukan IMD dan Mendapat konseling ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	IMD	94	96	106
2	Tidak IMD	13	17	14
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	107	113	120

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 106 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Januari 2024 dikarenakan terdapat dokter spesialis kandungan baru sehingga juga meningkatkan kunjungan jumlah pasien ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

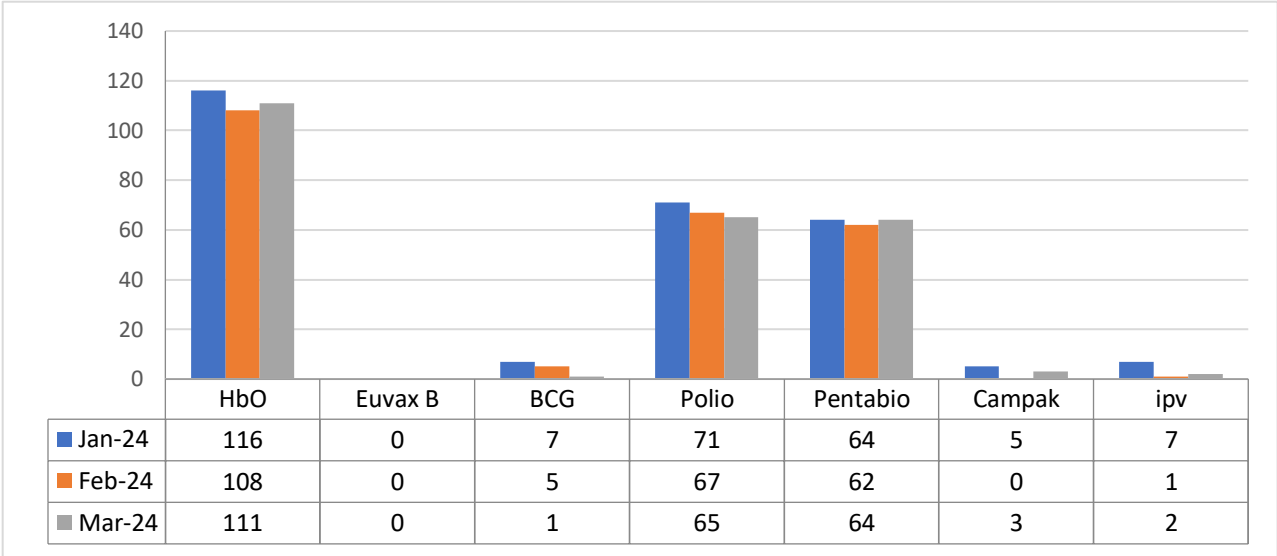
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

7. Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	HbO	116	108	111
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	7	5	1
3	Polio	71	67	65
4	Pentabio	64	62	64
5	Campak	5	0	3
6	IPV	7	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Maret 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan Maret mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 111 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien.
- 5. Pada periode Maret 2024 terdapat 3bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 65 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Februari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 64 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

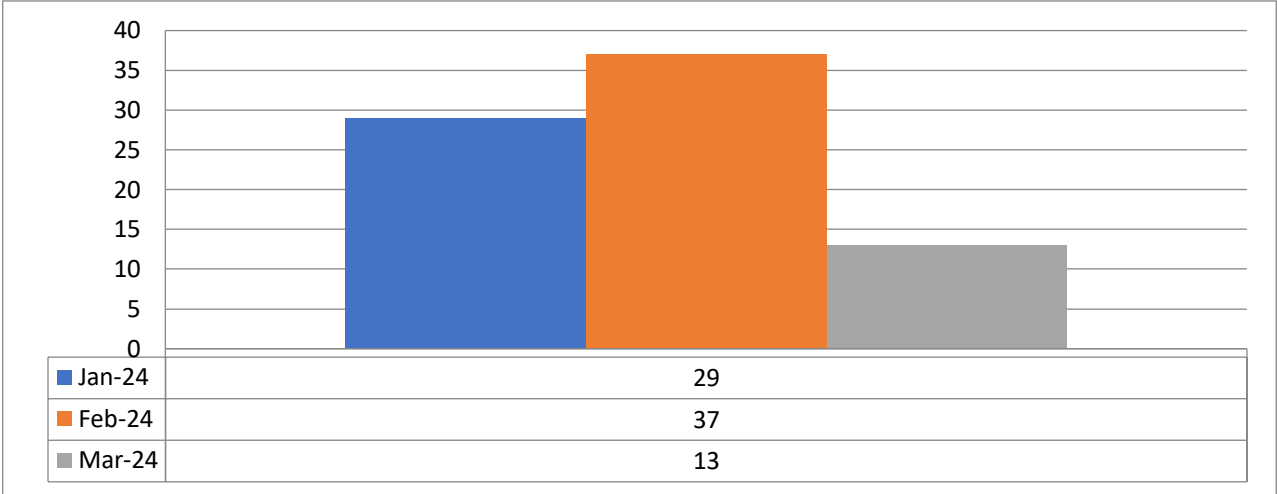
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

8. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	37	36	13
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2024



Analisis :

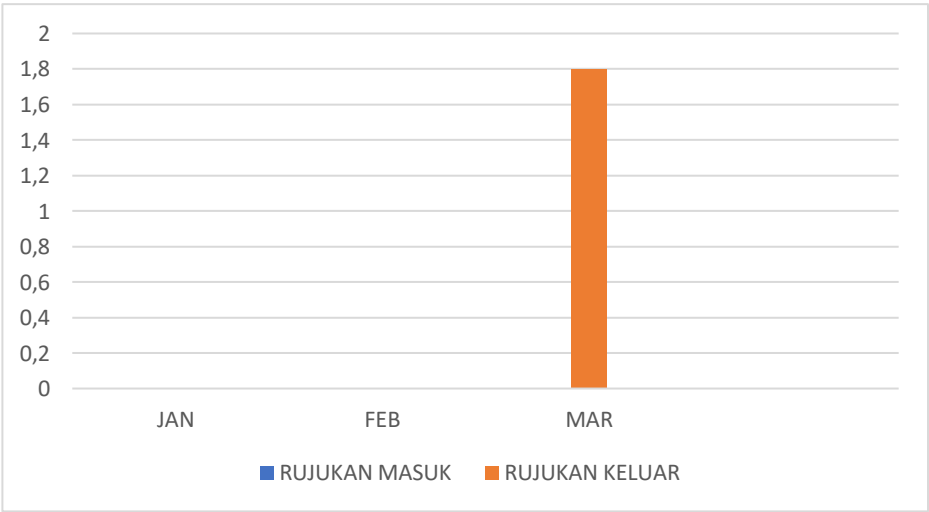
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Peserta Senam Hamil pada bulan Maret mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 peserta dikarenakan senam hamil pada bulan maret hanya dilaksanakan satu kali karena bertepatan dengan bulan puasa. Dengan meningkatkan sarana yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

9. Rumah Sakit Sebagai Pusat Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

NO	RUJUKAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Rujukan Masuk	0	0	0
2.	Rujukan keluar	0	0	1



Analisis :

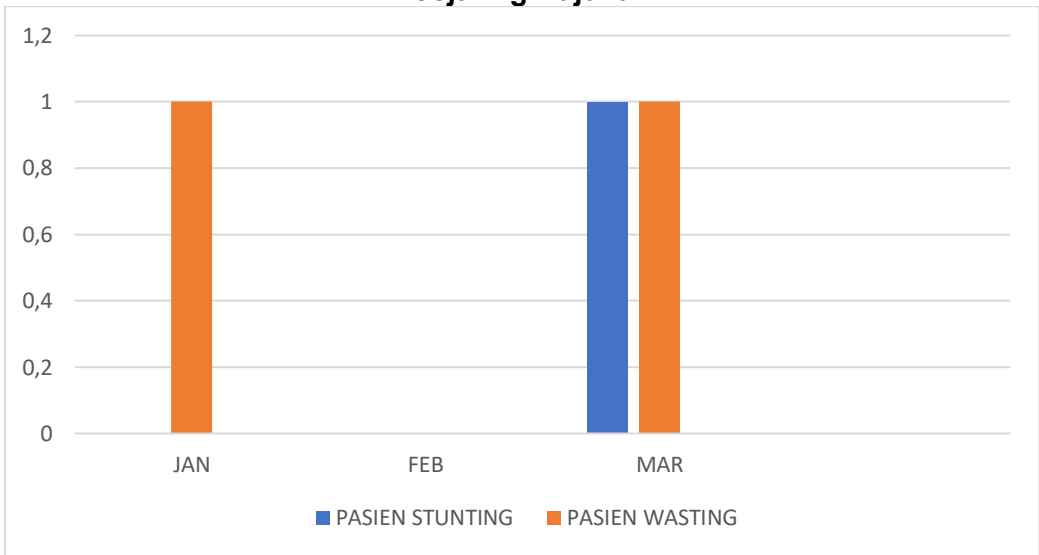
Terdapat 1 pasien dengan kondisi stunting yang dirujuk keluar yaitu ke RS Saiful Anwar dengan diagnose Stunting + Autism.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

10. Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
Jumlah Pasien Stunting	0	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisa :
Terdapat 1 pasien wasting pada bulan Januari. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Pada bulan Maret terdapat 1 pasien stunting yang merupakan pasien yang sudah dalam pantauan puskesmas. Sehingga ahli gizi berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi puskesmas dalam pemberian terapi balita stunting dan wasting.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

11. Program Pemantauan dan Evaluasi

Program pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting adalah dengan cara mengontrol pola makan, berat badan dan tinggi badan pasien pada saat pasien melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Analisa :
Program pemantauan dan evaluasi pasien stunting yang ditemukan saat rawat inap masih belum terlaksana dikarenakan pasien tersebut tidak melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Rencana Tindak Lanjut :

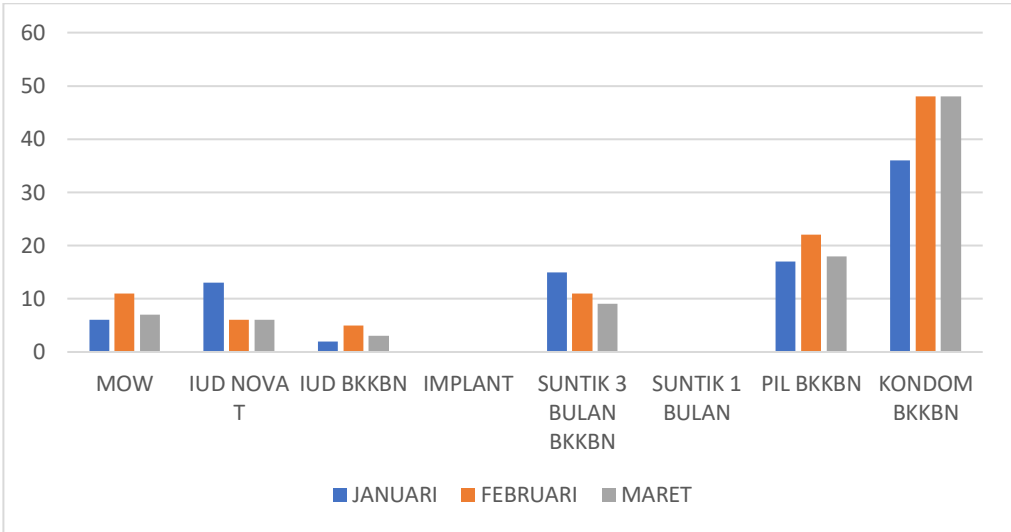
Menghubungi petugas gizi untuk melakukan pemantauan berat badan , tinggi badan, dan pola makan pada balita stunting yang ditemukan tim stunting dan wasting RS Prima Husada Malang.

15. KBRS

1. Angka Capaian Pelayanan KB Per-Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH ALAT KONTRASEPSI		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	MOW	6	11	7
2	IUD NOVA T	13	6	6
3	IUD BKKBN	2	5	3
4	IMPLANT BKKBN	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	15	11	9
6	SUNTIK 1 BULAN BKKBN	0	0	0
7	PIL BKKBN	17	22	18
8	KONDOM BKKBN	36	48	48

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Januari (6) meningkat pada bulan Februari (11) menurun pada Maret (7)
- 2. Peserta IUD Nova T pada Januari (13) dan pada bulan Februari (6) Maret (6) Peserta IUD BKKBN, pada Januari (2) dan meningkat pada bulan februari (5) menurun Maret (3)
- 3. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Januari (15) Februari (11) menurun maret (9)
- 4. Peserta KB pil pada Januari (17) Februari (22) menurun Maret (18)
- 5. Peserta KB Kondom pada bulan Januari (36) Februari (48) maret (48)

Analisis:

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

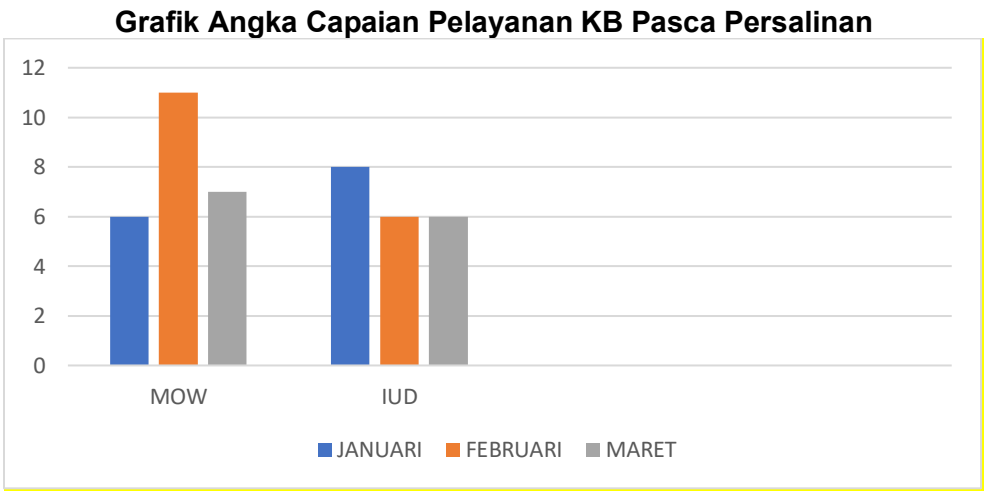
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal

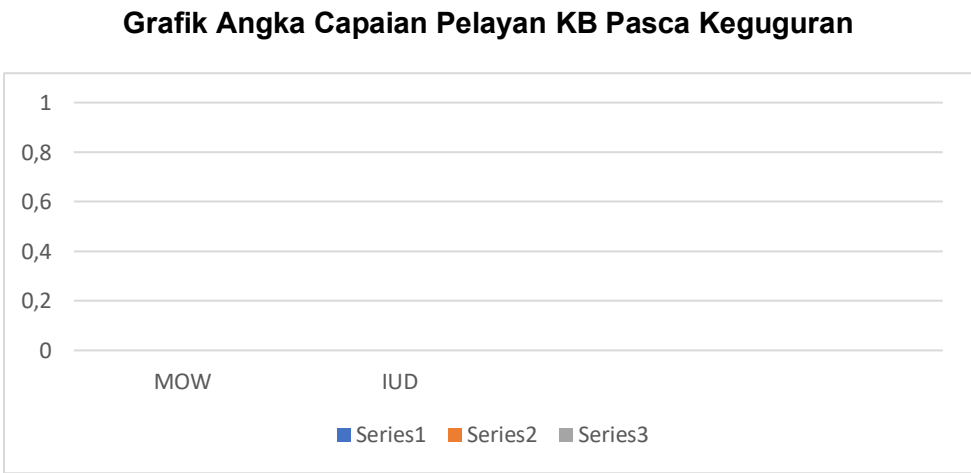
bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

2. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	MOW	6	11	7
2	IUD	8	6	7



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Januari-Februari-Maret meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Januari-Februari-Maret menetap

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena

sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya

2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

BAB IV
DATA UTILITAS UNIT

A. Pelayanan Medis

a. Tabel Data Kamar Operasi

NO	JENIS OPERASI	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	JASA RAHARJA	JUMLAH
1.	Kecil	0	59	0	0	0	0	59
2.	Sedang	0	1	0	0	0	0	1
3.	Besar	14	226	0	0	0	4	244
4.	Khusus	1	44	18	1	0	2	66
	Jumlah	15	330	18	1	0	6	370

1. 10 Tindakan Operatif

NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	SC	72
2	Phaco	49
3	Debridement Necrotomy	30
4	Orif	26
5	Remove Implant	16
6	Excisi & URS + Aff Sten	15
7	Repair & TURP	12
8	URS & ESWL	11
9	Laparatomy	9
10	Close Reduction	8

2. 10 Besar Diagnosa Operatif

NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1	Katarac	49
2	Close fraktur	44
3	Necrotizing	34
4	Hernia	4

5	Tumor	11
6	Appendicitis	3
7	Crush Injury	11
8	Union Fr	16
9	Ganglion	4
10	BPH	12

b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan

1. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Januari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	56	260	34	622	0	0	0	0	7	51	0	2	1032
2	IGD	121	122	93	282	9	13	0	0	10	26	0	2	678
3	Bedah	8	36	48	969	0	5	0	3	1	0	0	0	1070
4	Bedah Plastik	0	2	2	28	0	4	0	0	0	0	0	0	36
5	Fisioterapi	0	27	0	1115	0	18	0	0	0	1	0	0	1161
6	Gigi spesialis	1	6	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	18
7	Gizi	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	Klinik Ibu danBayi	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
9	Jantung	3	19	17	1551	0	0	0	0	1	8	0	2	1601
10	Jiwa	0	8	7	226	0	0	0	0	0	1	0	0	242
11	Kandungan	79	322	52	825	0	0	0	0	1	23	0	2	1304
12	Kulit dan kelamin	13	27	29	366	0	0	0	0	1	9	0	2	447
13	Mata	13	11	56	1224	0	2	0	0	0	2	0	0	1308
14	Orthopedi	9	24	26	484	1	54	0	1	0	0	0	10	609
15	Paru	3	17	15	552	0	0	0	0	0	3	0	0	590
16	Penyakit dalam	18	68	41	2871	0	0	0	0	1	14	0	1	3014

17	Saraf	9	27	28	1225	0	1	0	0	1	2	0	0	1293
18	THT	25	34	42	167	0	0	0	2	1	4	1	7	283
19	Urologi	7	20	31	328	0	0	0	0	1	2	0	0	389
20	Klinik Umum	65	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	83
JUMLAH		434	1074	521	12835	10	97	0	6	28	155	1	34	15195
TOTAL		1508		13356		107		6		183		35		

2. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Februari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	30	170	22	787	0	0	0	0	0	46	0	11	1066
2	IGD	117	120	72	265	14	10	0	0	9	16	0	3	626
3	Bedah	13	34	45	767	0	2	0	2	0	7	0	0	870
4	Bedah Plastik	1	2	0	17	0	1	0	0	0	0	0	1	22
5	Fisioterapi	2	5	0	1024	0	17	2	0	0	1	0	0	1051
6	Gigi spesialis	6	4	0	1	0	0	0		0	6	0	1	18
7	Gigi spesialis periodonti	0	0	3	10	0	0	0	0	1	1	0	2	17
7	Gizi	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
8	Klinik Ibu danBayi	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
9	Jantung	3	7	23	1611	0	0	0	0	1	6	0	0	1651
10	Jiwa	2	8	5	195	0	0	0	0	0	0	0	0	210
11	Kandungan	65	250	47	710	0	1	0	0	7	10	0	4	1094

12	Kulit dan kelamin	12	27	26	240	0	0	0	0	2	19	1	3	330
13	Mata	11	12	23	1051	0	0	0	0	2	7	0	0	1106
14	Orthopedi	8	14	13	451	0	49	0	3	0	4	0	4	546
15	Paru	7	14	0	460	0	0	0	0	0	3	0	0	484
16	Penyakit dalam	16	46	42	2740	0	0	0	0	1	16	0	5	2866
18	Penyakit dalam Sub EMD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	Saraf	2	18	26	1322	0	1	0	0	0	2	0	0	1371
18	THT	13	26	30	126	0	0	0	1	0	12	0	0	208
19	Urologi	10	18	31	337	0	0	0	0	0	2	0	0	398
20	Klinik Umum	15	12	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	37
JUMLAH		341	826	408	12114	14	81	2	6	25	166	1	34	14018
TOTAL		1167		12522		95		8		191		35		

3. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Maret 2024

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		ASURANSI PEMERINTAH ASABRI	TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX LAMA	
1	Anak	47	241	17	840	0	0	0	0	4	54	1	0	0	1204
2	IGD	142	142	108	400	16	20	0	0	2	20	1	6	0	857
3	Bedah	8	9	33	764	0	2	0	5	0	5	0	0	0	826
4	Bedah Plastik	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
5	Fisioterapi	0	6	0	1244	0	23	0	0	0	6	0	0	1	1280
6	Gigi spesialis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3

7	Gigi spesialis periodonti	3	7	2	16	0	0	0	0	0	7	0	4	0	39
7	Gizi	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Klinik Ibu danBayi	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
9	Jantung	4	6	9	1535	0	0	0	0	0	11	0	2	0	1567
10	Jiwa	1	4	5	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
11	Kandungan	73	340	46	725	0	0	0	0	2	18	1	3	0	1208
12	Kulit dan kelamin	22	55	18	316	0	0	0	0	1	24	1	1	0	438
13	Mata	10	21	41	1195	0	2	0	0	0	8	0	1	0	1278
14	Orthopedi	3	19	17	384	0	68	0	11	0	2	0	2	3	509
15	Paru	6	13	7	419	0	0	0	0	0	6	0	1	0	452
16	Penyakit dalam	16	48	31	2730	0	0	0	0	0	14	1	2	0	2842
18	Penyakit dalam Sub EMD	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
17	Saraf	13	14	22	1432	0	0	0	0	2	3	0	1	0	1487
18	THT	18	35	24	129	0	0	0	0	1	9	2	0	0	218
19	Urologi	10	10	28	312	0	0	0	0	0	0	0	2	0	362
20	Klinik Umum	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
JUMLAH		380	1013	409	12655	16	115	0	16	12	188	7	28	4	14843

c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap
1. Kunjungan Rawat Inap Bulan Januari 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	TOTAL
1	VVIP	1	5	0	0	0	0	0	6
2	VIP	4	13	0	0	4	0	0	21
3	Kelas I	1	170	0	1	3	4	0	179
4	Kelas II	18	306	14	0	0	0	0	338
5	Kelas III	33	427	7	0	1	1	0	469
6	ICU	1	16	1	2	0	0	0	20
7	Maternitas	0	37	0	0	0	0	0	37
8	Neonatologi	3	11	0	0	1	0	104	119
9	NICU	0	3	0	0	0	0	0	3
10	Isolasi	0	13	0	0	0	0	0	13
11	ICU T -	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		61	1001	22	3	9	5	104	1205

2. Kunjungan Rawat Inap Bulan Februari 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	PEMERINTAH LAINYA (TASPEN)	TOTAL
1	VVIP	0	10	0	0	0	1	0	0	0	11
2	VIP	6	12	1	0	0	2	0	0	0	21
3	Kelas I	3	151	0	0	1	7	2	0	0	164
4	Kelas II	15	302	15	0	2	2	0	0	0	336
5	Kelas III	26	390	1	0	4	0	1	0	1	423
6	ICU	3	19	0	0	0	0	0	0	0	22
7	Maternitas	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
8	Neonatologi	3	11	0	0	0	2	0	101	0	117
9	NICU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Isolasi	3	14	0	0	0	0	0	0	0	17
11	ICU T -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		59	945	17	0	7	14	3	101	1	1147

3. Kunjungan Rawat Inap Bulan Maret 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	ASURANSI PEMERINTAH	TOTAL
1	VVIP	4	10	0	0	3	0	0	0	17
2	VIP	1	15	0	0	6	1	0	0	23
3	Kelas I	8	177	0	0	5	0	0	0	190
4	Kelas II	14	374	20	6	2	0	0	1	371
5	Kelas III	53	428	1	9	0	2	0	0	493
6	ICU	1	24	0	0	0	0	0	0	25
7	Maternitas	1	39	0	0	0	0	0	0	40
8	Neonatologi	4	15	0	0	1	0	97	0	117
9	NICU	0	5	0	0	0	0	0	0	5
10	Isolasi	1	10	0	0	0	0	0	0	11
11	ICU T -	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		87	1098	21	15	17	3	97	1	1339

d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1. Bulan Januari 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	232	414	17	1	35	-	-
2	Rawat Inap	45	682	7	0	6	-	-
3	Rujuk	4	19	1	1	0	RSUD Soetomo RSSA RSUD Lawang RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu RS Unisma RS PHS	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi, Pro Stroke unit)
4	Meninggal	5	4	0	0	0	-	-

2. Bulan Februari 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	235	363	22	0	28	-	-
2	Rawat Inap	48	747	11	3	8	-	-
3	Rujuk	1	10	1	1	0	RSUD Soetomo RSSA RSUD Lawang RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu RS Unisma RS PHS	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi, Pro Stroke unit)
4	Meninggal	5	4	1	1	0	-	-

3. Bulan Maret 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	274	551	37	0	18	-	-
2	Rawat Inap	69	853	19	4	9	-	-

3	Rujuk	2	10	0	2	0	- RSSA - RSUD Lawang - RSUD Bangil - Persada Hospital - RSUD Karsa Husada Batu - RS Lavalette - RSUD Soetomo	- Pro HD - Pro PCI - Pro Trepanasi - Pro ICU Isolasi
4	Meninggal	11	7	0	0	0	-	-

B. Penunjang Medis
a. Tabel Data Laboratorium

1. Daftar Pemeriksaan Lab yang Dilakukan Di Dalam RSPH Malang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4915	4931	5059
	Hematologi	2406	2377	2799
	Serologi dan Molekuler	568	507	638
	Urine	371	372	371
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	54	43	57
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	1	2	0
	Pemeriksaan Histopatologi	25	34	17
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	11	14	17
4	Narkoba	67	22	20
5	Covid-19	69	73	55

2. Daftar Pemeriksaan Lab Yang Dilakukan Diuar RSPH Malang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	0	3
	Hematologi	0	3	0
	Serologi dan Molekuler	24	3	7
	Urine	-	1	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	-	-	-
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	7	6	14

	Pemeriksaan Histopatologi	66	40	47
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	19	14	5
4	PCR	-	2	2
5	Tumor Marker	20	2	1

Analisis :
 Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :

1. Patologi Anatomi : 61 sampel
2. Patologi Klinik : 10 sampel
3. Bakteriologi/Mikrobiologi : 5 sampel
4. PCR : 2 sampel (kasus covid-19 sudah jarang ditemui)
5. Tumor Marker : 1 sampel

Rencana Tindak Lanjut :
 Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.

b. Tabel Data Radiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1. Radiodiagnostik	Umum	437	20	29
	BPJS Kesehatan	720	666	814
	BPJS TK	40	35	47
	Asuransi Swasta	80	65	55
	Jasaraharja	100	90	75
Total		1377	876	1020
2. Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	437	20	29
	BPJS Kesehatan	720	666	814
	BPJS TK	40	35	47
	Asuransi Swasta	80	65	55
	Jasaraharja	100	90	75
Total		1377	876	1020
3. Foto Dengan Rol Film	Umum	437	20	29
	BPJS Kesehatan	720	666	814
	BPJS TK	40	35	47
	Asuransi Swasta	80	65	55
	Jasa Raharja	100	90	75
Total		1377	876	1020
4. CT Scan tanpa kontras	Umum	-	29	15
	BPJS Kesehatan	11	201	164
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	-	-	-
Total		11	230	179
5. CT Scan dengan kontras	Umum	-	-	1
	BPJS Kesehatan	-	7	6
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-

	Jasa Raharja	-	-	-
Total		0	7	7
6. USG tanpa kontras	Umum	44	35	18
	BPJS Kesehatan	150	198	187
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasa Raharja	-	-	-
Total		194	233	205

Analisis :

1. Pelayan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.
 Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak yaitu:
 - a) Rontgen : 3060 pasien
 - b) USG : 205 pasien
 - c) CT Scan : 186 pasien
2. Pada bulan Maret produktivitas radiologi pada pemeriksaan radiodiagnostik sejumlah 1020 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi. Mengalami peningkatan di bandingkan pada bulan Februari, masih belum dikatakan stabil karena data fluktuatif.
3. Pada bulan Maret Alat Ct-Scan mengalami trouble, unit yang membutuhkan pelayanan CT Scan melakukan pemeriksaan di RS rujukan selama 3 hari sehingga utilitas menurun.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan ATEM untuk melakukan maintenance setiap minggu.
2. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan jika sudah diperbaiki untuk menaikkan pendapatan.
3. Membuat SPO pelayanan pemeriksaan radiologi dari rujukan RS luar.

c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

UNIT DAN PENJAMIN	JANUARI 2024		FEBRUARI 2024		MARET 2024	
	JENIS RESEP		JENIS RESEP		JENIS RESEP	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1. Rawat Inap						
Umum	37	677	28	316	32	730
BPJS Kesehatan	191	6610	259	7145	214	7463
BPJS TK	0	0	0	10	0	0
Asuransi Swasta	0	70	0	41	2	52
Jasaraharja	0	70	0	41	2	52
Total	228	7427	287	7553	250	8297
2. Poliklinik						
Umum	221	450	172	619	209	421
BPJS Kesehatan	1913	8582	1735	8011	1784	7865

BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	5	0	4	0	16
Jasaraharja	0	5	0	4	0	16
Total	2134	9042	1907	8638	1993	8318
3. Kamar Operasi						
Umum	0	13	0	6	0	19
BPJS Kesehatan	0	398	0	384	0	384
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	9	0	10	0	14
Jasaraharja	0	9	0	10	0	14
Total	0	429	0	410	0	431
4. IGD						
Umum	31	346	46	290	59	341
BPJS Kesehatan	85	1337	81	1288	161	1461
BPJS TK	0	0	0	1	0	0
Asuransi Swasta	0	16	0	11	0	23
Jasaraharja	0	16	0	11	0	23
Total	116	1715	127	1601	220	1848
Total Resep	2478	18613	2321	18202	2463	18894

Analisis :

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah resep masuk di Bulan Maret mengalami peningkatan dari 3 bulan terakhir.

Perbedaan jumlah resep dapat disebabkan dari berbagai hal seperti kunjungan pasien, jumlah dokter yang tidak praktek atau izin atau cuti, jumlah tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut.

Jumlah resep pasien BPJS TK di Bulan Maret 2024 tidak terdeteksi karena tarikan data menjadi satu dengan resep pasien Asuransi Swasta.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan minat pasien untuk melakukan kunjungan ulang ke RS agar jumlah kunjungan dan jumlah resep meningkat setiap bulannya
2. Mempromosikan layanan pengantaran obat melalui media social, banner dan pengumuman melalui mic dengan harga terjangkau untuk menurunkan jumlah antrian pasien di Ruang Tunggu Farmasi.
3. Koordinasi dengan Programmer untuk memisahkan kategori per cara bayar sesuai penjamin pasien

d. Tabel Data Laundry

NO	UNIT	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
Linen				
1	VVIP	1kg	0kg	0 kg
2	VIP	1kg	3kg	1 kg
3	Kelas I	81kg	117 kg	88 kg

4	Kelas 2	507kg	486 kg	346 kg
5	Kelas 3	1461kg	1451 kg	1500 kg
6	Maternitas kelas 1	33kg	30 kg	20 kg
7	Maternitas kelas 2	245kg	312 kg	225 kg
8	Maternitas kelas 3	669kg	654 kg	765 kg
9	ICU	205kg	212 kg	176 kg
10	Kamar Operasi	2230kg	2021 kg	2434 kg
11	Poliklinik	27kg	34 kg	28 kg
12	IGD	75kg	65 kg	75 kg
13	Laborat	4kg	5 kg	4 kg
14	Radioogi	3kg	3 kg	3 kg
15	Dapur/Gizi	3kg	4 kg	3 kg
16	CSSD	5kg	4 kg	4 kg
Total Linen Tercuci		5550kg	5401kg	5672 kg
Bahan Habis Pakai				
1	Alkali	1	1	1
2	Emulsi	1	1	1
3	Oxy	1	1	1
4	Netral	1	1	1
5	Softener	26	23	22
6	Rapika	41	24	23
7	Detergen	16	-	-
8	Pemutih	19	17	16
9	LPG	18	20	16
10	Liquid matic	-	8	8
Total		124	96	89

Analisis :

1. Dari table diatas diketahui bahwa linen kotor meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien.
2. Linen kotor paling banyak dari Unit IRNA dengan kelas perawatan kelas 3, dimana total ruangan kelas 3 adalah 49TT dari 140TT.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan pengajuan mesin cuci industry supaya kapasitas lebih besar dan efisiensi waktu.

e. **Tabel Data CSSD**

NO	HAL	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024
1	Chemical Alcalide	1500ML	1500ml	1400ml
2	Chemical Alkazyme	21pcs	37pcs	34pcs
3	Kassa Masuk	54roll	54roll	38roll
4	Kassa Keluar	1899pouches	2130pouches	1983pouches
5	BHP Pouces	5.5roll	5roll	5roll
6	Indikator Adhesive	1roll	1roll	1roll
7	Indikator Strip Steam	2box	2roll	2roll
Alat yang disetor				
8	Unit IKO	391set	376set	367 set
9	IRJA	101set	87set	75 set
10	IRNA 5C	7set	4set	3 set

11	IRNA 3A dan 4A	5 set	4set	4 set
12	IRNA 3C ANAK	2 set	0set	3 set
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	8 set	4set	3 set
14	IRNA 2C VIP	4set	3set	3 set
15	IRNA ICU	10set	11set	12 set
16	IGD	126set	149set	156 set
17	MATERNITAS	203set	179set	243 set
18	PERINA	108set	112set	139 set
Jumlah		965set	929set	1008set

Analisis

Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terkahir yaitu sebanyak 1.134 set, diikuti dari Unit Maternitas 625 set dan IGD 431 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

Rencana Tindak Lanjut

- Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor.
- Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

f. Tabel Data Instalasi Gizi

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIET			PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	MARET 2024	
1	Diabetes Melitus	298	288	285	99
2	Rendah Garam	389	408	528	129
3	Jantung	176	223	190	85
4	Rendah serat	354	352	373	106
5	TKTP	1158	1079	1424	132
6	Makanan biasa	34	24	16	67
7	Makanan Lunak	17	20	10	50
8	Rendah Lemak	165	160	239	149
9	Rendah Protein	102	87	79	91
10	Bubur Halus	133	92	171	186
11	Cair	60	72	71	99
12	Rendah Purin	79	102	97	95
13	Tinggi Protein	45	24	23	96
14	Blender	23	17	21	124
15	Tinggi serat	0	3	0	0
16	Tinggi Kalsium	65	123	131	107
17	Rendah Kalsium	24	42	30	71
18	Rendah Sisa	0	9	10	111
Total		3122	3125	3698	118

Grafik Jumlah Pesanan Diet di Unit Gizi Pada Bulan Maret 2024



Analisis :
Jumlah pasien yang rawat inap meningkat sehingga mempengaruhi jumlah pemberian diet pasien di rawat inap. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.

g. Instalasi Rekam Medis

Tabel Daftar 10 besar penyakit di Rawat Jalan Pada Bulan Maret 2024

NO	CODE ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11	DM Type 2 / Noninsulin-dependent diabetes mellitus	935
2	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	550
3	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	515
4	M17	Gonarthrosis [arthrosis of knee]	333
5	I25	Chronic ischemic heart disease	329
6	M54.5	LBP (Low Back Pain)	328
7	J03	Acute tonsillitis (1003)	327
8	H53	Visual disturbances	276
9	T14	Injury of unspecified body region	270
10	I50.0	CHF / Congestive heart failure	240

Analisis :
Dari data di atas terbanyak adalah penyakit diabetes melitus dengan jumlah bulan Maret 2024 935 pasien dari data di atas penderita DM mengalami kenaikan,pasien di bulan februari 2024 pasien penderita DM mencapai di angka 898 an.

- Rencana Tindak Lanjut :
- 1. Menyediakan data pasien dan no telfon untuk tindak lanjut ke bagian manajemen, data tersebut bisa dilakukan untuk tindak lanjut ke bagian manajemen seperti melakukan :
 - 6) Diadakan program senam kaki untuk penderita DM.
 - 7) Membagikan leaflet tentang senam kaki DM
 - 2. Berikut link data pasien yang sakit Diabetes Melitus
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iR8zsxrFcoSHnqD25HwDmUUMbPyDbbe6/edit#gid=827051296>
 - 3. Hasil dari follow up humas dan marketing :
 - a) Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatric
 - b) Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan
 - c) Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap

Tabel Daftar 10 besar penyakit di Rawat Inap Pada Bulan Maret 2024

DAFTAR 10 BESAR PENYAKIT			
NO	KODE	DIAGNOSA	JUMLAH
1	P24.9	NEONATUS CUKUP BULAN	91
2	A90	DENGUE FEVER	79
3	K21.9	GASTRO ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	50
4	R50.9	FEBRIS	49
5	E86	VOLUME DEPLETION	42
6	J18.9	PNEUMONIA	35
7	063.0	GRAVIDA + KALA 1 FASE AKTIF	33
8	I63.9	CEREBRO VASKULER ACCIDENT INFARK	30
9	E11.9	DIABETES MELLITUS HYPERGLIKEMIA	23
10	A01.0	TYPHOID FEVER	23

Analisis :
Dari data di atas menunjukkan 91 NEONATUS CUKUP BULAN,dan yang ke 2 adalah DF 79.

Masalah :
Jumlah penyakit DF ada peningkatan di bulan ini dan ada warning dari dinas kesehatan agar melaporkan real time untuk DF karena KLB.

Rencana Tindak Lanjut :
Menindaklanjuti pelaporan DF dan di bantu oleh tim perawat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Dalam struktur organisasi RS Prima Husada Jabatan Struktural di Tingkat direksi sudah terpenuhi, seperti jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kebutuhan staf di Unit Humas dan Marketing juga sudah terpenuhi dan sudah mulai menjalankan tugasnya dengan mendatangi rekanan baik Perusahaan maupun Faskes Tingkat 1 untuk menjalin Kerjasama guna meningkatkan jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang.

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis mengalami perbaikan dari bulan-bulan sebelumnya setelah dilakukan penertiban dengan mengeluarkan surat pernyataan dari DPJP terkait kepatuhan jam visite. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja karena beberapa karyawan yang dirumahkan membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta menterbitkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalinkan lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan bulan Maret 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Maret 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 09 April 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah